



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PERAWATAN KEHAMILAN DAN PERSALINAN

Rigoan Malawat • Yuyun Setyorini • Yuanita Ani Susilowati
Apri Nur Wulandari • Ina Debora Ratu Ludji

Editor: Agustina A. Seran



BUNGA RAMPAI

PERAWATAN KEHAMILAN DAN PERSALINAN

Penulis:

Rigoan Malawat. S.Kep., M.Kes.

Yuyun Setyorini, S.Kp., Ners., M.Kep.

Yuanita Ani Susilowati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.

Apri Nur Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.

Editor:

Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH.



Bunga Rampai Perawatan Kehamilan dan Persalinan

Penulis: Rigoan Malawat. S.Kep., M.Kes.

Yuyun Setyorini, S.Kp., Ners., M.Kep.

Yuanita Ani Susilowati, M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.

Apri Nur Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.

Editor: Dr. Agustina A. Seran, S.Si.T., MPH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Rahman Arifin

ISBN: 978-634-7219-54-1

Cetakan Pertama: Mei 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Kehamilan dan persalinan merupakan proses fisiologis yang sarat makna dan memerlukan perhatian serius dari berbagai aspek, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Buku Bunga Rampai Perawatan Kehamilan dan Persalinan ini disusun untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan maternitas melalui penyajian topik-topik penting yang mendukung pemahaman menyeluruh tentang perawatan selama masa kehamilan hingga pascapersalinan.

Buku ini terdiri dari lima chapter yang membahas beragam isu penting, mulai dari urgensi pemeriksaan kehamilan rutin, asuhan dan manajemen nyeri saat persalinan normal, perawatan bayi prematur, hingga perhatian khusus terhadap kesehatan mental ibu serta dukungan psikososial yang dibutuhkan selama masa perinatal. Setiap penulis menyampaikan materi berdasarkan kajian ilmiah dan pengalaman profesionalnya di bidang kebidanan dan keperawatan maternitas, sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan di lapangan sekaligus menjadi sumber pembelajaran yang aplikatif.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontributor yang telah berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi kesehatan, dan semua pihak yang peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Umpan balik dan saran dari para pembaca sangat kami nantikan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
CHAPTER 1 PENTINGNYA PEMERIKSAAN KEHAMILAN RUTIN	1
Rigoan Malawat. S.Kep., M. Kes.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Pelayanan dalam Pemeriksaan Kehamilan.....	3
C. Kepatuhan dalam Pemeriksaan ANC.....	8
D. Simpulan	10
E. Referensi	11
F. Glosarium	13
CHAPTER 2 PERAWATAN PERSALINAN NORMAL DAN TEKNIK MANAJEMEN RASA SAKIT	15
Yuyun Setyorini, S.Kp., Ners., M.Kep.....	15
A. Pendahuluan	15
B. Konsep Dasar Persalinan Normal	16
C. Asuhan Keperawatan pada Persalinan Normal.....	20
D. Manajemen Rasa Sakit pada Persalinan Normal	23
E. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi pada Persalinan Normal.....	26
F. Pendidikan dan Promosi Kesehatan dalam Perawatan Persalinan Norma.....	29
G. Simpulan	31
H. Referensi	32
CHAPTER 3 KELAHIRAN PREMATUR: IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN DAN PERAWATAN	33
Yuanita Ani Susilowati, M.Kep., Ns. Sp.Kep.Mat.	33
A. Pendahuluan	33
B. Kelahiran Bayi Prematur	33
C. Identifikasi Penyebab Kelahiran Prematur	35
D. Pencegahan Kelahiran Prematur:.....	36
E. Perawatan Bayi Prematur	37
F. Simpulan	45
G. Referensi	46
H. Glosarium	48

CHAPTER 4 PERSALINAN DAN KESEHATAN MENTAL IBU: MENINGKATKAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	49
Apri Nur Wulandari, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	49
A. Pendahuluan	49
B. Persalinan dan Kesehatan Mental Ibu	50
C. Pencegahan Masalah Kesehatan Mental Ibu	52
D. Kebijakan Pemerintah terkait Kesehatan Mental Ibu	53
E. Dukungan Psikososial untuk Kesehatan Mental Ibu pada Masa Perinatal	55
F. Simpulan	59
G. Referensi	60
H. Glosarium	68
 CHAPTER 5 PERAWATAN PERSALINAN NORMAL DAN TEKNIK MANAJEMEN RASA NYERI	69
Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.	69
A. Pendahuluan	69
B. Permulaan Persalinan	70
C. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan	73
D. Kala I Persalinan/Kala Pembukaan	81
E. Kala II Persalinan (Kala Pengeluaran)	84
F. Kala III Persalinan (Kala Uri/Placenta)	88
G. Kala IV Persalinan (2-4 Jam Post Partum)	90
H. Manajemen Nyeri Persalinan	91
I. Referensi	99
 PROFIL PENULIS	101

CHAPTER 1

PENTINGNYA PEMERIKSAAN KEHAMILAN RUTIN

Rigoan Malawat. S.Kep., M. Kes

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan suatu keadaan dimana seorang wanita yang didalam rahimnya terdapat embrio dan fetus. Kehamilan dimulai pada saat masa konsepsi hingga lahirnya janin, dan lamanya kehamilan dimulai dari ovulasi hingga partus yang diperkirakan sekitar 280 hari atau 40 minggu dan tidak melebihi dari 300 hari atau 43 minggu (Amelia Erawaty, dkk, 2022)

Kehamilan berisiko tinggi adalah kehamilan yang cenderung berpotensi mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan ibu hamil, janin, ataupun keduanya. Pada dasarnya semua kehamilan memang memiliki risiko tersendiri. Namun, terdapat beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kehamilan menjadi lebih berisiko, misalnya ibu yang mengidap penyakit bawaan atau memiliki riwayat kehamilan yang bermasalah sebelumnya. Komplikasi dari kehamilan berisiko tinggi tersebut dapat terjadi mulai dari janin masih berada di dalam kandungan, selama proses persalinan, hingga masa nifas. Namun kehamilan yang berisiko tinggi bukan berarti ibu dan janin sudah pasti akan mengalami gangguan kesehatan. Hanya saja, ibu perlu menjalani perawatan dan berada di bawah pengawasan ekstra guna mengantisipasi terjadinya komplikasi kehamilan. Kehamilan resiko tinggi merupakan kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum kelahiran berlangsung (Putri, I. M., & Ismiyatun, N. (2020).

Antenatal Care (ANC) adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu selama masa kehamilan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan (Ayatullah Harun, 2021). Pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) sangat disarankan bagi para ibu hamil untuk memonitor kesehatan ibu dan janin dalam kandungan. Pemeriksaan kehamilan ini penting karena berguna dalam mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu, memonitor kesehatan ibu dan janin supaya persalinannya aman, agar tercapainya kesehatan bayi yang optimal dan yang lebih penting adalah mendeteksi dan mengatasi secara dini komplikasi atau resiko dan penyakit kehamilan yang mungkin dapat muncul misalnya hipertensi dalam kehamilan, diabetes dalam kehamilan (gestasional diabetes), Anemia, Janin dengan berat badan rendah, kehamilan anggur, plasenta previa (ari-ari menutup jalan lahir), infeksi dalam kehamilan

misalnya keputihan atau infeksi saluran kemih dan lain sebagainya (Susanti, E., & Zainiyah, Z., 2020).

Pemeriksaan rutin kehamilan dalam dunia medis disebut sebagai antenatal care, salah satu tujuan dari antenatal care tersebut adalah untuk mendeteksi dan mengatasi dini komplikasi Penyakit kehamilan yang mungkin dapat muncul. Pemeriksaan kehamilan rutin merupakan upaya untuk mengurangi angka komplikasi baik selama kehamilan dan selama persalinan (Asli, 2021).

Antenatal care penting dilakukan, ibu yang tidak mendapatkan asuhan antenatal memiliki risiko lebih tinggi kematian maternal, stillbirth, dan komplikasi kehamilan lainnya. Asuhan antenatal rutin bermanfaat untuk mendeteksi komplikasi pada kehamilan seperti anemia, preeklamsia, diabetes melitus gestasional, infeksi saluran kemih asimtomatik dan pertumbuhan janin terhambat (Nuzululdkk, 2021)

Hingga saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI) masih di kisaran 305 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita elamatkan dari kematian (Kemenkes RI, 2020).

Ibu berperan penting dalam mengasuh potensi anaknya di dalam kandungan. Salah satu inisiatif tersebut adalah Integrated Pregnancy/Pregnancy Screening atau Quality Prenatal Care (ANC). Secara umum, pelayanan antenatal terpadu (ANC) bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil atas pemeriksaan kehamilan yang berkualitas dan untuk mencapai kehamilan yang sehat, persalinan yang aman dan bayi yang sehat (Suryani, 2021). Masih banyaknya ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan menyebabkan tidak terdeteksinya faktor-faktor risiko tinggi yang mungkin dialami oleh mereka. Risiko ini baru diketahui pada saat persalinan yang sering kali karena kasusnya sudah terlambat dapat membawa akibat fatal yaitu kematian. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi (Andi Hasnah, 2022).

Sehingga penurunan angka kematian ibu melahirkan menjadi salah satu dari delapan tujuan yang dirumuskan dalam komitmen internasional Millenium Development Goals (MDGs) untuk pembangunan jangka panjang kesehatan Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2025. (Erika, dkk, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak yaitu dengan melakukan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas melalui pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) (Yesidkk, 2021).

Komplikasi dari kehamilan dan persalinan sebagai penyebab tertinggi kematian ibu tersebut dapat dicegah dengan pemeriksaan kehamilan melalui antenatal care (ANC) secara rutin dan teratur. Antenatal care (ANC) merupakan perawatan yang diberikan tenaga profesional (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, dan perawat) kepada ibu selama masa kehamilan. ANC juga dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko tinggi selama kehamilan (Fitriani et al. 2023).

B. Pelayanan dalam Pemeriksaan Kehamilan

Pelayanan pemeriksaan kehamilan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional pada ibu selama kehamilan dilaksanakan sesuai dengan standar antenatal. Pelayanan antenatal bertujuan untuk memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya dengan cara memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, serta sosial ibu dan bayi, mengenali secara dini adanya komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan (Fauziah, Mariana, dan Saputra, 2020).

Kunjungan antenatal care adalah kunjungan yang dilakukan oleh ibu hamil selama kehamilannya yang merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan adanya penyakit bahkan gangguan yang dapat membahayakan ibu dan kandungannya. (Kemenkes RI, 2020) Jadi upaya peningkatan kunjungan antenatal care adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan antenatal care ibu hamil selama masa kehamilannya.

Pemeriksaan kehamilan atau yang dikenal dengan istilah ANC (*Antenatal Care*) adalah pemeriksaan kehamilan yang wajib dilaksanakan oleh para Ibu Hamil. Tujuan dari ANC adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan menyiapkan mental ibu hamil secara optimal, sehingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif.

Standar kunjungan pelayanan pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil yaitu paling sedikit 4 kali kunjungan selama masa kehamilan. (Kemenkes RI, 2018). Setiap ibu hamil menghadapi risiko komplikasi yang bisa mengancam jiwanya. Oleh karena itu, wanita hamil perlu melakukan kunjungan kehamilan sedikitnya empat kali kunjungan selama masa kehamilan yaitu : Satu kali kunjungan selama trimester satu (<14 minggu). Pada kunjungan ini melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum, anemia kekurangan zat besi serta mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan, kebersihan, istirahat dan sebagainya). Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-28). Pada kunjungan ini pemeriksaannya sama dengan sebelumnya, ditambah kewaspadaan khusus mengenai preeklamsi (gejala

preeklampsia, pemantauan tekanan darah, evaluasi adanya edema). Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36 dan sesudah minggu ke 36). Pada pemeriksaan trimester tiga antara minggu 28-36 ini ditambah pemeriksaan palpasi abdominal untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan ganda. Setelah minggu ke 36 di tambah deteksi letak bayi yang tidak normal atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit. (Kemenkes RI, 2018)

Setelah adanya pembaharuan sesuai dengan Permenkes No.21 Tahun 2021 bahwa untuk pelayanan Antenatal Care ada penambahan yaitu K1-K6 pelayanannya yaitu Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Pelayanan Kesehatan Bersalin, Pelayanan Kesehatan Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Pelayanan Kesehatan Seksual Kemenkes RI tentang Standar Pelayanan Antenatal care pada kehamilan normal 6 kali dengan rincian 2 kali di trimester satu, 1 kali di trimester dua, dan 3 kali di trimmester tiga (Kemenkes RI, 2022).

Pemeriksaan ANC yang wajib dan disarankan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebanyak minimal 6 kali, yakni :

1. Satu kali pemeriksaan pada Trimester pertama

Trimester pertama mulai dari awal kehamilan sampai usia kehamilan 12 minggu. Pada tahap ini, baiknya ibu melakukan ANC sebanyak 1 kali di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan pertama juga dapat terjadi saat awal saat ibu mulai mengalami telat menstruasi. Pada kunjungan ini melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum, anemia kekurangan zat besi serta mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan, kebersihan, istirahat dan sebagainya)

2. Dua kali pemeriksaan pada Trimester kedua.

Trimester kedua dimulai dari kehamilan diatas 12 minggu sampai kehamilan 24 minggu. Pada tahap ini, baiknya ibu melakukan ANC minimal 2 kali di fasilitas kesehatan.

3. Tiga kali pemeriksaan pada Trimester ketiga.

Trimester ketiga dimulai dari usia kehamilan diatas 24 minggu. Pada tahap ini, baiknya ibu melakukan ANC minimal 3 kali di fasilitas kesehatan. Biasanya pemeriksaan tahap ini dilakukan pada usia kehamilan diatas 24 minggu sampai 40 minggu.

Kunjungan ke-6 (K6) K6 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 2 kali pada trimester kesatu (0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (> 12minggu - 24 minggu), dan 3 kali pada trimester ketiga (>24 minggu sampai dengan kelahiran), dimana

minimal 2 kali ibu hamil harus kontak dengan dokter (1 kali ditrimester 1 dan 1 kali di trimester 3). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 6 (enam) kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Jika kehamilan sudah mencapai 40 minggu.

Trimester kehamilan dihitung mulai dari hari pertama periode haid terakhir atau yang dikenal dengan HPHT. Oleh karena itu, ingat selalu ya tanggal HPHT untuk mengetahui memperkirakan waktu kehamilan ibu.

Selain itu, ada beberapa kondisi yang mengharuskan ibu hamil untuk lebih sering kontrol ke dokter, yaitu:

1. Menjalani kehamilan di usia 35 tahun atau lebih tua
2. Berisiko melahirkan secara prematur
3. Mengalami komplikasi kehamilan atau kehamilan risiko tinggi, misalnya preeclampsia
4. Memiliki riwayat penyakit, seperti asma, lupus, anemia, diabetes, tekanan darah tinggi, atau obesitas

Tujuan Kunjungan Antenatal Care Menurut (Kementrian Kesehatan RI, 2018) ada beberapa tujuan dari kunjungan antenatal care yaitu :

1. Mengetahui bila terdapat komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi sejak dini
2. Memantau kemajuan kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu dan tumbuh kembang janin yang dalam kandungan.
3. Meningkatkan pertahanan kesehatan ibu dan janin
4. Mempersiapkan proses persalinan agar bayi dapat terlahir dengan selamat serta meminimalkan trauma yang mungkin dirasakan ibu saat melakukan persalinan.
5. Mempersiapkan ibu untuk bisa melewati masa nifas dengan baik serta memberikan ASI eksklusif pada bayinya.
6. Mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk dapat menerima kelahiran sang buah hati agar tumbuh kembang anak menjadi baik.

Manfaat Melakukan Ante Natal Care secara rutin :

1. Mencegah, mendeteksi dan mengelola faktor risiko yang berdampak buruk bagi kesehatan ibu hamil dan janin.
2. Memberikan anjuran, pengetahuan dan dukungan bagi ibu hamil dan keluarga.
3. Deteksi dini kemungkinan adanya penyakit menular seperti HIV, Sifilis dan Hepatitis B. Deteksi dini akan membantu menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Suntik Tetanus Toksoid (TT). Tetanus adalah infeksi yang mengancam jiwa disebabkan oleh bakteri *Clostridium Tetani*. Suntik TT pada ibu hamil bertujuan untuk mencegah terjadinya tetanus pada proses persalinan, di mana pada proses

persalinan kemungkinan akan terdapat luka pada rahim atau tali pusar bayi. Tetanus adalah infeksi yang mengancam jiwa disebabkan oleh bakteri *Clostridium Tetani*.

5. USG. Pada saat ANC ibu hamil juga bisa mendapatkan pemeriksaan USG untuk membantu mendeteksi kelainan pada janin. Memastikan kehamilan kembar dan memastikan posisi plasenta.

Pelayanan kehamilan mencakup banyak hal, namun dalam penerapan operasionalnya dikenal dengan standar 14T untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan terdiri dari :

Menurut Kristiyanti (2020) penerapan Asuhan standar minimal 14T yaitu:

1. Pengukuran Tinggi Badan dan penimbangan Berat Badan (T1)

Pengukuran tinggi badan cukup sekali dilakukan pada saat ANC ini dilakukan untuk mendeteksi faktor resiko terhadap kehamilan yang sering berhubungan dengan keadaan rongga panggul.

2. Pengukuran Tekanan Darah (T2)

Pengukuran tekanan darah dilakukan setiap kali melakukan kunjungan dengan normal 120/80 mmHg. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi apakah tekanan darah normal atau tidak, tekanan darah yang tinggi yang mencapai 180/100 mmHg dapat membuat ibu mengalami keracunan kehamilan, baik ringan maupun berat bahkan sampai kejang - kejang. Sementara tekanan darah yang rendah juga menyebabkan pusing dan lemah.

3. Pengukuran Tinggi Fundus Uteri (T3)

Biasanya jika periksa ke bidan, akan diukur tinggi Rahim dengan melakukan palpasi dengan meraba bagian perut. Apabila periksa ke dokter, dapat dilihat melalui USG. Manfaat mengukur tinggi fundus uteri yaitu mendeteksi apakah besar kehamilan sesuai dengan umur kehamilan atau tidak. Misalnya kembar, tentu besarnya Rahim tidak sesuai dengan usianya karena lebih besar.

4. Pemberian Tetanus Toxoid Lengkap (T4)

TT (Tetanus Toksoid) menanyakan kepada ibu hamil jumlah vaksin yang telah diperoleh dan sejauh mana ibu sudah mendapatkan imunisasi TT, secara idealnya WUS (Wanita Usia Subur) mendapatkan imunisasi TT sebanyak 5 kali (long life) mulai dari TT1 sampai TT5.

5. Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan (T5)

Zat besi adalah unsur pembentukan sel darah merah dibutuhkan oleh ibuhamil guna mencegah terjadinya anemia atau kurang darah selama kehamilan. Pemberian tablet besi atau Tablet Tambah Darah (TTD) diberikan pada ibu hamil sebanyak satu tablet (60mg) setiap hari berturut-turut selama 90 hari selama masa

kehamilan, sebaiknya memasuki bulan kelima kehamilan. TTD mengandung 200 mg ferro sulfat setara dengan 60 ml besi elemental dan 0,25 mg asam folat baik diminum dengan air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan.

6. Pemberian HB (T6). Manfaatnya untuk mendeteksi anemia pada kehamilan.

7. Pemeriksaan VDRL (T7)

Pemeriksaan Venereal Disease Research Laboratory adalah tes darah untuk mengetahui adanya treponema pallidum/penyakit menular seksual.

8. Pemeriksaan Protein Urin (T8)

Berguna untuk mendeteksi adanya protein dalam urine dan ditunjukkan pada ibu hamil dengan riwayat tekanan darah tinggi dengan kaki bengkak. Namun saya tidak ada riwayat darah tinggi juga melakukan pemeriksaan ini. Kegunaannya untuk mendeteksi ibu hamil ke arah preeklampsia.

9. Pemeriksaan Reduksi Urin (T9)

Biasanya dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi penyakit Diabetes Melitus atau adanya riwayat penyakit gula pada keluarga. Apabila reduksi urine hasilnya (+), biasanya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan gula darah untuk memastikan adanya Diabetes Melitus Gestasional.

10. Perawatan Payudara (T10)

Meliputi senam payudara, perawatan payudara, pijat tekan payudara dengan tujuan menjaga kebersihan payudara, mengencangkan serta memperbaiki bentuk puting (misalnya tenggelam, atau flat nipple), merangsang kelenjar susu agar produksi ASI lancar, dan mempersiapkan laktasi.

11. Pemberian Senam Hamil (T11)

Senam hamil banyak sekali manfaatnya, mulai dari mempertahankan dan memperkuat otot dinding perut, panggul, latihan pernapasan, kontraksi relaksasi dan lain-lain.

12. Pemberian Obat Malaria (T12)

Ibu hamil dengan malaria mempunyai resiko terkena anemia dan meninggal. WHO telah merekomendasikan tiga strategi penanggulangan malaria pada kehamilan yaitu: deteksi dini dan pengobatan malaria yang efektif, pencegahan malaria secara intermiten dengan menggunakan SP dan menggunakan kelambu berinsektisida. Pemberian obat pencegah malaria dapat dilakukan secara mingguan.

13. Pemberian Kapsul Minyak Yodium (T13)

Kapsul ini berisi kandungan 200 mg yodium dalam bentuk minyak yang dikemas berbentuk kapsul. Kapsul ini bermanfaat untuk mencegah lahirnya bayi kretin dan diberikan kepada seluruh wanita usia subur, ibu hamil dan ibu nifas.

14. Temu wicara (Konseling) (T14)

Konseling dilakukan setiap ibu melakukan pemeriksaan antenatal care dengan melakukan memberitahu ibu cara perilaku hidup bersih dan sehat, meninjau kesehatan ibu hamil, memberitahu peran suami dan keluarga dalam masa kehamilan, tanda bahaya kehamilan, asupan gizi seimbang untuk ibu hamil, gejalapenyakit menular, inisiasi menyusui dini dan Keluarga berencana (KB).

Pemeriksaan rutin ini membantu deteksi dini dan pengobatan kondisi yang mungkin timbul selama kehamilan. . (Kemenkes RI, 2020). Hal tersebut perlu dilakukan pengawasan yang optimal, apabila tidak dilakukan pemeriksaan secara optimal dikhawatirkan akan memberikan efek tidak baik terhadap kehamilan tersebut. Salah satu langkah awal upaya preventif yaitu mengetahui penyebab tidak tercapainya target kunjungan ANC, selain itu salah satu tujuan ANC untuk mengurangi jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) yang ada di Indonesia.

Pentingnya ANC diperkuat oleh laporan global WHO yang menyebutkan bahwa 75% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, infeksi, dan hipertensi selama kehamilan kondisi yang sebagian besar dapat dicegah melalui informasi yang memadai tentang kesehatan ibu dan anak selama masa kehamilan (Kolantung, 2021). Dengan mengikuti ANC secara teratur diharapkan ibu hamil serta petugas kesehatan mampu mendeteksi serta menangani ketika terjadinya komplikasi, sehingga ANC sangat penting untuk menjamin bahwa proses alami dalam kehamilannya berjalan seperti standar dan dengan normal. Antenatal Care (pemeriksaan kehamilan) sangatlah penting diketahui oleh ibu hamil karena dapat membantu mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Keuntungan yang lain yaitu untuk menjaga agar selalu sehat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat, memantau kemungkinan adanya resiko-resiko kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan resiko tinggi serta menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin perinatal

C. Kepatuhan dalam Pemeriksaan ANC

Kepatuhan dalam melakukan ANC akan meningkatkan pemahaman ibu tentang kehamilan, nifas dan persalinan sehingga ibu hamil akan mampu mengurangi kecemasan yang dialami dalam menjalani proses persalinan (Missa et al., 2020). Kepatuhan ibu hamil melaksanakan kunjungan ANC memberi manfaat dan bantuan yang signifikan agar proses persalinan ibu hamil berjalan baik sesuai harapan. Dalam pengertian ibu dan bayi mengalami keselamatan.. kunjungan ibu hamil dalam ANC mesti diikuti dengan kepatuhan. Ukuran patuh yang dipakai

adalah 6 kali melakukan kunjungan. ibu hamil diharapkan secara aktif dan teratur mengikuti ANC sesuai petunjuk bidan (tenaga kesehatan). Kepatuhan ini dapat terlihat, terpantau secara positif mentaati jadwal kunjungan, atau menjumpai bidan dengan teratur

Kunjungan rutin prenatal ke tenaga Kesehatan di setiap fasilitas pelayanan Kesehatan merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan. Pemeriksaan kehamilan secara teratur memungkinkan deteksi dini komplikasi kehamilan, pencegahan kesulitan kehamilan dan pemberian Pendidikan kehamilan untuk meningkatkan pemahaman ibu. Kunjungan antenatal bertujuan agar ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat mengenali tanda bahaya kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan, mengurus transportasi rujukan jika sewaktu waktu dibutuhkan. Untuk itu ibu hamil diharapkan untuk patuh melakukan kunjungan kehamilan secara rutin dan membaca buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) agar dapat dilakukan secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari termasuk dapat mengenali tanda-tanda bahaya pada kehamilan (Safari et al., 2023). Banyak faktor yang menyebabkan tingginya AKI, seperti status sosial ekonomi yang rendah, latar belakang pendidikan rendah, lingkungan masyarakat dan kepercayaan bahwa kehamilan adalah suatu kejadian alami, yang tidak kalah pentingnya adalah unsur pemantauan selama kehamilan yaitu Antenatal Care (ANC), Ibu yang tidak menjalani ANC kurang dari 6 kali kunjungan akan berisiko mengalami masalah kesehatan (Dary, Nusawakan dan Setyaningrum, 2019).

Keberhasilan kunjungan antenatal care juga harus didukung motivasi dan kepatuhan yang besar dari ibu hamil itu sendiri dan pemberian informasi kesehatan yang terus menerus dari petugas kesehatan melalui berbagai media penyuluhan tentang manfaat pemeriksaan kehamilan sehingga peningkatan kesehatan dapat terwujud dan dapat merubah pola pikir dan kebiasaan yang salah yang dilakukan ibu hamil.(Handayani & Rinah, 2019).

Dukungan suami menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berupa tanggung jawab secara sosial,moral dan ekonomi menyangkut: pencari nafkah, pelindung, keteladanan, pengasuhan, menjalin hubungan dengan lingkungan, mempunyai hak reproduksi yang sama. Bentuk dukungan Suami terhadap istri yang sedang hamil seperti : mengetahui usia ideal bagi wanita untuk hamil, mengetahui masa subur istri, mengantar istri periksa kehamilan ke tenaga kesehatan, menentukan tempat persalinan dan rujukan, menyiapkan biaya melahirkan, mengetahui tentang 14T dalam pemeriksaan kehamilan memperhatikan gizi bagi ibu hamil,mengetahui kesehatan ibu, bayi dan anak,persalinan dan nifas. (Ninla, 2019).

Ibu hamil yang tidak teratur melakukan pemeriksaan kehamilan akan terjadi komplikasi yang lebih lanjut yang akan mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Sistem penilaian resiko tidak dapat memprediksi apakah ibu hamil bermasalah selama kehamilannya. Oleh karena itu, pelayanan asuhan antenatal merupakan cara penting untuk memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan normal. Kepatuhan dalam melakukan ANC akan meningkatkan pemahaman ibu tentang kehamilan, nifas dan persalinan sehingga ibu hamil akan mampu mengurangi kecemasan yang dialami dalam menjalani proses persalinan (Missa et al., 2020)

Menurut Dewanggayastuti (2022), dampak dari tidak melakukan ANC pada ibu hamil yaitu ibu hamil akan kurang mendapat informasi tentang cara perawatan kehamilan yang benar. Selain itu, tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan secara dini, seperti anemia kehamilan yang dapat menyebabkan perdarahan saat persalinan. Begitu pula dengan tidak terdeteksinya tanda penyulit persalinan sejak awal seperti kelainan bentuk panggul atau kelainan pada tulang belakang, atau kehamilan ganda. Ditambah lagi dengan tidak terdeteksinya penyakit penyerta dan komplikasi selama kehamilan seperti preeklampsia dan penyakit kronis

D. Simpulan

Kehamilan berisiko tinggi adalah kehamilan yang cenderung berpotensi mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan ibu hamil, janin, ataupun keduanya. Pemeriksaan kehamilan penting karena berguna dalam mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu, memonitor kesehatan ibu dan janin supaya persalinannya aman, agar tercapainya kesehatan bayi yang optimal dan yang lebih penting adalah mendeteksi dan mengatasi secara dini komplikasi atau resiko dan penyakit kehamilan yang mungkin dapat muncul. Pelayanan ANC diukur dengan cakupan kunjungan pertama (K1) dan kunjungan keenam (K6), yang menggambarkan kepatuhan ibu hamil dalam menjalani pemeriksaan secara rutin. Keberhasilan kunjungan antenatal care juga harus didukung motivasi dan kepatuhan yang besar dari ibu hamil itu sendiri dan pemberian informasi kesehatan yang terus menerus dari petugas kesehatan melalui berbagai media penyuluhan tentang manfaat pemeriksaan kehamilan sehingga peningkatan kesehatan dapat terwujud dan dapat merubah pola pikir dan kebiasaan yang salah yang dilakukan ibu hamil.

E. Referensi

- Amelia Erawaty Siregari, dkk, 2020. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Kunjungan Ulang Antenatal Care Di Klinik Pratama Sahabat Bunda Tahun 2022. *Jurnal Medika Husada*, Vol. 6, No.1.
- Asli, A. (2021). Machine Translated by Google Analisis Pemberdayaan Diri Ibu Hamil di Masa Covid -19 Pandemi 15, 333–336.
- Ayatullah Harun, 2021. Hubungan Dukungan Tenaga Kesehatan Terhadap Kunjungan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Pattingalloang Makassar. *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia*, Vol. 5, No.1
- Azizah, Nabilah Nur. 2021. "Hubungan Antara Sikap Dan Pengetahuan Ibu Hamil Dengan Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal Care) Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Medika Hutama02*, no. 04
- Dary, Nusawakan, A.W. and Setyaningrum, F. (2019) 'Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Melakukan Pemeriksaan Kehamilan Di Desa Sidorejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan', *Media Ilmu Kesehatan*, 6(2), pp. 177–185. Available at: <https://doi.org/10.30989/mik.v6i2.194>
- Dewanggayastuti, K. I., Surinati, I. D. A. K., & Hartati, N. N. (2022). Kepatuhan Ibu Hamil melakukan Kunjungan Antenatal Care (ANC) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Gema Keperawatan*, 15(1), 54–67
- Erika, dkk, 2022 Penyuluhan Tentang Peran Serta Dan Dukungan Keluarga Terhadap Kunjungan Antenatal Care Di PBM Mardianum Kelurahan Tegal Sari II Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 1406-1411. <https://doi.org/10.58466/literasi.v2i2.565>
- Fauziah, N. A., Mariana, D. dan Saputra, M. A. S. (2020) "Hubungan Pendapatan Pengasuh Dengan Kualitas Interaksi Pengasuh dan Anak Stunting Usia 6-23 Bulan," *Jurnal 'Aisyiah Medika*, 5(1), hal. 43–53. doi: 10.36729/jam.v5i1.309
- Fitriani, A, N Mauyah, Y. F Wahyuni, and I Friscila. 2023. "Edukasi Pentingnya Kunjungan ANC Pada Ibu Dengan Media Syair Aceh Di Desa Lancok." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*7, no. 5:5264–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17405>.
- Handayani, & Rinah. (2019). Hubungan dukungan suami terhadap kepatuhan ibu melakukan kunjungan antenatal care. *Jurnal Online Keperawatan Indonesia*, 2(1), 157–164

- Kemenkes RI, 2022. <https://yankes.kemkes.go.id> Pelayanan Antenatal Care
- Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, Dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Baru
- Kemenkes RI. (2018). Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan (ANC) di Fasilitas Kesehatan. Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
- Kristiyanti Melinda. (2020). Gambaran Pelaksanaan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Pada Ibu Hamil. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Missa, Y. M., Khorri, A. N., & Rosmaharani, S. (2020). Ibu Hamil Trimester III Dalam Menghadapi Persalinan Di Desa Sumbermulyo, Jogoroto Kabupaten Jombang. Stikes Pemkab Jombang, 60–69
- Nimedhealth (2020). The Purposes, Aims and Benefits of Antenatal Care.
- Nuzulul dkk, 2021. Pendidikan Kesehatan Tentang Pentingnya Kunjungan Antenatal Care (Anc) Sesuai Standar Selama Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Ie Alang Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan), 3 (1
- Promkes. kemkes (2018). Pentingnya pemeriksaan kehamilan ANC di fasilitas kesehatan.
- Putri, I. M., & Ismiyatun, N. (2020). Deteksi Dini Kehamilan Beresiko. JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama ,8(1), 40-51.
- Putri, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan K4 Di Puskesmas Katomaliga Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Doctoral Dissertation, Universitas Ngudi Waluyo)
- Safari, H. et al. (2023) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Ibu Hamil Untuk Kunjungan Antenatal Care Di PMB Hasrany Safari', MJ (Midwifery Journal), 3(4), pp. 185–192
- Suryani, 2021. Gambaran Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan Antenatal Care Di Puskesmas Leyengan. Jurnal Kebidanan.
- Susanti, E., & Zainiyah, Z. (2020). Kartu Skor Puji Rochyati (KSPR) Dalam Upaya Skrining Kehamilan Ibu Resiko Tinggi. Jurnal ARADIGMA (Pemberdayaan & Pengabdian Kepada Masyarakat), 2(2), 1-9.

Yesi dkk, 2021. Penyuluhan dan Pemeriksaan ANC Pada Ibu Hamil Di Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru Tahun 2021. Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health Services), 01 (03). DOI : <https://doi.org/10.25311/jpkk.Vol1.Iss3.1057>

F. Glosarium

ANC	= <i>Antenatal Care</i>
AKI	= Angka kematian Ibu
ASI	= Air Susu Ibu
BKKBN	= Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
KIA	= Kesehatan Ibu dan Anak
Preventif	= Pencegahan
TT	= Tetanus Toksoid
USG	= <i>Ultrasonografi</i>
VDRL	= <i>Veneral Disease Research Laboratory</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i>

CHAPTER 2

PERAWATAN PERSALINAN NORMAL DAN TEKNIK MANAJEMEN RASA SAKIT

Yuyun Setyorini, S.Kp., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan

Persalinan normal merupakan salah satu proses fisiologis yang menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang perempuan. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan emosional ibu. Persalinan normal yang berlangsung tanpa intervensi medis berlebihan memberikan manfaat besar bagi kesehatan ibu dan bayi, seperti pemulihan yang lebih cepat dan peningkatan peluang keberhasilan pemberian ASI. Namun, di era modern ini, banyak perempuan yang mengalami ketakutan atau kekhawatiran menghadapi persalinan, sehingga memerlukan pendampingan dan dukungan dari tenaga kesehatan, terutama perawat. (WHO, 2018).

Peran perawat dalam mendukung persalinan normal sangat penting, mengingat perawat adalah tenaga kesehatan yang sering berinteraksi langsung dengan ibu bersalin. Perawat tidak hanya bertugas memberikan asuhan fisik, tetapi juga harus mampu mendukung ibu secara emosional dan mental. Dengan pendekatan yang tepat, perawat dapat membantu mengurangi kecemasan ibu, meningkatkan kepercayaan diri, serta meminimalkan risiko komplikasi. Studi menunjukkan bahwa dukungan perawat yang berkelanjutan selama persalinan dapat meningkatkan kemungkinan kelahiran spontan tanpa intervensi medis. (Hodnett et al., 2013).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas perawatan persalinan normal menjadi salah satu prioritas global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendorong penerapan praktik berbasis bukti dalam mendukung persalinan normal, seperti teknik manajemen nyeri non-farmakologis dan penggunaan posisi optimal selama persalinan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengalaman positif ibu bersalin, tetapi juga untuk mencegah intervensi medis yang tidak perlu. (WHO, 2018).

Buku ini disusun untuk memberikan panduan praktis kepada mahasiswa keperawatan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan persalinan normal. Dengan mengintegrasikan teori, praktik berbasis bukti, dan

pengalaman klinis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi komprehensif untuk mendukung pelaksanaan perawatan persalinan normal yang holistik. Selain itu, buku ini juga dirancang untuk memperkuat keterampilan perawat dalam mendampingi ibu bersalin, sehingga mampu memberikan asuhan yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan individu.

B. Konsep Dasar Persalinan Normal

1. Definisi dan Karakteristik Persalinan Normal

Persalinan normal adalah proses fisiologis di mana bayi dilahirkan melalui jalan lahir tanpa intervensi medis yang tidak diperlukan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), persalinan normal harus memenuhi kriteria berikut: dimulai secara spontan, berlangsung dengan durasi yang wajar, tanpa penggunaan alat bantu seperti forceps atau vakum, serta tanpa komplikasi yang signifikan bagi ibu maupun bayi. Persalinan normal berfokus pada pengalaman positif bagi ibu dan keluarga, dengan menghormati hak asasi perempuan selama proses tersebut. (*WHO, 2018*).

Persalinan normal merupakan proses alami yang memiliki karakteristik tertentu, yang memastikan kelahiran berlangsung secara fisiologis tanpa intervensi medis yang tidak diperlukan. Berikut adalah uraian rinci mengenai karakteristik persalinan normal:

a. Dimulai secara Spontan

Persalinan normal dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan efektif secara spontan. Kontraksi ini berperan dalam melunakkan dan membuka serviks untuk mempersiapkan jalur keluarnya bayi. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keseimbangan hormon seperti oksitosin dan prostaglandin yang memicu kontraksi rahim. (*Cunningham et al., 2022*).

b. Progresi persalinan yang teratur

Persalinan normal menunjukkan progresi yang teratur, baik dari sisi dilatasi serviks maupun penurunan kepala janin.

- 1) Fase Laten (0–4 cm): Pada fase ini, kontraksi bersifat ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama. Proses ini bisa berlangsung beberapa jam atau bahkan hari, tergantung pada kesiapan tubuh ibu.
- 2) Fase Aktif (4–10 cm): Pada fase ini, kontraksi menjadi lebih kuat, lebih sering, dan lebih lama. Dilatasi serviks berlangsung dengan kecepatan lebih cepat, biasanya 1 cm per jam atau lebih pada primigravida. (*Friedman, 1954*).

c. Dilahirkan Melalui Jalan Lahir Alami

Proses kelahiran bayi dalam persalinan normal terjadi melalui jalan lahir alami tanpa bantuan alat seperti vakum atau forceps. Bayi melewati panggul ibu melalui mekanisme kardinal, termasuk engagement, descent, flexion, internal rotation, extension, external rotation, dan expulsion. Mekanisme ini memungkinkan bayi lahir dengan aman jika posisi janin optimal, seperti presentasi kepala anterior. (*American College of Obstetricians and Gynecologists, 2020*).

d. Tanpa Intervensi Medis yang Tidak Diperlukan

Persalinan normal tidak memerlukan intervensi medis seperti pemberian oksitosin sintetik atau operasi caesar, kecuali terdapat indikasi medis. Pendekatan minimal invasif ini penting untuk mengurangi risiko komplikasi, seperti infeksi atau trauma pada ibu dan bayi. (*WHO, 2018*).

e. Bayi Lahir dalam Keadaan Sehat

Persalinan normal menghasilkan bayi yang lahir dalam keadaan sehat, dengan adaptasi fisiologis yang baik. Bayi biasanya memiliki nilai *Apgar score* 7–10 pada satu menit pertama setelah lahir, yang menunjukkan fungsi pernapasan, tonus otot, refleks, dan warna kulit yang normal. Proses melalui jalan lahir juga membantu mengeluarkan cairan dari paru-paru bayi, mempersiapkannya untuk bernapas dengan baik. (*Resnick et al., 2021*).

f. Pemulihan yang Cepat bagi Ibu

Ibu yang menjalani persalinan normal cenderung memiliki pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menjalani persalinan dengan intervensi. Mobilisasi dini setelah persalinan memungkinkan ibu untuk segera merawat bayinya dan memulai pemberian ASI. (*Gupta et al., 2017*).

2. Tahapan Persalinan Normal

Tahapan proses persalinan normal terdiri dari 4 kala (Cunningham et al., 2022).

a. Kala I (Pembukaan Serviks)

Kala I adalah tahap awal persalinan yang dimulai dari kontraksi uterus pertama hingga dilatasi serviks mencapai 10 cm. Tahapan ini dibagi menjadi dua fase:

1) Fase Laten

- a) Berlangsung dari pembukaan serviks 0–4 cm.
- b) Kontraksi terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang, berdurasi 30–45 detik, dan berjarak 5–30 menit.
- c) Proses ini bisa berlangsung 6–20 jam pada primigravida dan lebih singkat pada multigravida.

- d) Selama fase ini, serviks mengalami pelunakan dan pemendekan (*effacement*) secara bertahap.
- 2) Fase Aktif
 - a) Dimulai dari pembukaan serviks 4–10 cm.
 - b) Kontraksi menjadi lebih kuat, sering, dan teratur, dengan durasi 45–90 detik dan jarak 2–5 menit.
 - c) Kecepatan dilatasi serviks mencapai sekitar 1 cm/jam pada primigravida dan hingga 1,5 cm/jam pada multigravida.
 - d) Fase ini biasanya berlangsung 4–8 jam.
- b. Kala II (Pengeluaran Bayi)

Kala II dimulai dari dilatasi serviks lengkap (10 cm) hingga bayi lahir. Pada tahap ini, kontraksi uterus bekerja sama dengan dorongan ibu untuk mengeluarkan bayi melalui jalan lahir.

 - 1) Durasi: Biasanya berlangsung 20 menit hingga 2 jam, tergantung pada paritas ibu dan posisi janin.
 - 2) Kontraksi: Intensitas tinggi dengan durasi 60–90 detik dan jarak 2–3 menit.
 - 3) Proses Mekanisme Kardinal:
 - a) Engagement (masuknya kepala janin ke panggul).
 - b) Descent (turunnya janin).
 - c) Flexion (dagu janin mendekati dada untuk mempermudah melewati jalan lahir).
 - d) Internal rotation (rotasi kepala janin agar sesuai dengan diameter panggul).
 - e) Extension (kepala janin keluar dengan posisi ekstensi).
 - f) External rotation (kepala janin kembali ke posisi semula).
 - g) Expulsion (seluruh tubuh bayi lahir).
- c. Kala III (Pengeluaran Plasenta)

Kala III dimulai dari kelahiran bayi hingga pengeluaran plasenta. Tahapan ini biasanya berlangsung 5–30 menit.

 - 1) Tanda-tanda Pelepasan Plasenta:
 - a) Fundus uterus mengeras dan teraba di atas pusar.
 - b) Tali pusat memanjang.
 - c) Keluarnya darah secara mendadak (indikasi pemisahan plasenta dari dinding uterus).
 - 2) Proses Pengeluaran Plasenta:
 - a) Plasenta dilepaskan melalui kontraksi uterus.
 - b) Teknik manual atau penekanan pada fundus uterus (dengan hati-hati) dapat digunakan untuk membantu proses ini.

Manajemen aktif kala III, termasuk pemberian oksitosin, sangat dianjurkan untuk mencegah perdarahan postpartum.

d. Kala IV (Pemulihan Awal)

Kala IV adalah tahap pemulihan yang berlangsung selama 1–2 jam setelah plasenta keluar. Fokus pada tahap ini adalah memastikan stabilitas kondisi ibu dan mencegah komplikasi.

Pemantauan Intensif:

- 1) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, suhu).
- 2) Penilaian kontraksi uterus untuk memastikan tidak ada atonia yang dapat menyebabkan perdarahan.
- 3) Observasi perdarahan postpartum.

Perawatan Ibu dan Bayi:

- 1) Ibu dianjurkan untuk memulai inisiasi menyusui dini (IMD) untuk merangsang pelepasan oksitosin alami, yang membantu kontraksi uterus.
- 2) Bayi ditempatkan dalam dekapan ibu untuk mempererat *bonding*.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Persalinan Normal

Proses persalinan dipengaruhi oleh interaksi antara lima faktor utama, yang dikenal dengan istilah 5P:

a. Passenger (Janin dan Plasenta)

Posisi, presentasi, dan ukuran janin sangat memengaruhi proses persalinan. Posisi anterior kepala janin biasanya memberikan hasil terbaik. (Cunningham et al., 2022).

b. Passageway (Jalan Lahir)

Meliputi panggul ibu dan jaringan lunak. Bentuk panggul gynecoid dianggap ideal untuk persalinan normal.

c. Powers (Kekuatan Kontraksi)

Kontraksi uterus dan tekanan dari otot perut ibu berperan dalam dilatasi serviks dan mendorong janin keluar.

d. Psyche (Kondisi Psikologis Ibu)

Tingkat kecemasan, ketakutan, dan dukungan emosional memengaruhi durasi dan hasil persalinan.

e. Position (Posisi Ibu)

Posisi selama persalinan, seperti duduk, jongkok, atau berdiri, dapat meningkatkan efektivitas kontraksi dan mempercepat persalinan. (Gupta et al., 2017).

4. Pentingnya Persalinan Normal

Persalinan normal memberikan banyak manfaat, baik bagi ibu maupun bayi. Bagi ibu, persalinan normal mempercepat pemulihan pasca-persalinan, mengurangi risiko komplikasi, dan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI. Bagi bayi, proses ini membantu mengeluarkan cairan dari paru-paru, mempersiapkan adaptasi pernapasan, dan memicu respons imun awal. Selain itu, persalinan normal juga lebih hemat biaya dibandingkan dengan intervensi seperti operasi caesar. (*WHO, 2018; American College of Obstetricians and Gynecologists, 2020*).

C. Asuhan Keperawatan pada Persalinan Normal

Asuhan keperawatan dalam persalinan normal merupakan intervensi komprehensif yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan suportif untuk memastikan proses persalinan berlangsung dengan aman bagi ibu dan bayi. Dalam bab ini, akan diuraikan tahapan asuhan keperawatan berdasarkan fase persalinan dan kebutuhan fisiologis, psikologis, serta emosional ibu. Pendekatan holistik menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, emosional, dan spiritual ibu selama persalinan.

- Aspek Fisik: Mencakup pemantauan tanda vital, kontraksi uterus, dan kondisi janin.
- Aspek Psikologis: Memberikan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri ibu.
- Aspek Spiritual: Memberikan kesempatan untuk menjalankan ritual atau doa sesuai keyakinan ibu.

1. Asuhan Keperawatan Kala I

a. Pengkajian

Pada kala I, pengkajian bertujuan untuk memantau kemajuan persalinan dan memastikan kenyamanan ibu. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah:

- 1) Kontraksi: Intensitas, frekuensi, durasi kontraksi.
- 2) Dilatasi Serviks: Evaluasi pembukaan serviks secara berkala (setiap 4 jam).
- 3) Pemantauan Jantung Janin: Memastikan bahwa detak jantung janin tetap stabil (120–160 bpm).
- 4) Kondisi Ibu: Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu), tanda-tanda kelelahan, dan kecemasan ibu.
- 5) Status Emosional: Dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan.

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Cemas berhubungan dengan ketidakpastian proses persalinan.
- 2) Nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus.
- 3) Risiko gangguan perawatan diri berhubungan dengan rasa lelah dan ketidaknyamanan.

c. Intervensi

- 1) Manajemen Nyeri: Berikan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, posisi yang nyaman, dan dukungan emosional.
- 2) Dukungan Psikologis: Menyediakan informasi mengenai proses persalinan untuk mengurangi kecemasan ibu.
- 3) Pemantauan Kontraksi: Evaluasi pola kontraksi secara berkala dan laporkan jika ada perubahan yang mencurigakan.
- 4) Pemantauan Janin: Monitor detak jantung janin menggunakan CTG atau doppler secara berkala.
- 5) Kompres Panas/Dingin: Memberikan kompres untuk mengurangi ketegangan otot pada ibu yang merasa tidak nyaman.
- 6) Pendidikan dan Dukungan: Berikan informasi mengenai apa yang diharapkan pada fase ini untuk mengurangi kecemasan. (*Cunningham et al., 2022; ACOG, 2020*).

2. Asuhan Keperawatan Kala II

a. Pengkajian

Pada kala II, pengkajian berfokus pada kemajuan kelahiran bayi dan kesiapan ibu untuk mendorong. Pengkajian yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Kontraksi: Frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi.
- 2) Posisi Janin: Pastikan kepala janin berada dalam posisi optimal (presentasi vertex).
- 3) Dilatasi dan Penurunan Janin: Menilai apakah ada progres dalam penurunan kepala janin.
- 4) Keinginan untuk Mengejan: Pantau apakah ibu merasa dorongan untuk mengejan.

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus dan proses kelahiran bayi.
- 2) Ketidakmampuan untuk beradaptasi berhubungan dengan dorongan untuk mengejan.
- 3) Risiko gangguan eliminasi berhubungan dengan tekanan pada rektum dan kandung kemih.

c. Intervensi

- 1) Membimbing Mengejan: Memberikan instruksi yang jelas tentang cara mengejan yang efektif dengan teknik pernapasan dan kontrol otot perut.
- 2) Dukungan Fisik dan Emosional: Memberikan dukungan emosional dengan memberikan kata-kata penyemangat, serta memastikan kenyamanan ibu selama mengejan.
- 3) Pemantauan Janin: Monitor detak jantung janin secara terus-menerus, terutama selama tahap mengejan.
- 4) Pemantauan Tanda Vital Ibu: Pemeriksaan tekanan darah dan suhu secara teratur untuk mendeteksi tanda-tanda komplikasi.
- 5) Posisi yang Nyaman: Mendorong ibu untuk mencoba berbagai posisi seperti posisi miring atau berjongkok untuk meningkatkan efektivitas dorongan. (ACOG, 2020; WHO, 2018).

3. Asuhan Keperawatan Kala III

a. Pengkajian

Pengkajian pada kala III bertujuan untuk memastikan plasenta keluar dengan aman dan menghindari perdarahan. Beberapa hal yang perlu dievaluasi:

- 1) Pemisahan Plasenta: Tanda-tanda plasenta telah terpisah dari dinding uterus, seperti pendarahan sedikit dan perubahan posisi fundus uterus.
- 2) Pemantauan Perdarahan: Mengevaluasi jumlah perdarahan dan memastikan tidak terjadi perdarahan yang berlebihan.
- 3) Pemantauan Tanda Vital Ibu: Pastikan tanda vital ibu tetap stabil (tekanan darah, nadi, suhu).

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Risiko perdarahan berhubungan dengan pemisahan plasenta.
- 2) Cemas berhubungan dengan ketidakpastian mengenai perdarahan dan plasenta yang tertinggal.

c. Intervensi

- 1) Pemantauan Perdarahan: Pastikan perdarahan dalam batas normal (500 ml pada persalinan pervaginam) dan pantau setiap tanda perdarahan berlebih.
- 2) Manajemen Aktif Kala III: Berikan oksitosin untuk mencegah atonia uteri dan perdarahan.
- 3) Pendidikan dan Informasi: Memberikan penjelasan tentang proses pengeluaran plasenta dan mengurangi kecemasan ibu.
- 4) Pemantauan Fundus Uterus: Setelah plasenta keluar, pastikan fundus teraba keras dan tidak ada tanda-tanda atonia uteri. (WHO, 2018; Cunningham et al., 2022).

4. Asuhan Keperawatan Kala IV

a. Pengkajian

Pada kala IV, pengkajian dilakukan untuk memastikan ibu pulih dengan baik pasca-persalinan dan mencegah komplikasi. Beberapa hal yang perlu dievaluasi:

- 1) Kontraksi Uterus: Memastikan uterus berkontraksi dengan baik untuk mengurangi risiko perdarahan.
- 2) Keadaan Ibu: Pemeriksaan tanda vital ibu (tekanan darah, nadi, suhu), dan perhatikan adanya tanda-tanda perdarahan postpartum.
- 3) Eliminasi: Pantau kebutuhan ibu untuk buang air kecil atau besar, serta memastikan ia dapat bergerak dengan nyaman.

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Risiko infeksi berhubungan dengan luka episiotomi atau perineum yang robek.
- 2) Risiko perdarahan berhubungan dengan atonia uteri atau retensio plasenta.
- 3) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelelahan dan rasa sakit pasca-persalinan.

c. Intervensi

- 1) Pemantauan Tanda Vital: Lakukan pemantauan tanda vital secara ketat, terutama tekanan darah, nadi, dan suhu untuk mendeteksi komplikasi seperti perdarahan atau infeksi.
- 2) Pencegahan Infeksi: Ajarkan ibu cara menjaga kebersihan perineum dan cara merawat episiotomi jika ada.
- 3) Dukungan Emosional: Memberikan dukungan untuk ibu dan bayi dalam proses *bonding* serta mendukung inisiasi menyusui dini (IMD).
- 4) Manajemen Nyeri: Berikan analgesik sesuai indikasi dan instruksikan ibu untuk bergerak sedikit demi sedikit untuk mempercepat pemulihan. (*Cunningham et al., 2022; ACOG, 2020*).

D. Manajemen Rasa Sakit pada Persalinan Normal

Rasa sakit selama persalinan adalah pengalaman subjektif yang dipengaruhi oleh faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya. Manajemen nyeri yang efektif bertujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan, mendukung proses fisiologis persalinan, dan meningkatkan pengalaman positif ibu dalam melahirkan (Cunningham et al., 2022). Berikut adalah uraian rinci tentang manajemen rasa sakit pada persalinan:

1. Mekanisme Rasa Sakit Selama Persalinan

Nyeri persalinan disebabkan oleh berbagai faktor:

a. Kala I (Pembukaan Serviks):

- 1) Nyeri berasal dari dilatasi serviks dan kontraksi uterus.
- 2) Serabut saraf yang terlibat adalah serabut viseral yang membawa impuls dari segmen spinal T10–L1.

b. Kala II (Pengeluaran Bayi):

- 1) Nyeri meningkat karena peregangan dan tekanan pada jaringan perineum, vagina, dan rektum.
- 2) Serabut saraf somatik dari segmen S2–S4.

c. Kala III dan IV (Pengeluaran Plasenta dan Pemulihan):

Nyeri berkurang tetapi tetap dirasakan akibat kontraksi uterus dan luka perineum.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi nyeri

Persepsi nyeri persalinan dipengaruhi oleh:

- a. Faktor Fisiologis: Intensitas kontraksi, ukuran bayi, posisi janin, dan durasi persalinan.
- b. Faktor Psikologis: Tingkat kecemasan, dukungan emosional, pengalaman sebelumnya, dan budaya.
- c. Faktor Lingkungan: Lingkungan fisik (suasana kamar) dan sosial (dukungan dari tenaga kesehatan dan keluarga).

3. Pendekatan Non-Farmakologi Untuk Manajemen Rasa Sakit

Pendekatan non-farmakologis membantu mengurangi rasa sakit tanpa intervensi medis. Teknik ini bersifat aman, efektif, dan tidak memiliki efek samping pada ibu atau janin (Smith et al., 2018; Simkin & Ancheta, 2017).

a. Teknik Relaksasi dan Pernapasan

- 1) Relaksasi: Mengurangi kecemasan dan ketegangan otot melalui teknik pernapasan dalam atau meditasi.
- 2) Pernapasan Ritmis: Pernapasan lambat saat kontraksi membantu mengalihkan perhatian dari rasa sakit.

b. Terapi Sentuhan dan Pijatan

Pijatan lembut pada punggung bawah, bahu, atau tangan dapat merangsang produksi endorfin dan mengurangi rasa sakit.

c. Kompres Panas dan Dingin

- 1) Kompres panas: Diletakkan pada punggung bawah atau perut untuk mengurangi ketegangan otot.
- 2) Kompres dingin: Membantu meredakan nyeri pada daerah perineum setelah kontraksi.

d. Hydrotherapy (Water Birth)

Berendam dalam air hangat membantu relaksasi otot, mengurangi tekanan pada punggung bawah, dan memberikan rasa nyaman.

e. Dukungan Emosional dan Psikologis

Kehadiran pasangan, keluarga, atau doula memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri ibu.

4. Pendekatan Farmakologi Untuk Manajemen Rasa Sakit

Pendekatan farmakologis sering digunakan untuk manajemen rasa sakit yang lebih intens. Pilihan ini melibatkan pemberian obat-obatan dengan efek sistemik (Hawkins, 2010; ACOG, 2020).

a. Analgesik Sistemik

1) Opioid: Morfin atau meperidin untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat. Efek samping dapat mencakup mual, muntah, atau depresi pernapasan pada janin.

2) Non-opioid: Paracetamol atau NSAID digunakan pada nyeri ringan hingga sedang.

b. Anestesi Regional

1) Epidural Anesthesia: Obat anestesi disuntikkan ke ruang epidural untuk memblokir nyeri dari pinggang ke bawah. Epidural sangat efektif untuk mengurangi nyeri kala I dan II.

2) Spinal Anesthesia: Diberikan saat operasi sesar atau kala II dengan efek cepat dan kuat.

c. Inhalasi Nitrous Oxide (Gas Tertawa)

Gas ini digunakan sebagai penghilang nyeri dengan efek ringan dan cepat. Tidak memengaruhi kesadaran ibu atau janin.

d. Blok Pudendal

Obat anestesi disuntikkan langsung ke saraf pudendal untuk mengurangi nyeri pada perineum dan vagina selama kala II dan III.

5. Pendekatan Komplementer Dan Alternatif

Pendekatan ini mencakup metode yang belum sepenuhnya diterima sebagai standar medis tetapi dapat membantu dalam mengelola nyeri (Smith et al., 2018; Cluett & Burns, 2013).

a. Akupresur dan Akupunktur

Menstimulasi titik-titik energi tubuh untuk merangsang pelepasan endorfin.

b. Aromaterapi

Minyak esensial seperti lavender atau peppermint digunakan untuk menciptakan suasana relaksasi.

c. Hypnobirthing

Teknik hipnosis digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kontrol ibu selama persalinan.

6. Rekomendasi Praktis Untuk Manajemen Rasa Sakit

- a. Pendekatan Individual: Pilihan metode manajemen nyeri harus disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan kondisi medis ibu.
- b. Kombinasi Teknik: Pendekatan non-farmakologis dapat dikombinasikan dengan farmakologis untuk hasil yang optimal.
- c. Komunikasi Efektif: Berikan penjelasan kepada ibu mengenai semua pilihan manajemen nyeri dan efek sampingnya.

E. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi pada Persalinan Normal

Komplikasi selama persalinan meskipun jarang, tetap dapat terjadi dan mempengaruhi keselamatan ibu serta bayi. Pencegahan yang tepat, deteksi dini, serta penanganan yang cepat dan efektif adalah kunci untuk mengurangi risiko dan memastikan hasil persalinan yang aman. Berikut adalah uraian rinci tentang pencegahan dan penanganan komplikasi pada persalinan normal:

1. Komplikasi pada Kala I

Komplikasi pada kala I umumnya berkaitan dengan durasi persalinan yang lebih lama, ketidakmampuan serviks untuk terbuka dengan optimal, dan masalah terkait kontraksi.

Komplikasi:

a. Prolonged Labor (Persalinan Prolonged)

Penyebab: Ketidakmampuan serviks untuk dilatasi secara efektif, ketidaksesuaian antara ukuran kepala janin dan panggul ibu, atau masalah pada kontraksi uterus. Tanda dan Gejala: Pembukaan serviks yang kurang dari 1 cm per jam pada ibu primigravida, atau kurang dari 2 cm per jam pada ibu multipara.

Penanganan:

- 1) Pemberian oksitosin: Jika kontraksi tidak cukup kuat, oksitosin dapat diberikan untuk meningkatkan intensitas kontraksi.
- 2) Manajemen Posisi: Mendorong ibu untuk berubah posisi, seperti posisi miring, untuk membantu aliran darah ke uterus dan meningkatkan efektivitas kontraksi.
- 3) Pertimbangkan Operasi: Jika terjadi ketidaksesuaian panggul dan janin, intervensi dengan operasi caesar mungkin diperlukan. (ACOG, 2020; Cunningham et al., 2022).

b. Distosia (Kesulitan Progres Persalinan)

Penyebab: Dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian panggul (cephalopelvic disproportion), posisi janin yang tidak optimal, atau hipertonusitas kontraksi. Tanda dan Gejala: Progres persalinan yang sangat lambat atau terhenti meskipun kontraksi kuat.

Penanganan:

- 1) Penggunaan Forceps atau Vakum: Untuk membantu kelahiran bayi bila terjadi distosia pada kala I atau II.
- 2) Evaluasi Posisi Janin: Pemantauan posisi janin dengan USG untuk memastikan posisi janin yang ideal untuk melahirkan. (ACOG, 2020).

2. Komplikasi pada Kala II: Pengeluaran Bayi

Komplikasi pada kala II sering kali berkaitan dengan ketidakmampuan ibu untuk mendorong bayi keluar, atau ketidaknormalan posisi bayi yang dapat menghambat kelahiran.

Komplikasi:

a. Prolonged Second Stage (Stage II yang Terlambat)

Penyebab: kemungkinan disebabkan oleh ketidakmampuan ibu dalam mendorong, posisi janin yang tidak ideal, atau daya dorong ibu yang lemah. Tanda dan Gejala: Durasi tahap kedua lebih dari 2 jam pada primigravida dan lebih dari 1 jam pada multipara.

Penanganan:

- 1) Mengubah Posisi Ibu: Mendorong ibu untuk mencoba posisi yang berbeda seperti berjongkok atau miring untuk membantu penurunan janin.
- 2) Intervensi dengan Forceps atau Vakum: Bila ada tanda-tanda kelelahan ibu atau distosia, penggunaan alat bantu seperti forceps atau vakum untuk mempermudah kelahiran bayi.
- 3) Operasi Caesar: Jika terjadi ketidaksesuaian ukuran atau posisi bayi yang tidak bisa diatasi dengan intervensi konservatif.

b. Perdarahan Perineum dan Episiotomi

Penyebab: Robekan perineum atau episiotomi yang tidak sempurna. Tanda dan Gejala: Perdarahan berlebih pada daerah perineum setelah kelahiran bayi.

Penanganan:

- 1) Penjahitan: Setelah kelahiran, lakukan penjahitan segera pada robekan atau episiotomi yang terjadi untuk menghentikan perdarahan dan mencegah infeksi.
- 2) Pemantauan Perdarahan: Pemantauan secara ketat terhadap jumlah perdarahan serta tanda-tanda shock. (Simkin & Ancheta, 2017).

3. Komplikasi pada Kala III: Pengeluaran Plasenta

Pada kala III, komplikasi utama adalah risiko perdarahan yang berlebihan atau plasenta yang tertinggal setelah kelahiran bayi.

Komplikasi:

a. Retensio Plasenta (Plasenta Tertinggal)

Penyebab: Plasenta tidak terlepas dengan baik dari dinding uterus setelah kelahiran bayi, atau terjadi plasenta yang tidak lengkap. Tanda dan Gejala: Perdarahan berlebihan dan uterus yang lembek setelah kelahiran bayi.

Penanganan:

- 1) Manajemen Aktif Kala III: Berikan oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus dan memfasilitasi pemisahan plasenta.
- 2) Pembersihan Plasenta secara Manual: Jika plasenta tertinggal, prosedur pembersihan manual mungkin diperlukan.
- 3) Perawatan Perdarahan: Jika perdarahan berlebihan terjadi, transfusi darah atau prosedur bedah lainnya mungkin diperlukan. (*Cunningham et al., 2022*).

b. Perdarahan Postpartum (Postpartum Hemorrhage - PPH)

Penyebab: Atonia uteri, robekan pada saluran lahir, atau retensio plasenta. Tanda dan Gejala: Perdarahan yang berlebihan lebih dari 500 ml pada persalinan pervaginam atau lebih dari 1000 ml pada operasi sesar.

Penanganan:

- 1) Pemberian Oksitosin atau Obat Penghenti Perdarahan: Untuk merangsang kontraksi uterus.
- 2) Masa Observasi: Pemantauan ketat terhadap tanda vital ibu untuk mendeteksi tanda-tanda shock atau perdarahan lanjutan.
- 3) Pembedahan: Jika perdarahan tidak terkendali, prosedur seperti histerektomi mungkin diperlukan untuk menyelamatkan ibu. (*WHO, 2018; ACOG, 2020*).

4. Komplikasi pada Kala IV: Pemulihan Awal

Pada kala IV, risiko utama adalah infeksi dan perdarahan postpartum.

Komplikasi:

a. Infeksi Postpartum

Penyebab: Infeksi pada jalan lahir atau perineum akibat robekan, episiotomi, atau prosedur medis yang dilakukan. Tanda dan Gejala: Demam, pembengkakan atau kemerahan pada perineum, dan keluarnya nanah dari luka.

Penanganan:

- 1) Antibiotik: Berikan antibiotik sesuai indikasi untuk mencegah atau mengobati infeksi.
- 2) Pemantauan Luka: Pemeriksaan luka episiotomi atau perineum untuk tanda-tanda infeksi.
- 3) Kebersihan: Ajarkan ibu cara menjaga kebersihan perineum setelah melahirkan

b. Perdarahan Postpartum Lanjutan

Penyebab: Atonia uteri, sisa jaringan plasenta, atau gangguan pembekuan darah. Tanda dan Gejala: Perdarahan yang tidak terkontrol atau berlanjut lebih dari 24 jam setelah kelahiran.

Penanganan:

- 1) Pemberian Oksitosin: Untuk merangsang kontraksi uterus.
- 2) Pembedahan atau Transfusi: Untuk mengatasi perdarahan yang berat atau komplikasi lain seperti atonia uteri. (*ACOG, 2020; WHO, 2018*).

F. Pendidikan dan Promosi Kesehatan dalam Perawatan Persalinan Normal

Pendidikan dan promosi kesehatan merupakan bagian penting dari perawatan persalinan normal, yang tidak hanya membantu meningkatkan pengetahuan ibu hamil, tetapi juga berperan dalam memperkuat peran mereka dalam proses persalinan dan meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi. Pendidikan kesehatan yang efektif selama masa kehamilan dan persalinan dapat mencegah komplikasi, mempromosikan kesehatan ibu dan bayi, serta memperbaiki pengalaman persalinan. Bab ini akan menguraikan pentingnya pendidikan dan promosi kesehatan dalam perawatan persalinan normal, dengan fokus pada tiga aspek utama: pendidikan prenatal, pendidikan persalinan, dan promosi kesehatan setelah persalinan.

1. Pendidikan Prenatal

Pendidikan prenatal adalah intervensi utama dalam memastikan ibu hamil mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk proses persalinan dan perawatan pasca persalinan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pengetahuan yang diperlukan agar ibu dapat mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan dan mengetahui cara menjaga kesehatan dirinya dan janinnya.

Aspek yang Diajarkan:

- a. Pemantauan Kehamilan yang Sehat: Mengajarkan ibu untuk rutin memeriksakan kehamilan guna mendeteksi masalah sejak dini, seperti preeklamsia, diabetes gestasional, atau gangguan pertumbuhan janin.

- b. Pola Makan Sehat dan Nutrisi: Memberikan informasi tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang selama kehamilan, termasuk asupan asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin lainnya yang penting untuk kesehatan ibu dan janin.
- c. Aktivitas Fisik yang Aman: Mendidik ibu hamil tentang pentingnya aktivitas fisik yang aman dan sesuai untuk menjaga kebugaran tubuh serta mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan.
- d. Tanda-tanda Bahaya Kehamilan: Memberikan informasi tentang tanda-tanda komplikasi yang dapat muncul selama kehamilan, seperti perdarahan, sakit kepala berat, atau pembengkakan ekstremitas, dan kapan harus mencari pertolongan medis.

2. Pendidikan dan Persiapan Persalinan

Pendidikan tentang persalinan mempersiapkan ibu secara mental dan fisik untuk menghadapi persalinan. Pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan mempengaruhi keputusan ibu dalam memilih metode persalinan dan bagaimana mereka menghadapi proses tersebut.

Aspek yang Diajarkan:

- a. Tanda-tanda Persalinan: Mengajarkan ibu tentang bagaimana mengenali tanda-tanda persalinan, seperti kontraksi yang teratur, pecahnya ketuban, atau perdarahan, sehingga ibu dapat mempersiapkan diri untuk pergi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
- b. Pilihan Manajemen Rasa Sakit: Memberikan informasi mengenai berbagai pilihan manajemen rasa sakit selama persalinan, baik itu melalui obat-obatan seperti analgesik atau epidural, maupun pendekatan non-farmakologis seperti teknik relaksasi, pernapasan, dan penggunaan air hangat.
- c. Pendampingan Selama Persalinan: Memberikan dukungan tentang pentingnya adanya pendampingan selama persalinan (misalnya doula atau pasangan) yang dapat membantu ibu mengelola stres dan rasa sakit, serta meningkatkan pengalaman emosionalnya.
- d. Pemahaman tentang Prosedur Medis: Memberikan penjelasan tentang prosedur medis yang mungkin terjadi selama persalinan, seperti episiotomi, induksi persalinan, atau operasi caesar, untuk membantu ibu merasa lebih siap mental dan mengurangi kecemasan.

3. Promosi Kesehatan Pasca Persalinan

Setelah persalinan, ibu membutuhkan informasi yang jelas dan dukungan untuk memulihkan diri serta merawat bayi mereka. Ini mencakup pendidikan tentang perawatan diri ibu, perawatan bayi baru lahir, serta menjaga kesehatan mental ibu.

Aspek yang Diajarkan:

- a. Pemulihan Pasca Persalinan: Memberikan informasi tentang perawatan luka episiotomi, pemantauan perdarahan post-partum, serta latihan dasar untuk membantu pemulihan fisik ibu setelah melahirkan.
 - b. Perawatan Bayi Baru Lahir: Memberikan pengetahuan mengenai perawatan bayi baru lahir, seperti menyusui, cara merawat tali pusat, serta pentingnya imunisasi.
 - c. Kesehatan Mental Ibu: Mendidik ibu tentang tanda-tanda depresi postpartum dan pentingnya dukungan sosial. Ini penting untuk memastikan ibu menerima bantuan yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan mental mereka.
 - d. Kesehatan Keluarga: Memfokuskan pada pentingnya kesehatan keluarga, seperti perencanaan keluarga, kesehatan seksual, dan merawat bayi secara keseluruhan.
4. Media dan Teknologi dalam Pendidikan dan Promosi Kesehatan

Selain pendidikan tatap muka, penggunaan media dan teknologi dalam pendidikan kesehatan juga semakin penting. Dengan berkembangnya teknologi informasi, ibu hamil dapat mengakses berbagai sumber daya pendidikan yang bermanfaat.

Aspek yang Diajarkan:

- a. Platform Digital: Aplikasi kesehatan yang dapat memberikan informasi tentang kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, serta reminder untuk jadwal pemeriksaan.
- b. Media Sosial dan Grup Dukungan Online: Menggunakan media sosial sebagai tempat untuk berbagi pengalaman, dukungan sosial, dan pengetahuan terkait persalinan dan pemulihan pasca persalinan.

G. Simpulan

Persalinan normal adalah proses fisiologis yang membutuhkan pemahaman mendalam dari tenaga kesehatan serta kesiapan fisik dan mental dari ibu. Dalam buku ini, telah diuraikan berbagai aspek penting terkait persalinan normal, mulai dari karakteristik dan tahapan persalinan, asuhan keperawatan pada setiap kala persalinan, manajemen rasa sakit, hingga pencegahan komplikasi dan upaya pendidikan serta promosi kesehatan.

Pentingnya pendekatan holistik dalam perawatan persalinan normal menjadi fokus utama dalam memberikan asuhan yang tidak hanya mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga mendukung kenyamanan emosional serta kepuasan ibu selama proses persalinan.

H. Referensi

- Hodnett, E. D., Gates, S., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., & Weston, J. (2013). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (7).
- WHO. (2018). Recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization.
- Gupta, J. K., Sood, A., Hofmeyr, G. J., & Vogel, J. P. (2017). Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (5).
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2022). *Williams Obstetrics, 26th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Obstetric care consensus: Levels of maternal care.
- Friedman, E. A. (1954). The graphic analysis of labor. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 68(6), 1568-1575.
- Resnick, R., Greenspan, J., & Goodwin, T. (2021). *Normal and Problematic Newborn Adaptations*. New York: Elsevier.
- Smith, C. A., Collins, C. T., Cyna, A. M., & Crowther, C. A. (2018). Complementary and alternative therapies for pain management in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Simkin, P., & Ancheta, R. (2017). *The Labor Progress Handbook: Early Interventions to Prevent and Treat Dystocia*. New York: Wiley.
- Hawkins, J. L. (2010). Epidural analgesia for labor and delivery. *New England Journal of Medicine*, 362(16), 1503-1510.

CHAPTER 3

KELAHIRAN PREMATUR: IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN DAN PERAWATAN

Yuanita Ani Susilowati, M.Kep., Ns. Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan

Dunia kesehatan saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam menghadapi kelahiran bayi prematur. Kelahiran bayi prematur yaitu bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu atau kurang dari 9 bulan. Lebih dari 15 juta bayi lahir prematur di seluruh dunia setiap tahunnya. Di Indonesia sekitar 10% prevalensi kelahiran bayi prematur dari total kelahiran. Bayi lahir prematur menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi baru lahir. Bayi lahir prematur memiliki organ-organ vital yang belum sempurna, sehingga organ-organ tersebut belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Bayi lahir prematur rentan terhadap berbagai permasalahan antara lain, gangguan pernapasan seperti *respiratory distress syndrome* (RDS) yang terjadi karena belum sempurnanya pembentukan surfaktan, bayi prematur juga rentan terhadap berbagai infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna. Imaturitas pada berbagai sistem tubuh pada bayi prematur menyebabkan munculnya berbagai gangguan termasuk didalamnya gangguan dalam tumbuh kembang, bayi prematur berpotensi mengalami stunting (kegagalan tumbuh kembang). Penanganan bayi lahir prematur memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat mulai dari pendidikan kesehatan bagi masyarakat, deteksi dini, peningkatan layanan kesehatan ibu-anak, kemudahan akses layanan kesehatan yang pada akhirnya tercipta pembangunan berkesinambungan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat (Kemenkes 2018)

B. Kelahiran Bayi Prematur

Kelahiran bayi prematur didefinisikan sebagai kelahiran bayi setelah usia gestasi 20 minggu dan sebelum usia gestasi 37 minggu (Murray and McKinney 2013), (Kevin P Hanretty 2014). Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan angka kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 16,85 %, dan pada tahun 2021 Kemenkes menyebutkan angka kematian bayi yang disebabkan oleh prematuritas sebesar 84% (Mulyah, P; Aminatun, D; Septian 2020), (Shanti 2023). Prevalensi kelahiran

prematur di Indonesia menurut WHO dan UNICEF mencapai sekitar 10% dari total kelahiran. Bayi lahir prematur menjadi penyebab utama kematian bayi baru lahir dengan angka sebesar 27,6 % dan berisiko mengalami kejadian stunting (Kemenkes RI 2022), (SSGI 2023).

Kelahiran prematur disebut juga kelahiran kurang bulan. Bayi yang lahir secara prematur memiliki berat badan dibawah normal atau berat badan lahir rendah (BBLR), selain berat dan panjang yang belum optimal, demikian pula dengan organ-organ tubuh bayi yang belum berkembang secara sempurna antara lain paru-paru yang belum berfungsi sempurna karena pembentukan surfaktan yang belum adekuat menyebabkan bayi rentan mengalami *respiratory distress syndrome* (RDS) dan sistem kekebalan tubuh bayi yang belum optimal memungkinkan bayi mengalami berbagai infeksi. Bayi lahir prematur cenderung mengalami *cerebral palsy*, gangguan pada sistem pendengaran dan penglihatan. Bayi lahir prematur menjadi salah satu menyebabkan bayi mengalami kegagalan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), dengan demikian bayi yang lahir prematur membutuhkan dukungan perawatan yang memadai agar bayi dapat bertahan hidup dan berkembang dengan baik. Bayi lahir prematur tidak sedikit yang membutuhkan perawatan intensif (*Neonatal intensive care unit* / NICU) dengan rentang waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan, dengan demikian bayi lahir prematur membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Bayi lahir prematur juga menjadi beban psikologi bagi kedua orang tua, karena selalu was-was akan keberlangsungan hidup buah hati mereka (Murray and McKinney 2013).

Klasifikasi Persalinan Prematur Menurut Kejadia Kelahiran:

- Spontan atau idiopatik, yaitu persalinan prematur yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya, terdapat sekitar 50 % persalinan prematur tanpa sebab yang pasti, dan sekitar 12,5% kelahiran prematur karena ketuban pecah dini.
- Elektif / Iatrogenik, yaitu persalinan prematur yang disengaja atau persalinan elektif *preterm* yang bertujuan menyelamatkan ibu dan bayi.

1. Menurut Usia Kehamilan digolongkan menjadi 3 yaitu:

- a. Kurang bulan/*Preterm*, yaitu usia kehamilan 32 minggu sampai kurang dari 37 minggu.
- b. Sangat kurang bulan/ *Very Preterm*, yaitu kelahiran bayi pada usia gestasi 28 minggu sampai usia gestasi kurang dari 32 minggu.
- c. Ekstrem kurang bulan/*Extremely Preterm* yaitu usia gestasi kurang dari 28 minggu (Yuniwiyati, Wuryanto, and Yuliawati 2023).

2. Menurut Berat Badan Lahir dikelompokkan menjadi:
 - a. Berat Bayi lahir Rendah (BBLR) yaitu bayi yang dilahirkan memiliki berat badan antara 1500 gram sampai dengan 2500 gram.
 - b. Berat Bayi lahir sangat rendah yaitu bayi yang dilahirkan dengan berat badan 1000 gram sampai 1500 gram.
 - c. Berat Bayi ekstrim rendah yaitu, bayi yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 1000 gram, (Herman 2020).

C. Identifikasi Penyebab Kelahiran Prematur

Penyebab kelahiran bayi prematur terbagi atas :

1. Kondisi Kesehatan Ibu:

- a. Hipertensi dalam Kehamilan,

Hipertensi yang berkembang menjadi preeklamsi dan eklamsi sering kali menjadi penyebab terjadinya kelahiran prematur, karena kehamilan harus diterminasi melalui operasi caesar yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan janin yang dikandungnya (Akri and Yunamawan 2019), (Herman 2020).

- b. Perdarahan Ante Partum

Perdarahan yang disebabkan karena letak plasenta pada jalan lahir (plasenta previa) mengharuskan dokter untuk melakukan terminasi kehamilan mana kala perdarahan semakin sering terjadi seiring pertumbuhan janin, demikian pula halnya dengan perdarahan yang disebabkan oleh solusio plasenta yang mengakibatkan terjadinya gawat janin merupakan kondisi emergency untuk segera dilakukan terminasi kehamilan demi menyelamatkan ibu dan janin (Herman 2020).

- c. Korioamnionitis

Infeksi pada air ketuban dan plasenta dapat menyebabkan kejadian bayi lahir prematur, meskipun korioamnionitis dari hasil penelitian tidak berhubungan dengan kejadian sepsis neo natal awitan dini (Sari et al. 2023).

- d. Penyakit Sistemik

Berbagai penyakit sistemik yang berat (penyakit jantung, penyakit autoimun, ,penyakit ginjal, diabetes dll). Seseorang yang menderita penyakit sistemik tersebut seringkali mengalami insufisiensi organ, aliran darah ke janin tidak adekuat, sehingga janin tidak dapat tumbuh dengan optimal dan terjadi kelahiran prematur.

2. Kondisi Kesehatan Janin terbagi atas:

- a. Gawat janin, gawat janin dapat disebabkan oleh berbagai keadaan antara lain hipoksia, asidosis, anemia atau gangguan jantung janin.

- b. Janin yang mengalami infeksi (Infeksi intra uterine) menjadi salah satu penyebab terjadinya prematuritas.
 - c. *Intra uterine growth restriction* (IUGR) menjadi salah satu penyebab kelahiran bayi prematur.
 - d. Isoimunisasi rhesus dengan istilah lainnya sensitisasi Rh, yaitu ketika ibu hamil memiliki rhesus negatif, membentuk antibody terhadap protein rhesus sel darah merah janin, terjadi ketidak cocokkan rhesus disebut juga penyakit hemolitik, sel darah merah janin rusak, dapat terjadi komplikasi anemia berat, gagal jantung dan kerusakan otak (Hikma, Mutholib, and Garini 2021).
 - e. Lilitan tali pusat istilah lainnya *cord entanglemen* yaitu tali pusat bayi melilit tubuh bayi, lilitan dapat terjadi pada leher, badan juga ekstremitas janin. Lilitan yang terlalu kuat terlebih pada daerah leher dapat menyebabkan kematian janin (IUFD).
3. Faktor Risiko Terjadinya Kelahiran Prematur
- a. Ibu yang merokok meningkatkan risiko kelahiran prematur, nikotin yang dihisap, memicu terjadinya vaso konstriksi dan meningkatkan kadar karbon monoksida pada darah, sekitar 20 % merokok menyebabkan terjadinya kelahiran prematur.
 - b. Infeksi saluran kemih dan infeksi genital dapat memicu terjadinya kelahiran prematur. Beberapa jenis bakteri yang dapat memicu terjadinya infeksi intra uterin antara lain mycoplasma spp, streptococcus, fusobacterium dan enterobacteria.
 - c. Ibu mengalami malnutrisi dengan body mass index (BMI) kurang dari 8,5 kg/m², gangguan pola makan/ asupan nutrisi yang tidak adekuat eningkatkan risiko kelahiran prematur.
 - d. Kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan organ reproduksinya belum matang sempurna, pola makan yang tidak sehat, merokok dan terkadang menggunakan obat terlarang.
 - e. Kehamilan ganda, pada kehamilan kembar dua cenderung lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, kehamilan kembar tiga, bayi lahir sebelum usia kehamilan 35 minggu (Hayashi 2020).

D. Pencegahan Kelahiran Prematur:

1. Sebelum hamil dilakukan deteksi dini terhadap kejadian anemia dan infeksi saluran kemih juga infeksi genital. Bila kadar hemoglobin rendah perlu dikoreksi terlebih dahulu sebelum hamil, demikian pula bila terdapat infeksi saluran kemih atau infeksi genital, maka perlu dilakukan pengobatan dengan pemberian antibiotik sampai tuntas terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk hamil.

2. Setelah hamil, perlu melakukan kunjungan *antenatal care* (ANC) sekurang-kurangnya sebanyak enam (6) kali selama hamil sesuai anjuran dari Kementerian Kesehatan RI. Pada saat kunjungan ANC tersebut, kesejahteraan ibu dan janin akan dipantau dengan seksama, sehingga bila didapatkan kelainan atau pertumbuhan janin yang tidak optimal dapat segera diatasi.
3. Konsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia dan pemberian asam folat untuk pertumbuhan janin, makan makanan bergizi, bila perlu konsultasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah asupan nutrisi yang dibutuhkan. Ibu yang mengalami malnutrisi atau kekurangan energi kronik (KEK) dapat diberikan makanan tambahan dan pemantauan berat badan Ibu.
4. Manajemen stress yang baik, hindari minum minuman keras, hindari merokok, tidak hamil ketika sudah cukup umur (lebih dari 35 tahun), menjaga kebersihan genital untuk mencegah infeksi genital dan saluran kemih.
5. Peningkatan akses layanan kesehatan sebagai upaya pencegahan kelahiran prematur (Hayashi 2020), (Yundri et al. 2017), (Cetinkaya and Kusdemir 2018).

E. Perawatan Bayi Prematur

Perawatan bayi prematur merupakan upaya melalui berbagai tindakan untuk memfasilitasi bayi lahir kurang bulan dapat hidup di ekstra uteri. Mengingat bayi kurang bulan memiliki risiko mengalami berbagai komplikasi dikarenakan organ-organ tubuh belum matur sempurna. Memperhatikan kondisi tersebut, sehingga diperlukan berbagai upaya baik oleh petugas kesehatan, masyarakat dan keluarga pada khususnya.

Agar dapat merawat bayi prematur dengan baik, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan dilakukan, komponen tersebut yaitu:

- **Pengaturan Suhu Tubuh**

Bayi lahir prematur belum mampu mengatur suhu tubuhnya, termoregulator belum berfungsi sempurna dan kulit tubuhnya masih sangat tipis sehingga kemampuan untuk menyesuaikan suhu dengan lingkungan belum mampu, dengan demikian bayi prematur sangat berisiko mengalami hipotermi. Untuk menjaga suhu tubuh agar stabil, bayi yang lahir prematur perlu dirawat dalam incubator dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan usia gestasinya (Fath Irtaniyah R, Emy Febrianti Kahar, and Suhartati 2023)

- **Pemberian Nutrisi,**

Bayi lahir prematur dapat diberikan ASI, karena ASI merupakan makanan terbaik dan menurunkan kejadian infeksi saluran cerna dan saluran pernapasan, namun bila bayi mengalami kondisi yang menyebabkan kontra indikasi terhadap

ASI, bayi dapat diberikan susu formula khusus dengan kandungan nutrisi menyerupai ASI (Rohsiswatmo and Amandito 2020).

- Dukungan Pernapasan

Bayi lahir prematur, membutuhkan dukungan alat bantu napas, bayi prematur cenderung mengalami henti napas (apnea) periodik sehingga perlu alat bantu napas (ventilator) yang siap pakai (District 2013))

- Pencegahan dan Penanganan Infeksi,

Pencegahan infeksi dapat dilakukan sejak janin ada dalam kandungan ibu antara lain menjaga kebersihan genital dan saluran kemih, saat bayi lahir prematur diusakan dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menolong persalinan dengan teknik steril, memotong tali pusat dengan alat yang steril, pemberian ASI, dan menjaga lingkungan yang bersih (Rohsiswatmo and Amandito 2020).

- Pemantauan Kesehatan

Bayi lahir prematur rentan terhadap gangguan kesehatan sehingga penting adanya pemantauan secara periodik kondisi kesehatannya antara lain: Pemantauan pertumbuhan fisik (Berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, fungsi pernapasan, fungsi jantung, kemampuan makan/minum, kemampuan pengaturan suhu dll) (Rohsiswatmo and Amandito 2020), (Fadlalmola and Mohammed 2020).

- Stimulasi Perkembangan

Bayi lahir prematur meskipun dirawat dalam incubator, bayi tetap berhak mendapat sentuhan ibunya, karena sentuhan dan suara ibu yang lembut tersebut akan mestimulasi perkembangan otak dan emosional bayi dengan demikian penting melibatkan ibu dalam perawatan bayi prematur dalam incubator (Mariyana 2018)(Rohsiswatmo and Amandito 2020).

1. Perawatan Bayi Prematur di Layanan Kesehatan

Bayi lahir prematur memerlukan berbagai dukungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di Rumah Sakit, bayi lahir prematur dirawat di ruang *neonatal intensif care unit* (NICU) dengan jangka waktu menyesuaikan dengan kondisi bayi tersebut. Dukungan bagi bayi prematur di Rumah Sakit antara lain:

a. Pengaturan suhu

Di ruang NICU, bayi dirawat dalam incubator yang memiliki spesifikasi pengaturan suhu tubuh bayi, karena bayi prematur belum mampu mengatur suhu tubuhnya dikarenakan termoregulatornya belum berfungsi sempurna dan lapisan lemak tubuh untuk menjaga suhu tubuh belum adekuat. Incubator

juga berfungsi melindungi bayi terhadap infeksi (Fath Irtaniyah R, Emy Febrianti Kahar, and Suhartati 2023).

b. Dukungan pernapasan

Bayi lahir prematur mempunyai paru-paru yang belum berfungsi sempurna, bayi cenderung mengalami *respiratory distress syndrome* (RDS) dikarenakan cairan surfaktan belum terbentuk secara adekuat. Bayi lahir prematur membutuhkan dukungan pernapasan seperti oksigen, *continuous positive airway pressure* (CPAP) atau ventilator mekanik (Hendrawatia et al. 2024).

c. Dukungan nutrisi

Bayi prematur membutuhkan asupan nutrisi untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya. Air susu ibu (ASI) tetap menjadi pilihan utama karena ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi, ASI juga mengandung anti body sehingga meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Bila terdapat kontra indikasi pemberian ASI, maka bayi prematur diberi susu formula khusus yang kandungannya mirip ASI. Bayi prematur cenderung belum mampu untuk menghisap puting susu dan menelan ASI atau susu formula dengan sempurna, sehingga pemberian nutrisi pada bayi prematur perlu dipertimbangkan dengan seksama. Ada dua cara pemberian nutrisi pada bayi prematur yaitu secara:

- 1) Enteral melalui *naso gastric tube* (NGT) atau *oro gastric tube* (OGT). ASI atau susu formula khusus diberikan melalui selang NGT atau OGT langsung menuju lambung, dengan gaya gravitasi atau dengan *syirink pum*.
- 2) Parenteral, nutrisi dalam bentuk cairan infus diberikan melalui pembuluh darah yang sudah dipasang iv chateter.

Berikut ketentuan pemberian nutrisi bagi bayi prematur menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) (IDAI 2016)

Tabel 3.1: Rute Pemberian Nutrisi pada Bayi Prematur

Usia kehamilan	Kematangan fungsi oral	Rute pemberian nutrisi
<28 minggu	- Refleks mengisap belum ada - Gerak dorong usus belum ada	Parenteral
28-31 minggu	- Refleks menghisap payudara mulai ada - Belum ada koordinasi antara mengisap, menelan dan bernapas	<i>Orogastric tube</i> atau <i>nasogastric tube</i> Sesekali dengan <i>nipples</i>
32-34 minggu	- Refleks mengisap hampir matang - Koordinasi antara mengisap, menelan dan bernapas mulai ada	dengan <i>nipples</i>
>34 minggu	- Refleks mengisap telah matang - Koordinasi mengisap, menelan dan bernapas telah terbentuk sempurna	Menyusu

Dimodifikasi dari: Sankar dkk. (2008)

Bagan di sadur dari Konsensus Asuhan Nutrisi pada bayi prematur (IDAI, 2016).

- 3) Pengaturan jumlah kalori disesuaikan dengan berat badan dan usia bayi prematur, berikut panduan pemberian nutrisi bagi bayi prematur, disadur dari konsensus asuhan nutrisi pada bayi premature Ikatan Dokter Anak Indonesia th.2016 (IDAI 2016)

Tabel 3.2: Frekuensi dan Volume Nutrisi Enteral Bayi Prematur²⁸

	BBLASR	BBLSR
Jenis cairan	ASI	ASI
Mulai	6-48 jam pertama	6-48 jam pertama
<i>Minimal enteral feeding</i> (MEF)	0,5 ml/kg/jam atau 1 ml/kg/2 jam	1 ml/kg/jam atau 2 ml/kg/2jam
Durasi MEF	1-4 hari	1-4 hari
Peningkatan minum	15-25 ml/kg/hari	20-30 ml/kg/hari
<i>Continues feeding</i>	+0,5 ml/kg/jam tiap 12 jam	+1 ml/kg/jam tiap 8 jam
<i>Intermittent feeding/ 2 jam</i>	+1 ml/kg/jam tiap 12 jam	+1 ml/kg/jam tiap 8 jam
HMF	Sebelum 100 ml/kg/hari	Sebelum 100 ml/kg/hari
Target energi	110-130 kkal/kg/hari	110-130 kkal/kg/hari
Target asupan protein	4-4,5 g/kg/hari	3,5-4 g/kg/hari

Dikutip dari: Koletzko dkk. (2005)

(Arum and Riana 2021), (Rohsiswatmo and Amandito 2020)

d. Pemantauan Kondisi Bayi

Bayi lahir prematur perlu di pantau secara ketat tanda-tanda vitalnya, antara lain detak jantung, suhu tubuh, tekanan darah, pernapasan dan saturasi oksigen. Bayi prematur yang dalam keadaan kritis tanda vitalnya dimonitor menggunakan *bedside monitor*, sehingga bila terjadi perubahan yang ekstrim alarm pada *bedside monitor* akan berbunyi. Bayi prematur dalam kondisi stabil monitoring tanda vital dapat dilakukan setiap 2-4 jam, sedangkan pemantauan berat badan dilakukan setiap hari pada jam yang sama (Fath Irtaniyah R, Emy Febrianti Kahar, and Suhartati 2023).

e. Persiapan Kepulangan Bayi Prematur

Bayi prematur yang dirawat di ruang NICU, saat akan dipulangkan, maka keluarga/orang tua harus dilatih terlebih dahulu tentang perawatan bayi prematur dirumah. Mereka perlu diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat dan tidak mengalami hipotermi, diajarkan bagaimana cara mengukur suhu tubuh bayi, jadwal pemberian ASI, dan mengenali tanda-tanda bahaya pada bayinya dan segera membawa bayi ke sarana/layanan kesehatan bila didapati tanda bahaya pada bayinya (Rohsiswatmo and Amandito 2020).

2. Perawatan bayi premature dirumah

Seorang ibu yang ingin merawat bayi prematur di rumah, perlu berlatih terlebih dahulu di Rumah Sakit sebelum bayi dibawa pulang, disamping itu keluarga juga harus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan bayi saat dirumah nanti. Berikut yang perlu disiapkan untuk merawat bayi prematur dirumah:

a. Pemantauan suhu tubuh

Ciptakan lingkungan rumah yang bersih, dan nyaman dengan suhu ruangan berkisar antara 22-26 °C. Bayi dikenakan pakaian yang hangat, nyaman, dan diberi selimut. Monitor suhu tubuh bayi menggunakan thermometer setidaknya dua (2) kali sehari, catat hasil pengukuran suhu bayi dan segala penemuan yang terjadi di catat misalnya bayi tampak gelisah, rewel, tidak mau menyusu/minum dll. Catatan tersebut dibawa dan diperlihatkan ke dokter/perawat saat membawa bayi kontrol ke Rumah Sakit.

b. Pemberian nutrisi.

Nurisi terbaik bagi bayi prematur adalah ASI, namun bila tidak dimungkinkan untuk pemberian ASI, maka bayi dapat diberikan susu formula khusus bagi bayi prematur. Pemberian ASI atau susu formula hendaknya diberikan antara 8 – 10 kali dalam satu hari, jarak menyusu tidak boleh lebih dari 4 jam karena bayi dapat mengalami dehidrasi.

c. Posisi tidur dan jadwal tidur

Bayi prematur membutuhkan waktu tidur lebih banyak dibandingkan dengan bayi cukup bulan, bayi prematur menggunakan sebagian besar waktunya untuk tidur. Posisi tidur bayi prematur sebaiknya bayi pada posisi terlentang, pada kasur yang keras dan rata, tanpa bantal, tanpa selimut dan jangan meletakkan mainan dekat bayi. Bayi prematur dapat mengalami syndrome kematian bayi mendadak (*sudden infant death syndrome* /SIDS) sehingga perlu dilakukan monitoring ketat secara periodik terhadap pernapasan dan detak jantungnya.

d. Pemantauan kesehatan dan imunisasi

Bayi prematur sangat rentan terhadap kondisi kesehatan, sehingga perlu monitoring kesehatan secara berkala, agar meminimalkan bayi terpapar oleh penyakit termasuk terpapar *respiratory syncytial virus* (RSV) penyebab flu pada bayi prematur, maka keluarga dapat berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk melakukan home care, monitoring peningkatan berat badan bayi dan pemberian vaksin RSV. Awasi perkembangan motorik dan kognitif bayi, bila perlu konsultasi pada dokter anak atau perawat spesialis anak.

e. Buat aturan di rumah.

Aturan sebelum menyentuh bayi harus mencuci tangan, tidak membawa bayi pada kerumunan (area publik), membatasi pengunjung, dan melarang orang yang sedang flu/batuk dan penyakit penular lainnya mendekati atau menyentuh bayi, bila ada anggota keluarga yang batuk atau pilek harus menggunakan masker (Fuchs 2015), (Cetinkaya and Kusdemir 2018), (Simanjuntak, R., & Anggraeni 2019).

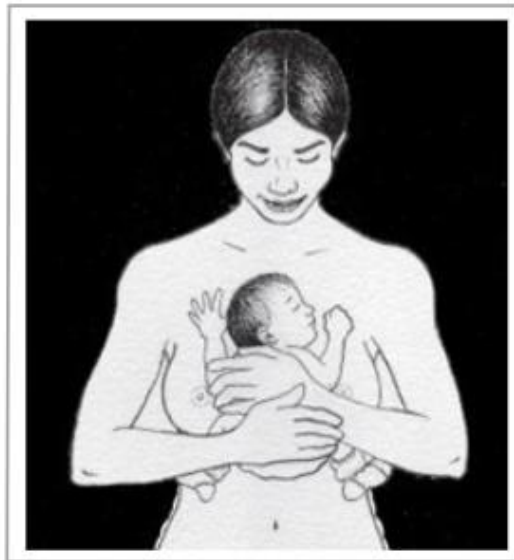
3. Perawatan Bayi Prematur Menggunakan Metode Kanguru Mother Care

Kanguru mother care (KMC), merupakan salah satu metode perawatan bayi prematur secara konvensional, dengan memanfaatkan panas tubuh dari ibu/ayah/pengasuh untuk menjaga suhu tubuh bayi prematur agar tetap stabil, mengingat bayi prematur rawan terhadap kejadian hipotermi. Metode *kanguru mother care* dilakukan selama 24 jam berturut-turut. Atau secara intermiten dalam jangka waktu tertentu.

a. Komponen dalam *kanguru mother care* yaitu:

1) Posisi kanguru (*skin to skin contact*)

Ibu dan bayi pada posisi vertical (tegak), bayi berada diantara kedua payudara ibu dan didalam pakaian ibu, cara tersebut dapat dilakukan pula oleh ayah bayi atau pengasuh bayi tersebut. *Kanguru mother care* sudah dimulai sejak bayi masih dalam perawatan di Rumah Sakit dan diteruskan saat perawatan dirumah.



Kangaroo Position

(Taken from the "Practical guideline for the Kangaroo care method" WHO)

Disadur dari (Enouk 2012)

Gambar 3.1: Posisi Kanguru



Disadur dari (Enouk 2012)

Gambar 3.2: Posisi Kanguru

2) Dukungan ASI Eksklusif.

Kanguru mother care dapat memfasilitasi pemberian ASI secara eksklusif, mengingat bayi berada di antara kedua payudara ibu, sehingga mudah bagi ibu langsung memberikan ASI pada bayinya.

3) Menurunkan LOS di Rumah Sakit

Length of Stay atau lama rawat bayi di Rumah Sakit dapat lebih singkat dan bayi dapat cepat pulang dari Rumah Sakit, karena ibu dan keluarga sudah mampu merawat bayi prematur secara mandiri.

4) Keterlibatan Anggota Keluarga

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk terus melaksanakan program *kanguru mother care* di rumah, dan pastikan ada kemudahan akses emergency bila bayi mengalami kegawat daruratan.

b. Kontra Indikasi KMC

- 1) Bayi dengan tanda vital yang tidak stabil termasuk tekanan darah yang tidak stabil
- 2) Bayi yang mengalami hipotremia
- 3) Bayi dengan bradikardi, data jantung kurang dari 85 kali/menit
- 4) *Periodic apnea* lebih dari 10 detik dengan saturasi oksigen kurang dari 85%,
- 5) Apnormalitas gas darah
- 6) Penggunaan obat-obat vasopressor
- 7) Perdarahan intra cranial derajat 3-4
- 8) Cardiorespiratory arrest
- 9) Gangguan neurologi, lethargy dan hypotonia berat
- 10) Baru saja selesai operasi
- 11) Kondisi kesehatan ibu tidak stabil, baik fisik maupun mental
- 12) Ibu menderita penyakit menular

c. Keuntungan Metode *Kanguru Mother Care*

1) Mencegah hipotermi dan menjaga suhu tubuh bayi stabil

Skin to skin contact pada metode kanguru memfasilitasi bayi untuk mempertahankan suhu tubuhnya, suhu tubuh ibu/ayah/ pengasuh yang melakukan KMC akan ditransfer atau dialirkan ke tubuh bayi, dengan demikian bayi akan tetap merasa hangat.

2) Menjaga pernapasan dan detak jantung bayi agar tetap stabil

Detak jantung ibu adalah suara yang pertama kali didengar oleh bayi, dan selama dalam kandungan ibu, bayi akan terus mendengar detak jantung ibu tersebut. Detak jantung ibu membuat bayi merasa aman dan nyaman dengan demikian detak jantung bayi dan pernapasannya akan teratur.

3) Meningkatkan bonding (ikatan) antara ibu dan bayi

Berada di dada ibu dengan kulit yang bersentuhan membuat bayi merasa nyaman, demikian juga ibu/ayah yang meletakkan bayi di dadanya merasa semakin sayang dan semakin ingin melindungi dan memfasilitasi kenyamanan bayi, dengan demikian ikatan batin (bonding) antara bayi dan kedua orang tuanya semakin erat.

4) Mendukung pemberian ASI eksklusif

ASI merupakan nutrisi sempurna bagi bayi, melalui metode *kanguru mother care* bayi dapat menyusu kapanpun dia mau, demikian pula dari sisi ibu, dapat dengan mudah menyusui bayinya secara langsung

5) Memfasilitasi kenaikan berat badan bayi

Bayi yang merasa nyaman dan aman akan menyusu dengan baik, energi yang dikeluarkan minimal, sehingga asupan nutrisi akan lebih banyak disimpan dan meningkatkan masa otot, dengan demikian berat badan bayi akan cepat bertambah.

6) KMC sangat di rekomendasikan untuk dilakukan sesegera mungkin, saat bayi masih berada dalam perawatan di Rumah Sakit, selama tidak ada kontra indikasi.

(Bailey 2012), (Enouk 2012), (Siagian, Pujiati, and Sinaga 2021), (world health organization 2023), (Inni Khozaimah, Munir, and Tauriana 2024).

F. Simpulan

Bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, terbagi tiga yaitu: bayi lahir kurang bulan, sangat kurang bulan dan ekstrim kurang bulan. Menurut berat badannya dikelompokkan menjadi berat bayi lahir rendah, berat bayi lahir sangat rendah dan berat bayi lahir ekstrim rendah. Ada beberapa penyebab terjadinya kelahiran prematur antara lain, ibu menderita hipertensi, perdarahan dan penyakit sistemik, sedangkan faktor janin yang dapat menyebabkan kelahiran prematur antar lain lilitan tali pusat, IUGR dan infeksi intra uterine, sedangkan faktor predisposisi terjadinya kelahiran prematur yaitu ibu perokok, malnutrisi, infeksi saluran kemih dan atau genital. Kelahiran prematur dapat dicegah dengan kunjungan rutin ke layanan kesehatan saat dinyatakan hamil, deteksi dini kejadian anemia, konsumsi tablet tambah darah, makan makanan bergizi dan menghindari rokok, minuman keras dan obat-obatan terlarang. Perawatan bayi prematur dapat dilakukan di Rumah Sakit di ruang NICU dengan menggunakan incubator, dirawat dirumah bila kondisi bayi sudah stabil dan mau untuk menyusu, selain itu bayi prematur juga dapat dirawat menggunakan metode

kanguru baik di Rumah Sakit maupun dirumah dengan terlebih dahulu ibu, ayah dan pengasuh dari bayi tersebut, mengikuti training cara melakukan *kanguru mother care*. Perawatan bayi prematur yang utama yaitu mempertahankan suhu tubuh bayi, mencegah hipotermi, pemberian nutrisi yang adekuat, pemantauan berat badan dan kondisi kesehatan bayi.

G. Referensi

- Akri, Yusnita Julyarni, and Donny Yunamawan. 2019. *STUDI TENTANG USIA IBU, PARITAS, RIWAYAT HIPERTENSI DAN POLA ISTIRAHAT TERHADAP KEJADIAN PREEKLAMSI Di PUSKESMAS SUKODONO LUMAJANG*.
- Arum, W Anita, and S Shinta Riana. 2021. "Tatalaksana Pemberian Nutrisi Pada Bayi Prematur Untuk Mencapai Tumbuh Kembang Yang Optimal." *Seminar Nasional Riset Kedokteran 2 (SENSORIK)* 2: 194–201.
- Bailey, Sarah. 2012. "Kangaroo Mother Care." *British Journal of Hospital Medicine* 73(5): 278–81.
- Cetinkaya, Senay, and Sibelt Kusdemir. 2018. "A Premature Baby's Nursing Care Plan." *Open Journal of Obstetrics and Gynecology* 08(05): 437–45.
- District, Health south Eastern Sydney Local Health. 2013. "Newborn Care Center, The Royal Hospital for Women. Apnea Prematuritas." : 2–4.
- Enouk. 2012. "Kangaroo Mother Care Training Manual." *Federal Ministry of Health of Nigeria* (November): 1–265.
- Fadlalmola, Hammad, and Amal Mohammed. 2020. "Nurse's Knowledge and Practice on the Care of Preterm Infants at Khartoum State Hospitals." *Sudan Journal of Medical Sciences* 15(2): 184–94.
- Fath Irtaniyah R, Emy Febrianti Kahar, and Suhartati. 2023. "Studi Kasus Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Kasus Premature Di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari Tahun 2022." *Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Avicenna* 2(1): 1–7.
- Fuchs, Lynn M. 2015. "Taking Your Preemie Home." *KidsHealth*. <https://kidshealth.org/en/parents/preemie-home.html>.
- Hayashi, Masako. 2020. "Prevention and Management of Preterm Birth." *Nihon Ika Daigaku Igakkai Zasshi* 16(3): 138–43.
- Hendrawatia, Sri et al. 2024. "Terapi Oksigen Untuk Pencegahan Hipoksia Pada Bayi Prematur Di Neonatal Intensive Care Unit: Sebuah Narrative Review." *Jurnal Keperawatan Cikini* 5(2): 252–65.
- Herman, Sriyana Joewono T Hermanto. 2020. "Buku Acuan Persalinan Kurang Bulan (Prematur) 1." *Buku Acuan Persalinan Kurang Bulan (Prematur)*: 1–219.
- Hikma, Elfa Nur, Abdul Mutholib, and Ardiya Garini. 2021. "Abo and Rhesus Blood

- Group Distribution Among Indegeous People in South Sumatera." *Journal of Medical Laboratory and Science* 1(1): 16–21.
- IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2016. "Konsensus Asuhan Nutrisi Pada Bayi Prematur." *Konsensus und Interessen*: 15–88.
- Inni Khozaimah, Putri, Zainal Munir, and S. Tauriana. 2024. "Penerapan Terapi Metode Kangaroo Mother Care (KMC) Pada Bayi V Dengan Kasus BBLR Pada Diagnosa Hipotermia Di Ruang Peristi Bayi RSUD Sidoarjo." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 5(1): 56–65.
- Kemenkes. 2018. *Riskesdas*.
- Kemenkes RI. 2022. "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022." *Kemenkes*: 1–150.
- Kevin P Hanretty. 2014. *Ilustrasi Obstetri*. Ketujuh. eds. Santoso Budi Iman and Muliawan Elysabeth.
- Mariyana, Rina. 2018. "Riwayat Prematur Dengan Tumbuh Kembang Anak Usia Satu Tahun." *Human Care Journal* 3(3): 183.
- Muliyah, P; Aminatun, D; Septian, S dkk. 2020. "Angka Kematian Bayi (IMR) Menurut Provinsi." *Journal GEEJ* 7(2): 2020.
- Murray, Sharon Smith, and Emily Slone McKinney. 2013. *Foundations of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing-e-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Rohsiswatmo, Rinawati, and Radhian Amandito. 2020. "Optimalisasi Pertumbuhan Bayi Prematur Dan Pasca Prematur Di Indonesia; Mengacu Pada Pedoman Nutrisi Bayi Prematur Di RSCM." *Sari Pediatri* 21(4): 262.
- Sari, Devita et al. 2023. "Korioamnionitis Sebagai Prediktor Sepsis Neonatus Awitan Dini Pada Bayi ≤ 32 Minggu Atau Bayi Berat Lahir ≤ 1500 Gram = Chorioamnionitis as a Predictor of Early Onset Neonatal Sepsis in Infants $\hat{=}$ $\% \hat{=}$ 32 Weeks or Birth Weight $\hat{=}$ $\% \hat{=}$ 1500 Grams."
- Shanti, Hreeloita Dharma. 2023. "Kemenkes: Kematian Bayi Di Indonesia 84 Persen Akibat Lahir Prematur." *Antaranews.com* (September): 2021.
- Siagian, Yusraini, Wasis Pujiati, and Martina Indah Sinaga. 2021. "Pengaruh Metode Kanguru Terhadap Peningkatan Berat Badan Pada Bayi BBLR." *Jurnal SMART Kebidanan* 8(2): 136.
- Simanjuntak, R., & Anggraeni, L. D. 2019. "Pengalaman Ibu Dalam Merawat Bayi Prematur Di Rumah. Jurnal Keperawatan BSI, 7(1), 21–31." 7(2): 21–31.
- SSGI. 2023. "Hasil Survei Status Gizi Indonesia." *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*: 77–77. <https://promkes.kemkes.go.id/materi-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2022>.

world health organization. 2023. 73 British Journal of Hospital Medicine *Kangaroo Mother Care Implementation Strategy for Scale-up Adaptable to Different Country Contexts*.

Yundri, Yundri et al. 2017. "Faktor-Faktor Risiko Status Imunisasi Dasar Tidak Lengkap Pada Anak (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas II Kuala Tungkal)." *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas* 2(2): 78.

Yuniwiyati, Hanik, Moh Arie Wuryanto, and Sri Yuliawati. 2023. "Beberapa Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur (Studi Persalinan Prematur Di RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara)." *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat* 3(1): 8–22.

H. Glosarium

ANC	= Ante Natal Care
BBLR	= Berat Bayi Lahir Rendah
CPAP	= Continuous Positive Airway Pressure
IUFD	= Intra Uterine Fetal Death
IUGR	= Intra Uterine Growth Restriction
IV Chateter	= Intra Vena Chateter
NICU	= Neonatal Intensive Care Unit
RDS	= Respiratory Distress Syndrome
Rh	= Rhesus

CHAPTER 4

PERSALINAN DAN KESEHATAN MENTAL IBU: MENINGKATKAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Apri Nur Wulandari, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

A. Pendahuluan

Persalinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seorang perempuan. Dalam proses ini terjadi kelahiran bayi dan plasenta dari rahim ke dunia luar. Kondisi ini merupakan masa yang kritis karena tidak hanya terjadi perubahan secara fisik, akan tetapi juga terjadi perubahan secara fisiologis, hormonal, dan emosional atau psikologis yang signifikan pada ibu (Valadares et al., 2020). Sebagian besar penatalaksanaan kehamilan dan persalinan berfokus pada aspek kesehatan fisik ibu dan bayi. Sedangkan aspek psikologis atau kesehatan mental ibu sering kali diabaikan dalam perawatan kesehatan ibu secara rutin (Jungari, 2024).

Kesehatan mental ibu di Indonesia menjadi perhatian yang signifikan. Faktor biologis, psikologis, dan lingkungan termasuk perubahan hormonal, dan tekanan dari masyarakat berkontribusi terhadap kerentanan wanita selama periode perinatal (Valadares et al., 2020). Berbagai penelitian menyoroti prevalensi dan dampak gangguan mental pada ibu hamil dan pasca persalinan. Kesehatan mental ibu melibatkan kondisi seperti depresi post partum, kecemasan, dan stres yang secara signifikan dapat berdampak pada ibu dan anak (Handa et al., 2024). Gangguan kesehatan mental yang umum terjadi pada ibu adalah depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan psikosis nifas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan dampak yang parah jika tidak terdeteksi dan dikelola dengan cepat (Chilaka & Muriithi, 2021). Jungari (2024) menyebutkan bahwa masalah kesehatan mental ibu berkontribusi terhadap penurunan kualitas hidup, keterlambatan tumbuh kembang anak, dan beban keuangan.

Secara global, masalah kesehatan mental ibu ini terjadi pada 10%-35% wanita, dengan prevalensi lebih tinggi di negara berpendapatan rendah dan menengah (Jungari, 2024; Srivastava, 2020). Sedangkan di Indonesia, sekitar 26% ibu postpartum mengalami masalah kesehatan mental perinatal (Fitriana et al., 2022). Tahun 2023, prevalensi depresi post partum sangat tinggi, sekitar 50%-70% pada ibu baru (Anggarani et al., 2024; Pratiwi et al., 2024). Tingginya prevalensi masalah kesehatan mental maternal tersebut mengindikasikan perlunya perawatan

kesehatan mental terpadu dalam perawatan kesehatan maternal secara rutin (Jungari, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental ibu dapat terjadi karena kurangnya dukungan sosial dan psikologis yang memadai. Kurangnya dukungan sosial dan psikologis yang memadai menjadi masalah utama yang dihadapi oleh ibu hamil dan post partum. Pemberian dukungan psikososial merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membantu ibu mengatasi tantangan yang muncul selama dan setelah persalinan.

Berdasar uraian di atas, bab ini akan membahas lebih dalam tentang hubungan persalinan dan kesehatan mental ibu, serta pentingnya meningkatkan dukungan psikososial. Sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik terkait dengan perawatan yang efektif untuk mendukung kesehatan mental maternal di Indonesia dalam konteks perawatan selama kehamilan dan persalinan.

B. Persalinan dan Kesehatan Mental Ibu

Persalinan dan kesehatan mental ibu sangat berkaitan. Persalinan merupakan momen penting dalam kehidupan seorang ibu yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Kesehatan mental ibu atau yang sering disebut sebagai maternal mental health mencakup kesejahteraan emosional, mental atau psikologis ibu selama periode perinatal, yang meliputi periode kehamilan, persalinan dan postpartum (Handa et al., 2024). Satu dari lima wanita mengalami masalah kesehatan mental selama periode pre-natal dan postpartum (WHO, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat et al. (2022), menunjukkan bahwa 71,3% wanita hamil yang berusia 20-35 tahun menunjukkan gejala gangguan mental emosional. Berbagai macam gangguan mental ibu yang mungkin dapat terjadi pada ibu seperti post partum blues, stres, depresi post partum, dan kecemasan. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryati & Amir (2022) menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental yang muncul pada ibu hamil seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan gangguan psikosomatis.

Masalah kesehatan mental ibu, dalam jangka panjang berkaitan dengan dengan komplikasi kehamilan dan persalinan (Bodunde et al., 2025). Kecemasan yang dialami oleh ibu hamil misalnya, dapat memberikan dampak negatif, tidak hanya pada kesehatan mental ibu, tetapi juga pada kesehatan janin. Terdapat komplikasi seperti persalinan prematur dan berat badan lahir rendah (Rahman & Urbayatun, 2021; Widyastuti et al., 2024). Tekanan psikologis pada ibu selama kehamilan berkaitan dengan risiko gangguan kejiwaan yang lebih tinggi pada anak-anak dikemudian hari (Srinivasan et al., 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan mental seperti kecemasan dan depresi dapat mempengaruhi

pemulihan dan fungsi maternal setelah melahirkan, yang pada akhirnya dapat menghambat penyesuaian ibu dan mengganggu kesehatan ibu dan bayi. Masalah kesehatan mental ibu juga dapat meningkatkan kematian ibu karena bunuh diri (Kimmel, 2020).

Insiden depresi post partum, merupakan salah satu masalah kesehatan mental maternal yang sangat tinggi di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh interaksi berbagai macam faktor, seperti faktor individual, reproduksi, dan kondisi sosial ekonomi. Riwayat aborsi, usia ibu yang masih muda, kurangnya dukungan sosial dari pasangan dan keluarga, serta kesulitan atau tantangan ekonomi dapat meningkatkan masalah kesehatan mental ibu (Pratiwi et al., 2024; Sari et al., 2023). Ibu postpartum dengan usia ibu yang masih muda beresiko mengalami gangguan kesehatan mental seperti postpartum blues maupun depresi post partum. Hal ini dapat terjadi karena ibu mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang remaja menjadi seorang ibu yang dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan (Khairat et al., 2023; Oktafia et al., 2022).

Pengalaman melahirkan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kesehatan mental ibu. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman negatif selama melahirkan, termasuk perlakuan buruk dan tidak hormat sangat berkaitan dengan depresi post partum dan gangguan stress pasca trauma (PTSD) (Coo et al., 2023; Paiz et al., 2022; Taghizadeh et al., 2021; Yohannes et al., 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas perawatan yang diterima selama persalinan, termasuk sikap pemberi layanan kesehatan memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan mental ibu (Tomita et al., 2023).

Kondisi individu seperti komplikasi kehamilan yang dialami oleh ibu juga memberikan dampak psikologis. Kondisi seperti diabetes gestasional, gangguan hipertensi, dan komplikasi obstetrik lainnya berhubungan dengan peningkatan resiko kecemasan dan depresi post partum. Memahami kondisi medis yang dialami oleh ibu dan juga konsekuensi psikologisnya sangat penting dilakukan untuk dapat memberikan intervensi dan dukungan yang tepat selama periode perinatal (Bajinka, 2022; Farias et al., 2021).

Dukungan sosial juga merupakan faktor penting lain yang mempengaruhi kesehatan mental ibu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial yang tinggi diterima oleh ibu, dapat berperan sebagai faktor perlindungan terhadap PTSD dan depresi selama periode post partum (Malaju et al., 2022; Malaju & Alene, 2022). Seorang ibu yang menerima dukungan emosional dan praktis yang adekuat dari keluarga dan teman cenderung tidak mengalami masalah kesehatan mental yang parah (Malaju et al., 2022). Sebaliknya, kurangnya dukungan dapat memperburuk perasaan cemas dan depresi (Rowe et al., 2023). Hasil sistematik

review dan meta analisis yang dilakukan Bedaso et al. (2021), menunjukkan bahwa rendahnya dukungan sosial berhubungan secara signifikan dengan resiko depresi, cemas, menciderai diri selama kehamilan. Ibu yang merasa tidak mendapat dukungan seringkali mengalami isolasi sosial dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah melahirkan.

Sebagai tambahan, faktor sosial ekonomi secara signifikan juga berdampak pada kesehatan mental ibu. Penelitian mengindikasikan bahwa seorang ibu dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental selama dan setelah kehamilan. Faktor seperti tekanan finansial, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, dan kesenjangan pendidikan berkontribusi terhadap beban kesehatan mental yang dialami oleh ibu (Awini et al., 2023). Memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan mental ibu dan juga menerapkan intervensi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan outcome.

C. Pencegahan Masalah Kesehatan Mental Ibu

Pencegahan masalah kesehatan mental pada masa perinatal merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rospia et al., (2023), diperoleh hasil bahwa pencegahan masalah kesehatan mental perinatal dapat dilakukan dengan skrining dari masyarakat, skrining dan deteksi dini, serta pencegahan gangguan kesehatan mental pada kehamilan dan postpartum selanjutnya.

1. Skrining dari masyarakat

Petugas kesehatan mendapatkan informasi dari keluarga maupun dari kader bahwa terdapat pasien dengan gangguan kesehatan mental perinatal.

2. Skrining dan deteksi dini

Skrining dini untuk gangguan kesehatan mental pada ibu hamil dan post partum sangat penting dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus depresi perinatal yang tidak terdeteksi dalam perawatan obstetri, dan hanya 22% wanita yang terdeteksi menerima layanan kesehatan mental (Tabb et al., 2024). Maka dari itu, penetapan skrining untuk kesehatan mental perinatal sangat dianjurkan. Tenaga kesehatan (perawat ataupun bidan) diberikan tugas untuk melakukan skrining dengan menggunakan kuesioner ketika menemukan atau mendapatkan informasi bahwa ada ibu hamil atau postpartum yang mengarah pada gangguan mental. Hal ini dilakukan untuk menentukan, apakah pasien membutuhkan penanganan kejiwaan yang lebih lanjut atau tidak (Rospia et al., 2023). Skrining yang efektif dapat membantu dalam dalam

identifikasi dini dan pemberian intervensi yang diperlukan untuk mencegah perkembangan gangguan mental yang lebih serius (Grussu et al., 2023).

3. Pencegahan gangguan kesehatan mental pada kehamilan dan postpartum selanjutnya

Pencegahan dapat dilakukan dengan menanyakan terkait riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, komplikasi dan kondisi sebelumnya, persalinan sebelumnya dilakukan di mana, dan apakah suami bekerja atau tidak. Selain itu, pencegahan dilakukan dengan melibatkan perawat kesehatan mental dalam perawatan maternal melalui program kelas ibu hamil.

Penelitian lain menyebutkan bahwa salah satu kebijakan terkait kesehatan mental ibu adalah pelaksanaan kelas ibu hamil. Pelaksanaan kelas ibu hamil merupakan salah satu intervensi penting dalam upaya mencegah gangguan kesehatan mental pada ibu. Kelas ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan fisik dan mental selama masa kehamilan (Ayuanda et al., 2022). Edukasi yang diberikan kepada ibu hamil mengenai persiapan fisik dan mental efektif dalam meningkatkan sikap positif dan kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan (Hesti et al., 2022).

Pada pelaksanaannya, kelas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi saja, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesehatan mental ibu hamil. Dalam pelaksanaan kelas ibu hamil, tenaga kesehatan memberikan dukungan psikologis dalam bentuk konseling. Hal yang disampaikan dalam konseling seperti kondisi yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan juga post partum, termasuk dampak dari masa tersebut pada ibu. Dengan memahami kondisi yang dialami, diharapkan ibu dapat menerima dan dapat berdamai dengan kondisi bahwa hal tersebut memang alamiah terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelas ibu hamil dapat menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan ketakutan yang sering dialami ibu hamil (Kartika et al., 2023; Putri et al., 2022). Melalui pemberian informasi yang tepat dan dukungan emosional, kelas ibu hamil dapat membantu ibu lebih siap menghadapi proses kehamilan dan persalinan, sehingga mengurangi resiko gangguan kesehatan mental.

D. Kebijakan Pemerintah terkait Kesehatan Mental Ibu

Seperti yang telah diketahui bahwa masalah kesehatan mental ibu dapat mempengaruhi morbiditas dan mortalitas maternal. Guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi, Kementerian Kesehatan merumuskan berbagai kebijakan yang berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan mental ibu hamil. Pemerintah Indonesia telah menerapkan

beberapa kebijakan untuk menangani kesehatan mental ibu selama kehamilan, persalinan, dan post partum, yang sejalan dengan rekomendasi World Health Organization (WHO). WHO menekankan pentingnya mengintegrasikan perawatan kesehatan mental perinatal ke dalam pelayanan maternitas rutin ibu.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam sistem kesehatan maternal. Model integrasi ini terbukti efektif mengisi kesenjangan layanan dan meningkatkan hasil kesehatan mental ibu. Integrasi layanan kesehatan mental ke dalam perawatan maternal yang rutin dilakukan dapat meningkatkan akses dan treatment untuk depresi post partum. Melalui integrasi pelayanan tersebut, dapat dipastikan bahwa ibu akan menerima perawatan yang komprehensif, baik secara fisik maupun mental (Almutairi et al., 2023).

Peraturan terkait kesehatan mental perinatal di Indonesia tercantum di dalam Pedoman Antenatal Terpadu (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Kebijakan ini mendorong agar dilakukan pemeriksaan masalah kesehatan mental yang dialami oleh perempuan hamil dan nifas. Peraturan ini juga ada dalam standar minimal layanan kesehatan ibu hamil yaitu 10T pada sesi temu wicara. Pada saat sesi temu wicara atau konseling, diberikan informasi terkait hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda dan bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi persalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, serta ASI eksklusif (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Melalui standar ini, bidan dan perawat memiliki wewenang dalam melakukan skrining kesehatan mental perinatal dalam sesi temu wicara. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi WHO tahun 2022, bahwa perlu screening rutin terkait kondisi kesehatan mental perinatal termasuk kondisi depresi dan kecemasan dengan menggunakan tools yang valid (Behl, 2023).

Pelayanan Antenatal Terpadu tersebut juga sejalan dengan Perinatal Mental Health Project (PMHP) yang diluncurkan pada tahun 2002. Proyek ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan mental ibu di Indonesia. Layanan dalam PMHP ini meliputi skrining, konseling, dan layanan psikiatri. Skrining dilakukan untuk mencari tanda-tanda gangguan psikologis dan faktor resiko gangguan mental perinatal pada ibu hamil saat kunjungan antenatal pertama. Konseling dilakukan untuk membantu ibu hamil mengatasi stres dan kecemasan yang mungkin muncul selama kehamilan (Sholihin et al., 2023; Sudirman et al., 2022). Konseling dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak terspesialisasi. Serta layanan psikiatri yang meliputi terapi, pengobatan dan juga monitoring perkembangan.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perinatal Mental Health Project di Indonesia adalah kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam mengenali (screening) dan menangani gangguan mental perinatal (Rospia et al., 2023). Banyak tenaga kesehatan merasa tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada ibu hamil dan post partum. Agar dapat melakukan skrining dan deteksi dini masalah kesehatan mental pada ibu dan memberikan dukungan yang tepat, tenaga kesehatan juga harus memahami terkait kesehatan mental ibu. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani masalah kesehatan mental maternal sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengelola kondisi kesehatan mental yang mungkin dialami oleh ibu hamil dan postpartum (Poreddi et al., 2023).

Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan perawatan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan mental ibu (Ayala et al., 2023; Masters et al., 2023). Pelatihan bagi tenaga kesehatan tersebut terkait kemampuan dalam melakukan penilaian kesehatan mental pada ibu hamil. Kebijakan yang mendukung pelatihan dan penyediaan sumber daya untuk tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada ibu (Howard & Khalifeh, 2020; Voit et al., 2022).

E. Dukungan Psikososial untuk Kesehatan Mental Ibu pada Masa Perinatal

Pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah kesehatan mental ibu melibatkan pengintegrasian berbagai intervensi yang ditujukan untuk menangani kebutuhan psikososial ibu yang unik. Berbagai intervensi telah diidentifikasi secara efektif dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan sistematik review yang dilakukan oleh Qi et al., (2025), diperoleh hasil bahwa intervensi psikososial yang dapat diberikan pada ibu mencakup berbagai strategi seperti edukasi, dukungan sosial, kunjungan rumah, manajemen dan program perawatan kehamilan, serta intervensi terkait ibu dan bayi. Intervensi psikososial yang diberikan mengarah pada terapi dan sistem dukungan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial dan psikologis terkait kesehatan mental ibu (Vaiphei et al., 2023). Intervensi tersebut dapat dilakukan oleh para profesional seperti perawat, dokter, bidan, spesialis kesehatan jiwa, maupun non-profesional seperti kader, relawan, pekerja sosial, serta komunitas perempuan (Qi et al., 2025).

Prom et al. (2022) juga menyebutkan bahwa program yang dapat dilakukan untuk menangani masalah kesehatan mental perinatal mencakup pemantauan kebutuhan individu, pemberian dukungan psikososial, psikoedukasi, dan psikoterapi berbasis bukti, serta pelatihan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi

tersebut secara efektif. Dukungan psikososial selama masa perinatal mengacu pada bantuan emosional, sosial, dan psikologis yang diberikan kepada ibu maupun keluarga selama masa kehamilan, persalinan, dan postpartum (Shinohara et al., 2022). Memberikan dukungan psikososial kepada ibu yang mengalami masalah kesehatan mental selama dan setelah kehamilan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Dukungan psikososial yang efektif dapat membantu mengurangi ketakutan terkait persalinan dan memberikan pengalaman persalinan yang baik (Munkhondya et al., 2020). Selain itu, adanya dukungan psikososial yang memadai dapat mengurangi kecemasan dan depresi yang sering dialami oleh ibu hamil dan post partum (Kristianingrum, 2021; Mendrofa, 2019; Dewi M Rahmawati et al., 2022).

Dukungan psikososial dapat berasal dari pasangan maupun tenaga kesehatan. Dukungan yang berasal dari pasangan dan tenaga kesehatan selama persalinan dapat meningkatkan pengalaman persalinan positif dan mengurangi risiko masalah kesehatan mental di kemudian hari (Khademi & Kaveh, 2024; Kim & Kim, 2020), selain itu ibu juga lebih siap untuk menghadapi persalinan. Dukungan dari pasangan atau suami dapat berupa kehadiran suami dalam proses persalinan. Kehadiran suami selama proses persalinan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman persalinan secara keseluruhan (Kristianingrum, 2021; Maria & Oktalia, 2023).

Tenaga kesehatan (nurse-midwife) juga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan pada ibu hamil hingga postpartum, dengan cara memberikan perawatan holistik yang memenuhi kebutuhan kesehatan fisik dan mental ibu (Fitriana et al., 2022). Dukungan psikososial yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat membantu ibu mengatasi masalah emosional yang muncul selama kehamilan dan setelah melahirkan (Sudirman et al., 2022). Berbagai bentuk dukungan psikososial yang diberikan selama pemberian asuhan sesuai antara lain:

1. Dukungan sosial

Dukungan sosial ini diberikan dalam bentuk penghargaan yang diberikan kepada ibu dengan memberikan pujian atas kekuatan dan keberhasilan ibu dalam menjalani persalinan.

2. Dukungan instrumental

Dukungan ini dilakukan dengan memberikan sentuhan lembut pada perut, dan belaian pada ibu nifas.

3. Dukungan informasi

Dukungan informasi dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan tentang kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Dukungan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang perawatan tali pusat, perawatan

perineum (jalan lahir), dan makan makanan yang membuat ibu merasa sehat dan bahagia.

4. Dukungan spiritual

Dukungan ini diberikan melalui doa untuk mengurangi rasa sakit dan memperlancar persalinan (Sumarni et al., 2020).

Intervensi psikologis seperti konseling juga dapat menjadi bentuk dukungan yang efektif. Konseling dapat membantu ibu mengatasi perasaan cemas dan depresi yang mungkin muncul selama kehamilan dan setelah melahirkan. Melalui konseling ini, ibu dapat belajar strategi koping yang efektif dan mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan (Sudirman & Usman, 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa konseling dapat meningkatkan kesehatan mental ibu dan mengurangi resiko gangguan mental yang serius dikemudian hari.

Intervensi *Cognitive Behavioral Therapy*, *Interpersonal Therapy*, teknik pemecahan masalah juga dapat diberikan oleh tenaga kesehatan kepada Ibu yang mengalami masalah kesehatan mental selama masa perinatal. *Cognitive Behavioral Therapy* berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku negatif. *Interpersonal Therapy* berfokus pada peningkatan hubungan interpersonal dan fungsi sosial untuk meringankan gejala depresi. Sedangkan teknik pemecahan masalah diberikan untuk membantu ibu mengembangkan solusi praktis untuk masalah sehari-hari, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan mental (Nagendrappa & Murugesan, 2023; Nillni et al., 2022).

Dukungan keluarga juga telah diketahui memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu post partum (Hestiani K & Fardi, 2023). Bentuk dukungan keluarga yang diberikan antara lain:

1. Dukungan emosional

Dukungan emosional disini dapat berasal dari pasangan maupun anggota keluarga lain. Ibu yang mendapatkan dukungan emosional lebih mampu menghadapi tekanan psikologis yang dialami. Bentuk dukungan emosional seperti empati, perhatian, dan pengakuan terhadap perasaan ibu setelah melahirkan. Pasangan yang mendengarkan dan merespon kebutuhan emosional ibu dapat mempercepat pemulihan mental setelah melahirkan.

2. Dukungan instrumental

Dukungan instrumental mencakup bantuan praktis yang diberikan oleh keluarga, seperti membantu merawat bayi, mengatur rumah tangga, dan menyediakan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Ibu yang menerima dukungan ini melaporkan tingkat stres yang lebih rendah dan lebih banyak waktu

untuk beristirahat, yang mempengaruhi kesehatan mental mereka. Karena ibu menjadi memiliki waktu yang untuk memulihkan kondisi fisik setelah melahirkan.

3. Dukungan sosial secara keseluruhan

Dukungan sosial secara keseluruhan diperoleh dari anggota keluarga besar. Dukungan ini meliputi perhatian secara menyeluruh dari orang tua, saudara kandung, bahkan tetangga yang membantu menciptakan lingkungan yang suportif untuk ibu (Hestiani K & Fardi, 2023).

Perlu adanya intervensi yang dapat meningkatkan sistem dukungan keluarga dan masyarakat (Zheng et al., 2021). Salah satunya adalah dengan membina jaringan dukungan sosial (*social support network*). Kunjungan rumah merupakan salah satu intervensi yang dilakukan oleh perawat penanggung jawab kesehatan jiwa di puskesmas ketika ada pasien dengan gangguan kesehatan mental perinatal (Rospia et al., 2023). Kegiatan kunjungan rumah ini telah berhasil meningkatkan dukungan sosial bagi ibu post partum, yang mana hal tersebut sangat penting untuk mencegah depresi ibu (Sharifipour et al., 2022).

Family Centered Maternity Care (FCMC) merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan keluarga dalam proses perawatan guna memberikan dukungan sosial kepada ibu hamil. Keterlibatan keluarga salah satunya adalah dengan melibatkan suami. Keterlibatan suami dalam proses kehamilan dan persalinan merupakan bentuk dukungan dari suami. Pelatihan kepada keluarga tentang cara memberikan dukungan emosional dan instrumental dapat membantu menurunkan risiko gangguan mental ibu. Sehingga, edukasi kepada suami tentang pentingnya dukungan emosional dan praktis bagi ibu hamil juga perlu untuk diberikan (Rahmawati et al., 2023). Dukungan yang diberikan oleh suami ini dapat membantu ibu merasa lebih terhubung dan mendapatkan dukungan dalam peran barunya (Mage et al., 2020). Hal ini karena mendorong tanggungjawab bersama dan hubungan emosional sehingga, ibu mampu mengelola stres dan kecemasan selama kehamilan dan post partum (Pratiwi et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa dukungan suami juga dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap pemeriksaan Antenatal Care (ANC), yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kesehatan mental dan fisik ibu dan bayi.

Selain intervensi yang telah disebutkan di atas, intervensi psikologis berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mental ibu. Pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam memberikan dukungan psikososial kepada ibu. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta kesadaran bersama tentang pentingnya kesehatan mental ibu hamil dan perlunya dukungan yang memadai. Edukasi kepada masyarakat dan keluarga tentang

pentingnya dukungan psikososial bagi ibu hamil dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif (Renbarger et al., 2021).

Membangun komunitas yang mendukung ibu postpartum dapat meningkatkan kesejahteraan mental mereka, salah satunya adalah dengan dukungan sebaya. Keterlibatan dukungan sebaya dapat mengurangi perasaan tersingkir dan stres, yang umum terjadi pada ibu baru (Jidong et al., 2021). Intervensi program "Ibu mendukung Ibu", yang menunjukkan dukungan dari rekan sejawat/sebaya, telah terbukti secara signifikan mengurangi tingkat stres psikososial, gejala depresi dan kecemasan pada ibu postpartum, serta meningkatkan kualitas hidup terkait kesehatan (Hrdličková et al., 2024; Němcová et al., 2024). Hasil meta analisis menunjukkan bahwa intervensi dukungan sebaya secara positif juga meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu dalam periode perinatal, baik secara jangka panjang maupun pendek (Shah et al., 2024). Ibu yang terlibat dalam kelompok dukungan sebaya merasa lebih nyaman untuk berbagi pengalaman dan tantangan mereka, yang dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kesejahteraan mereka (McLeish et al., 2023).

Dukungan emosional yang diperoleh dari interaksi teman sebaya ini dapat membantu ibu merasa dihargai dan dipahami, kondisi inilah yang penting bagi kesejahteraan mereka. Pelaksanaan kelas antenatal yang menyediakan ruang khusus bagi ibu hamil untuk berbagi pengalaman dan informasi juga berkontribusi pada dukungan psikososial yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Intervensi dukungan sebaya direkomendasikan dapat dilaksanakan melalui kombinasi pendekatan tatap muka dan juga online yang diberikan secara kelompok maupun individu, agar dapat memberikan dampak secara berkelanjutan (Shah et al., 2024).

F. Simpulan

Kesehatan mental ibu selama periode perinatal merupakan isu yang penting, namun sering kali terabaikan. Perubahan fisik dan psikologis yang secara signifikan terjadi selama periode perinatal dapat memicu terjadinya masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental ibu yang dapat muncul seperti postpartum blues, depresi, kecemasan, bahkan psikosis nifas. Faktor penyebab terjadinya masalah kesehatan mental antara lain kurangnya dukungan psikososial, riwayat kesehatan mental, komplikasi obstetrik, pengalaman negatif selama kehamilan serta tekanan sosial-ekonomi. Kurangnya deteksi dini, kepedulian tentang kesehatan mental, serta kurangnya dukungan yang memadai dapat memperburuk kondisi tersebut.

Secara keseluruhan, dukungan psikososial yang kuat dan komprehensif dari pasangan, keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas sangat penting untuk menjaga kesehatan mental ibu selama periode ini. Pemenuhan kebutuhan psikososial ibu telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mental mereka yang akan berdampak pada kesejahteraan anak. Masyarakat dan juga tenaga kesehatan penting untuk memahami kesehatan mental ibu serta mengimplementasikan strategi dukungan yang efektif. Penanganan yang tepat melalui pemberian dukungan, peningkatan pengetahuan dengan pemberian edukasi kesehatan, pelaksanaan intervensi psikologis dapat mengurangi risiko masalah kesehatan mental serta dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Diperlukan kerjasama lintas sektor dan program yang lebih sinergis untuk memastikan bahwa kesehatan mental ibu menjadi bagian dari pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Pendekatan holistik dan kolaboratif dengan melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat juga perlu dilakukan untuk menciptakan generasi yang sehat baik secara fisik maupun mental.

G. Referensi

- Almutairi, H. A., Alyousef, S. M., Alhamidi, S. A., & Almoammar, D. N. (2023). Exploring the healthcare services' contribution to reducing postpartum depression. *SAGE Open Nursing*, 9, 23779608231171780. <https://doi.org/10.1177/23779608231171780>
- Anggarani, N. L. A. S., Dwina Mastryagung, G. A., & Sri Ariani, N. K. (2024). Screening for Postpartum Depression Risk Using Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) In Postpartum Mothers. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 12(2), 330–338. <https://doi.org/10.33366/jc.v12i2.4483>
- Awini, E., Agyepong, I. A., Owiredo, D., Gyimah, L., Ashinyo, M. E., Yevoo, L. L., Aye, S. G. E. V., Abbas, S., Cronin De Chavez, A., Kane, S., Mirzoev, T., & Danso-Appiah, A. (2023). Burden of mental health problems among pregnant and postpartum women in sub-Saharan Africa: systematic review and meta-analysis protocol. *BMJ Open*, 13(6), e069545. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069545>
- Ayala, N. K., Lewkowitz, A. K., Whelan, A. R., & Miller, E. S. (2023). Perinatal mental health disorders: a review of lessons learned from obstetric care settings. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 19, 427–432. <https://doi.org/10.2147/ndt.s292734>
- Ayuanda, L., Arifiana, R., & Susiatmi, S. A. (2022). Pendkestal Bumil "Pendidikan Kesehatan Mental Pada Ibu Hamil" Dalam Upaya Peningkatan Kebugaran Maternal. *Jurnal Batikmu*, 2(2), 35–39. <https://doi.org/10.48144/batikmu.v2i2.1385>

- Bajinka, O. (2022). Postpartum Psychosis: Risk factors and Management. *Microbiological Research*, 1(1). <https://doi.org/10.52803/23122IOB>
- Bedaso, A., Adams, J., Peng, W., & Sibbritt, D. (2021). The relationship between social support and mental health problems during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *Reproductive Health*, 18(1), 162. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01209-5>
- Behl, R. (2023). The World Health Organization's recommendations on postnatal mental health: The advances made and consolidated limitations. *Ethics, Medicine and Public Health*, 31, 100940. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2023.100940>
- Bodunde, E. O., Buckley, D., O'Neill, E., Al Khalaf, S., Maher, G. M., O'Connor, K., McCarthy, F. P., Kublickiene, K., Matveinko-Sikar, K., & Khashan, A. S. (2025). Pregnancy and birth complications and long-term maternal mental health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 132(2), 131–142. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17889>
- Chilaka, V. N., & Muriithi, F. G. (2021). Mental Health Disorders in Pregnancy and Puerperium. In F. Okonofua, J. A. Balogun, K. Odunsi, & V. N. Chilaka (Eds.), *Contemporary Obstetrics and Gynecology for Developing Countries* (pp. 375–382). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75385-6_34
- Coo, S., García, M. I., & Mira, A. (2023). Examining the association between subjective childbirth experience and maternal mental health at six months postpartum. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 41(3), 275–288. <https://doi.org/10.1080/02646838.2021.1990233>
- Farias, D. R., Carrilho, T. R. B., Freitas-Costa, N. C., Batalha, M. A., Gonzalez, M., & Kac, G. (2021). Maternal mental health and gestational weight gain in a Brazilian Cohort. *Scientific Reports*, 11(1), 10787. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-90179-6>
- Fitriana, F., Ningtyas, W. S., & Dewi, E. R. (2022). Providing mental healthcare for postpartum women in Indonesia: a qualitative phenomenological study. *British Journal of Midwifery*, 30(12), 692–699. <https://doi.org/10.12968/bjom.2022.30.12.692>
- Grussu, P., Jorizzo, G. J., Alderdice, F., & Quatraro, R. M. (2023). Preventing, mitigating, and treating women's perinatal mental health problems during the covid-19 pandemic: a scoping review of reviews with a qualitative narrative synthesis. *Behavioral Sciences*, 13(5), 358. <https://doi.org/10.3390/bs13050358>
- Handa, A., Gaidhane, A., & Choudhari, S. (2024). Shedding light on maternal mental health in LMICs: a cornerstone of maternal and child health care. *Discover Mental Health*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.1007/s44192-024-00111-3>

- Hesti, N., Wildayani, D., & Zulfita, Z. (2022). Edukasi persiapan fisik dan mental serta pendamping persalinan pada kelompok ibu hamil. *Jurnal Pustaka Mitra*, 2(2), 154–159. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v2i2.178>
- Hestiani K, D., & Fardi, F. (2023). The Role Of Family Support On Postnatal Mothers' Mental Wellbeing: A Literature Review. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(3), 1342–1350. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/441>
- Howard, L. M., & Khalifeh, H. (2020). Perinatal mental health: a review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 19(3), 313–327. <https://doi.org/10.1002/wps.20769>
- Hrdličková, K., Horáková, A., Kuklová, M., Němcová, H., Knytl, P., Kostýlková, L., & Šebela, A. (2024). Effectiveness of “Mom Supports Mom” Peer Support Intervention in Reducing Prenatal Anxiety and Psychosocial Stress Levels. *European Psychiatry*, 67(S1), S197--S197. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2024.426>
- Jidong, D. E., Husain, N., Ike, T. J., Murshed, M., Pwajok, J. Y., Roche, A., Karick, H., Dagona, Z. K., Karuri, G. S., Francis, C., Mwankon, S. B., & Nyam, P. P. (2021). Maternal mental health and child well-being in Nigeria: A systematic review. *Health Psychology Open*, 8(1), 20551029211012200. <https://doi.org/10.1177/20551029211012199>
- Jungari, S. (2024). Maternal Mental Health. In *Encyclopedia of Social Work*. NASW Press and Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.1685>
- Kartika, M. L., Lubis, R., & Kundaryanti, R. (2023). Kelas ibu hamil sebagai upaya mengatasi kecemasan dalam kehamilan. *Jurnal Kebidanan Khatulistiwa*, 9(1), 32. <https://doi.org/10.30602/jkk.v9i1.828>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal terpadu*. <https://repository.kemkes.go.id/book/147>
- Khademi, K., & Kaveh, M. H. (2024). Social support as a coping resource for psychosocial conditions in postpartum period: a systematic review and logic framework. *BMC Psychology*, 12(1), 301. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01814-6>
- Khairat, I., Ramanda, P., & Alfiah, F. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu di Kecamatan Ciomas untuk Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Mental pada Ibu Muda. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 240–250. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i1.331>
- Kim, S. Y., & Kim, H. W. (2020). Prenatal nursing intervention studies published in Korean nursing journals: a scoping review. *Korean Journal of Women Health Nursing*, 26(2), 109–119. <https://doi.org/10.4069/kjwhn.2020.06.12>

- Kimmel, M. (2020). Maternal Mental Health MATTERS. *North Carolina Medical Journal*, 81(1), 45–50. <https://doi.org/10.18043/ncm.81.1.45>
- Kristianingrum, D. Y. (2021). The Role of Husbands in Giving Labor Support. *EMBRIO: Jurnal Kebidanan*, 13(1), 39–45. <https://doi.org/10.36456/embrio.v13i1.3234>
- Mage, M. Y. C., Prapunoto, S., & Kristijanto, A. I. (2020). Dinamika dukungan suami pada kecemasan ibu nifas dalam Rumah Bulat. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 7(1), 69–86. <https://doi.org/10.24854/jpu101>
- Malaju, M. T., & Alene, G. D. (2022). Longitudinal patterns of the relation between anxiety, depression and posttraumatic stress disorder among postpartum women with and without maternal morbidities in Northwest Ethiopia: a cross-lagged autoregressive structural equation modelling. *Archives of Public Health*, 80(1), 225. <https://doi.org/10.1186/s13690-022-00978-0>
- Malaju, M. T., Alene, G. D., & Bisetegn, T. A. (2022). Longitudinal mediation analysis of the factors associated with trajectories of posttraumatic stress disorder symptoms among postpartum women in Northwest Ethiopia: Application of the Karlson-Holm-Breen (KHB) method. *PLoS ONE*, 17(4), e0266399. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266399>
- Maria, L., & Oktalia, I. (2023). Hubungan dukungan suami dalam persalinan dengan nyeri persalinan di Ruang Kenanga RSUP Dr Rivai Abdullah Palembang tahun 2022. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 13(25), 57–66. <https://doi.org/10.52047/jkp.v13i25.205>
- Masters, G. A., Yuan, Y., Li, N. C., Straus, J., Moore Simas, T. A., & Byatt, N. (2023). Improving front-line clinician capacity to address depression and bipolar disorder among perinatal individuals: a longitudinal analysis of the Massachusetts Child Psychiatry Access Program (MCPAP) for Moms. *Archives of Women's Mental Health*, 26(3), 401–410. <https://doi.org/10.1007/s00737-023-01324-1>
- McLeish, J., Ayers, S., & McCourt, C. (2023). Community-based perinatal mental health peer support: a realist review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 570. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05843-8>
- Mendrofa, H. K. (2019). Hubungan dukungan sosial keluarga dengan tingkat kecemasan ibu primigravida trimester III dalam menghadapi proses persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kota Matsum Medan. *Indonesian Trust Health Journal*, 2(1), 132–137. <https://doi.org/10.37104/ithj.v2i1.29>
- Munkhondya, B. M. J., Munkhondya, T. E., Chirwa, E., & Wang, H. (2020). Efficacy of companion-integrated childbirth preparation for childbirth fear, self-efficacy, and maternal support in primigravid women in Malawi. *BMC Pregnancy Childbirth*, 20(1), 48. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2717-5>

- Nagendrappa, S., & Murugesan, M. (2023). Psychosocial Assessment in Perinatal Mental Health: Insights, Strategies, and Future Directions. *Indian Journal of Social Psychiatry, 39*(3), 198–203. https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp_247_23
- Němcová, H., Hrdličková, K., Kuklová, M., Horáková, A., Nosková, E., Švancer, P., Byatt, N., & Šebela, A. (2024). Enhancing Postpartum Mental Health: Evaluation of the Effect of Remote Peer Support Intervention. *European Psychiatry, 67*(S1), S268–S269. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2024.566>
- Nilni, Y. I., Murphy, S., Paul, E., & Johnson, E. (2022). Psychosocial Treatment for Perinatal Depression, Anxiety, and Posttraumatic Stress Disorder. In *Comprehensive Clinical Psychology* (Second, pp. 188–202). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818697-8.00134-5>
- Nuryati, T., & Amir, Y. (2022). Mental Health Problems of Pregnant Women, The Causes, and The Need for Social Support. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan, 11*(1), 80–88. <https://doi.org/10.20473/jbk.v11i1.2022.80-88>
- Oktafia, R., Rini Rahmayanti, & Dea Ainun Maghipira. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu di Kecamatan Ciomas untuk Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Mental pada Ibu Muda. *Jurnal Abdi Mercusuar, 2*(1), 1–8. <https://doi.org/10.36984/jam.v2i1.292>
- Paiz, J. C., De Jesus Castro, S. M., Giugliani, E. R. J., Dos Santos Ahne, S. M., Aqua, C. B. D., & Giugliani, C. (2022). Association between mistreatment of women during childbirth and symptoms suggestive of postpartum depression. *BMC Pregnancy and Childbirth, 22*(1), 664. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04978-4>
- Poreddi, V., Gandhi, S., Ramachandra, Ganjekar, S., Desai, G., & Chandra, P. S. (2023). Evaluation of a manual-based training program in changing auxiliary nurse midwives (ANMs) knowledge, attitudes, and skills related to maternal mental health. *Indian Journal of Psychiatry, 65*(6), 617–625. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_567_22
- Pratiwi, L., Mahmud, U. H., Wardin, I., Nawangsari, H., & Puspitasari, M. T. (2024). Edukasi Pencegahan Pre Eklampsia Dan Determinan Post Partum Blues Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal, 1*(3), 114–120. <https://doi.org/10.62951/masyarakatmandiri.v1i3.285>
- Prom, M. C., Denduluri, A., Philpotts, L. L., Rondon, M. B., Borba, C. P. C., Gelaye, B., & Byatt, N. (2022). A systematic review of interventions that integrate perinatal mental health care into routine maternal care in low- and middle-income countries. *Frontiers in Psychiatry, 13*, 859341. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.859341>

- Putri, N. R., Amalia, R., & Kusmawati, I. I. (2022). Kelas ibu hamil terhadap kesehatan psikologis ibu hamil dan persiapan persalinan: systematic review. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.35473/ijm.v5i1.1427>
- Qi, W., Huang, S., Zhao, J., Cui, X., Wei, Z., Cui, G., Guo, Q., & Hu, J. (2025). The preventive effect of psychological and psychosocial interventions on postpartum depression: {An} overview of systematic reviews. *Journal of Psychiatric Research*, 182, 21–33. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2024.11.050>
- Rachmat, M., Wati, F., Hasnaeni, H., Manti, S., Hasliani, A., Hasnita, H., Marbun, U., Bellani, E., Virani, D., Ikhsan, M., Asrianti, T., Hidayat, M., & Anwar, S. A. (2022). Detection of Mental Emotional Disorder Symptoms using SRQ-20 in Pregnant Women: A Case Example from South Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 4(1), 106–115. <https://doi.org/10.36590/jika.v4i1.231>
- Rahman, A., & Urbayatun, S. (2021). Kesehatan Mental Ibu Hamil Sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Kajian Literatur. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 7(2), 59–67. <https://doi.org/10.22487/htj.v7i2.161>
- Rahmawati, Dewi M, Irmayani, I., & Sopiatus, R. (2022). Pemberian dukungan keluarga dan kader terhadap penurunan kecemasan ibu hamil resiko tinggi dalam menghadapi persalinan. *Jurnal Midwifery Update (MU)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32807/jmu.v4i1.136>
- Rahmawati, Dewi Maharesi, Purbowati, M. R., Pratama, A. Y. A., & Basuki, D. R. (2023). Hubungan Dukungan Suami Ibu Hamil Terhadap Kepatuhan Antenatal Care Di Puskesmas Padamara Kabupaten Purbalingga. *Herb-Medicine Journal*, 5(3), 14. <https://doi.org/10.30595/hmj.v5i3.14370>
- Renbarger, K. M., Place, J. M., & Schreiner, M. (2021). The Influence of Four Constructs of Social Support on Pregnancy Experiences in Group Prenatal Care. *Women's Health Reports*, 2(1), 154–162. <https://doi.org/10.1089/whr.2020.0113>
- Rospia, E. D., Cahyaningtyas, D. K., Wd, S. M., & Lestari, C. I. (2023). Qualitative Study of Perinatal Mental Health Services: Experiences and Perspectives of Health Workers and Patients. *EMBRIO: Jurnal Kebidanan*, 15(2), 216–227. <https://doi.org/10.36456/embrio.v15i2.7773>
- Rowe, A., Bhardwaj, M., & McCauley, M. (2023). Maternal multimorbidity - experiences of women seeking asylum during pregnancy and after childbirth: a qualitative study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 789. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-06054-x>
- Sari, N., Dewi, F. N. M., & Muhani, N. (2023). Maternal Factors Influencing Postpartum Depression in Indonesia. *Kesmas*, 18(3), 203–208. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v18i3.7209>

- Shah, L., Chua, J. Y., Goh, Y. S., Chee, C. Y., Chong, S. C., Mathews, J., Lim, L. H., Chan, Y. H., Morelius, E., & Shorey, S. (2024). Effectiveness of peer support interventions in improving mothers' psychosocial well-being during the perinatal period: A systematic review and meta-analysis. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 21(6), 652–664. <https://doi.org/10.1111/wvn.12747>
- Sharifipour, F., Javadnoori, M., Moghadam, Z. B., Najafian, M., Cheraghian, B., & Abbaspoor, Z. (2022). Interventions to improve social support among postpartum mothers: A systematic review. *Health Promotion Perspectives*, 12(2), 141–150. <https://doi.org/10.34172/hpp.2022.18>
- Shinohara, E., Ohashi, Y., Hada, A., & Usui, Y. (2022). Effects of 1-day e-learning education on perinatal psychological support skills among midwives and perinatal healthcare workers in {Japan}: a randomised controlled study. *BMC Psychology*, 10(1), 133. <https://doi.org/10.1186/s40359-022-00832-6>
- Sholihin, H. Y. A., Laili, Z., Adi, S., & Ratih, S. P. (2023). Hubungan Faktor Pemungkin dan Penguat dengan Perilaku Pencarian Pertolongan Segera ke Tenaga Kesehatan terhadap Kecemasan Maternal. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(3), 829–838. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i3.1012>
- Srinivasan, R., Pearson, R. M., Johnson, S., Lewis, G., & Lewis, G. (2020). Maternal perinatal depressive symptoms and offspring psychotic experiences at 18 years of age: a longitudinal study. *The Lancet Psychiatry*, 7(5), 431–440. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30132-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30132-2)
- Srivastava, D. M. (2020). Various aspect of maternal mental health on the basis of mini review. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, 6(6), 681–684. https://ijariie.com/AdminUploadPdf/VARIOUS_ASPECT_OF_MATERNAL_MENTAL_HEALTH_ON_THE_BASIS_OF_MINI_REVIEW_ijariie13121.pdf
- Sudirman, J., Rahayu Eryani K., & Fadjriah Ohorella. (2022). Upaya Menjaga Kesehatan Mental Ibu Hamil melalui Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan di Masa Pandemi Covid-19. *Income Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 1(2), 28–34. <https://doi.org/10.56855/income.v1i2.46>
- Sudirman, J., & Usman, S. (2022). Efektifitas edukasi maternal mental health terhadap kesehatan mental ibu selama masa kehamilan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 3(4), 317–322. <https://doi.org/10.25077/jikesi.v3i4.1041>
- Sumarni, S., Prawitasari, S., & Putri, I. (2020). The effect of midwife training in strengthening the mental health of postpartum mother. *Journal of Community Empowerment for Health*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.41269>

- Tabb, K. M., Hsieh, W.-J., Ramirez, X. R., & Kopels, S. (2024). State legislation and policies to improve perinatal mental health: a policy review and analysis of the state of Illinois. *Frontiers in Psychiatry*, *15*, 1347382. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1347382>
- Taghizadeh, Z., Ebadi, A., & Jaafarpour, M. (2021). Childbirth violence-based negative health consequences: a qualitative study in Iranian women. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *21*(1), 572. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03986-0>
- Tomita, Y., Kiriya, J., Silwal, R. C., Ong, K. I. C., Shibanuma, A., & Jimba, M. (2023). Association between the person-centered maternity care experience and mental health after delivery in urban and rural Dhading, Nepal: a cross-sectional study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *23*(1), 398. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05709-z>
- Vaiphei, K., Manukrishnan, & Lobo, R. (2023). Psychosocial Interventions in Perinatal Mental Illness. *Indian Journal of Social Psychiatry*, *39*(3), 204–209. https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp_252_23
- Valadares, G., Drummond, A. V., Rangel, C. C., Santos, E., & Apter, G. (2020). Maternal Mental Health and Peripartum Depression. In J. Rennó, G. Valadares, A. Cantilino, J. Mendes-Ribeiro, R. Rocha, & A. Geraldo Da Silva (Eds.), *Women's mental health: A clinical and evidence-based guide* (pp. 349–375). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29081-8_24
- Voit, F. A. C., Kajantie, E., Lemola, S., Räikkönen, K., Wolke, D., & Schnitzlein, D. D. (2022). Maternal mental health and adverse birth outcomes. *PLoS ONE*, *17*(8), e0272210. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272210>
- WHO. (2022). *Guide for Integration of Perinatal Mental Health in Maternal and Child Health Services* (1st ed). World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/362880>
- Widyastuti, D. E., Ernawati, Yessy M, M., & Apriani, A. (2024). Minimalisasi Kecemasan pada Ibu Hamil dengan Kartu Pintar Samas (Sadar Kecemasan). *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, *6*(1), 98–103. <https://doi.org/10.35473/ijce.v6i1.3185>
- Yohannes, E., Moti, G., Gelan, G., Creedy, D. K., Gabriel, L., & Hastie, C. (2024). Impact of disrespectful maternity care on childbirth complications: a multicentre cross-sectional study in Ethiopia. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *24*(1), 380. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06574-0>
- Zheng, Z., Zhang, R., Liu, T., Cheng, P., Zhou, Y., Lu, W., Xu, G., So, K.-F., & Lin, K. (2021). The psychological impact of the coronavirus disease 2019 pandemic on pregnant women in China. *Frontiers in Psychiatry*, *12*, 628835. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.628835>

H. Glosarium

AKI	= Angka Kematian Ibu
ANC	= Antenatal Care
ASI	= Air Susu Ibu
PTSD	= Post Traumatic Stress Disorder/Gangguan Stres Pasca Trauma
WHO	= World Health Organization

CHAPTER 5

PERAWATAN PERSALINAN NORMAL DAN TEKNIK MANAJEMEN RASA NYERI

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.

A. Pendahuluan

Persalinan normal menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) 2018 adalah persalinan yang berlangsung tanpa adanya komplikasi, baik pada ibu maupun bayi. Pada persalinan ini, proses kelahiran bayi terjadi melalui jalan lahir (vagina) tanpa menggunakan intervensi medis yang signifikan. Persalinan normal juga disebut sebagai persalinan fisiologis karena prosesnya mengikuti tahapan alami dan berlangsung dengan dukungan minimal dari tenaga medis, kecuali jika diperlukan. Ciri-ciri Persalinan Normal adalah (1) Pembukaan serviks yang teratur: Pada persalinan normal, pembukaan serviks biasanya terjadi secara bertahap hingga mencapai 10 cm. (2) Pecahnya ketuban secara alami: Ketuban pecah secara alami dalam waktu yang relatif normal, atau dilakukan dengan prosedur medis bila diperlukan. (3) Proses kontraksi rahim: Kontraksi yang teratur dan meningkat intensitasnya. (4) Bayi lahir dengan posisi kepala di bawah (presentasi cephalic): Posisi bayi yang sesuai untuk lahir normal adalah kepala di bawah. (5) Bayi dan ibu dalam keadaan sehat setelah melahirkan. Proses Persalinan dan Perawatan disebut juga *Intra Partial Care* atau *Intra Natal Care*. Intra Partial Care. Periode intra partal dimulai dari kontraksi uterus yang menyebabkan dilatasi serviks, dilanjutkan dengan kelahiran bayi dan placenta dari jam-jam pertama sampai ke empat setelah kelahiran. Intra partal care berkaitan dengan perawatan medis dan keperawatan yang diberikan pada ibu hamil dan keluarga selama persalinan dan kelahiran.

Hasil Survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023, mayoritas ibu di Indonesia memilih metode persalinan normal. Proporsi ibu yang melahirkan secara normal mencapai 73,2%, persalinan Caesar sebesar 25,9% dan metode lainnya 1%. (SKI, 2023). Data SKI (2023) menunjukkan bahwa 96,1% ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan 89,9% dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Bab ini membahas tentang permulaan persalinan, tanda-tanda awal persalinan, termasuk tanda persalinan yang sebenarnya dan persalinan yang palsu, faktor-faktor penting yang mempengaruhi persalinan dan kelahiran, respons ibu dan janin terhadap proses persalinan, dan empat tahap persalinan. Bab ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penting yang terkait dengan setiap tahap persalinan: "10 P" persalinan. Kala I, II, III, Kala IV dan manajemen Nyeri Persalinan.

B. Permulaan Persalinan

Persalinan Normal adalah Proses pengeluaran buah kehamilan cukup bulan (Bayi, Plasenta dan Selaput Ketuban), presentasi kepala (Posisi belakang kepala), dari rahim ibu, melalui jalan lahir, dengan tenaga ibu sendiri. Proses persalinan secara normal melibatkan berberapa hormone, Rangsangan oxytocin, keregangan otot-otot, pengaruh kontrol endokrin fetal dan Teori prostaglandin. Secara luas diyakini bahwa persalinan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk peregangan rahim, penarikan progesteron, peningkatan sensitivitas oksitosin, dan peningkatan pelepasan prostaglandin. Satu teori menyatakan bahwa persalinan dimulai oleh perubahan rasio estrogen-progesteron. Selama trimester terakhir kehamilan, kadar estrogen meningkat dan kadar progesteron menurun. Perubahan ini menyebabkan peningkatan jumlah gap junction miometrium. Gap junction adalah protein yang menghubungkan membran sel dan memfasilitasi koordinasi kontraksi rahim dan peregangan miometrium (Gilbert, 2007).

Persalinan adalah suatu proses dimana fetus dan produk konsepsi lainnya dipaksa keluar sebagai akibat dari kontraksi uterus yang teratur, progresif, sering dan kuat. Teori-teori lainnya persalinan meliputi : Penurunan progesteron. Kadar progesteron dan estrogen selama kehamilan berada dalam keadaan seimbang. Pada akhir kehamilan kadar progesteron menurun, akibatnya terjadi relaksasi otot-otot rahim yang menyebabkan his. Sebaliknya estrogen meningkat kerentanan otot-otot rahim.

Tujuan dari Perawatan Persalinan Normal adalah : Meningkatkan kesehatan fisik dan emosional ibu dan fetus semaksimal mungkin serta Menggabungkan konsep-konsep asuhan yang berpusat pada keluarga kedalam pengalaman persalinan dan melahirkan. Pengalaman kehamilan sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman persalinan (intra partal/Intra natal): (1) Harapan-harapan pribadi dan kebudayaan. Kehamilan ada yang diinginkan serta direncanakan dengan baik. Namun ada juga kehamilan yang tak diinginkan (*Married By Accident*). Hal ini akan mempengaruhi Ibu hamil saat persiapan persalinan dan semangat untuk melahirkan dengan senang dan bahagia sehat sejahtera. Penting sekali peran keluarga atau orang terdekat untuk mendukung ibu hamil dalam proses persalinan serta nilai dari pentingnya kehadiran anak sebagai penerus keturunan Ayah pada budaya Patriaki dan Ibu pada budaya Matriaki. Sehingga diperlukan peran petugas kesehatan untuk menjadi fasilitator maupun mediator yang baik dengan keluarga serta menjadi sahabat ibu hamil. (2) Kesehatan ibu sebelum hamil dan kesiapan biofisik untuk kelahiran bayi. Kesehatan ibu hamil sangat penting untuk persiapan persalinan agar Ibu dapat melahirkan secara normal. Ibu dan keluarga perlu mengikuti *Kelas Pre Natal Care and Family*. Agar ibu dipersipkan

untuk menghadapi persalinan yang aman dan selamat. (3) Motivasi untuk memiliki anak. Motivasi untuk memiliki anak menjadi suatu energy terbesar yang membuat ibu siap untuk melahirkan. (4) Kesiapan sosioekonomi. Ibu yang akan melahirkan perlu persiapan ekonomi yang baik, perlu menabung yang disebut Tabulin: Tabungan Ibu Bersalin. Hal ini menjadi tanggung jawab Ibu dan Suami dan juga. Karena banyak persoalan ibu hamil tidak mau melahirkan di Fasilitas Kesehatan karena sosial ekonomi yang rendah, terkait kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi keluarga yang mendampingi maupun kebutuhan khusus sandang/pakaian Ibu. Perlu peran dari Petugas untuk mempersiapkan Tabulin atau Dasolin (Dana Sosial Ibu bersalin) dari keluarga maupun dari pihak Pemerintah jika disediakan. (5) Usia ibu turut mempengaruhi proses persalinan misalnya usia terlalu Tua > 35 tahun atau terlalu muda < 20 tahun; status ibu (bersuami atau tidak); Status perkawinan ibu akan mempengaruhi dalam persiapan persalinan. Ibu yang tidak menikah malu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan sehingga Perawat atau Bidan harus membantu ibu untuk tidak stress bahkan sampai depresi, memeriksakan kehamilan dengan teratur serta merawat kehamilannya dengan baik dan dapat melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dengan aman dan selamat. Selama hamil ibu diharapkan dapat merawat kehamilannya dengan baik di klinik ANC baik Puskesmas, RS atau Praktek swasta serta siap untuk melahirkan dengan aman dan selamat di fasilitas kesehatan yang memadai

Tanggung jawab Perawat dalam proses persalinan agar ibu hamil dapat melahirkan bayi dengan aman dan selamat adalah : (1) Menentukan kesehatan ibu dan fetus pada saat masuk ke ruang bersalin (2) Menciptakan lingkungan yang ramah dan menampilkan pelayanan yang berkualitas (3) Menjelaskan dengan tepat, jelas dan sesuai tentang lingkungan fisik ruang bersalin, prosedur-prosedur yang akan dilakukan, dan harapan-harapan yang diinginkan (4) Mengkaji secara akurat dan memberikan intervensi yang tepat dan sesuai keadaan ibu. Dengan demikian Ibu dapat melahirkan bayi dengan penuh semangat dan aman. Ibu dan bayi sehat dan selamat.

1. Tanda-tanda Awal Persalinan

a. Persalinan Sejati versus Palsu

Persalinan sejati ditandai dengan kontraksi yang terjadi pada interval teratur yang meningkat dalam frekuensi, durasi, dan intensitas. Kontraksi persalinan sejati menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks progresif. Sebaliknya, Persalinan palsu adalah kondisi yang terjadi selama minggu-minggu terakhir beberapa kehamilan di mana kontraksi uterus tidak teratur terasa, tetapi serviks tidak terpengaruh. Tabel 5.1 merangkum perbedaan antara persalinan sejati dan palsu. Persalinan palsu,

Tabel 5.1: Perbedaan antara *True and False Labor*

Parameter	True Labor (Tanda Persalinan Sebenarnya)	False Labor (Tanda Peralinan Palsu)
Waktu Kontraksi	Kontraksi Teratur, semakin dekat satu sama lain, biasanya sebentar-sebentar dan teratur berjarak 4–6 menit, berlangsung 30–60 detik	Kontraksi terjadi Tidak teratur, tidak terjadi berdekatan Sering kali lemah,
Kekuatan Kontraksi	Menjadi lebih kuat seiring waktu, tekanan vagina , intensitas dan durasinya meningkat, dengan interval yang semakin bertahap pendek (2 -3 menit)	Frekuensi lemah, tidak bertambah kuat seiring waktu atau bergantian (yang kuat diikuti oleh yang lemah)
Ketiaknyamanan Kontraksi	Biasanya terasa Dimulai dari belakang dan menjalar ke arah depan perut	Biasanya terasa di bagian depan perut
Perubahan yang terjadi saat aktivitas	• Kontraksi terus berlanjut, apa pun perubahan posisi yang terjadi. • Kontraksi diperhebat bila berjalan	Kontraksi dapat berhenti atau melambat saat berjalan atau mengubah posisi dan malahan mengurangi kontraksi
Bertahan atau pergi/Berkurang	• <i>Bloody show</i> (Lendir campur darah) • Cerviks menjadi pendek,tipis dan dilatasi • Kontraksi tidak berhenti dengan sedative • Tetaplah di rumah hingga kontraksi terjadi setiap 5 menit, berlangsung selama 45–60 detik, dan cukup kuat sehingga Anda tidak dapat mengobrol selama kontraksi—lalu pergilah ke rumah sakit atau pusat bersalin.	• Tidak ada bloody show • Tidak ada perubahan cerviks • Ambulasi tidak menyebabkan perubahan • Sedativa cenderung mengurangi kontraksi • Minumlah cairan dan berjalan-jalan untuk melihat apakah ada perubahan intensitas kontraksi; jika kontraksi berkurang intensitasnya setelah salah satu atau keduanya—tinggallah di rumah.

C. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan

Dalam banyak referensi, faktor-faktor penting yang memengaruhi proses persalinan dan kelahiran diuraikan sebagai "lima P": 1. *Passageway* (jalan lahir) 2. *Passenger* (janin dan plasenta) 3. *Powers* (kontraksi) 4. *Position* (ibu) 5. *Psychological Responses* (Respons psikologis) Faktor-faktor penting ini umumnya diterima dan dibahas oleh para profesional perawatan kesehatan. Namun, lima "P" tambahan juga dapat memengaruhi proses persalinan: 1. *Philosophy* (teknologi rendah, sentuhan tinggi) 2. *Partner* (Mitra: pengasuh pendukung) 3. *Patience*/Kesabaran (waktu alami) 4. *Patient Preparation*/ Persiapan pasien (dasar pengetahuan persalinan) 5. *Pain Control*/ Pengendalian rasa sakit (tindakan kenyamanan)

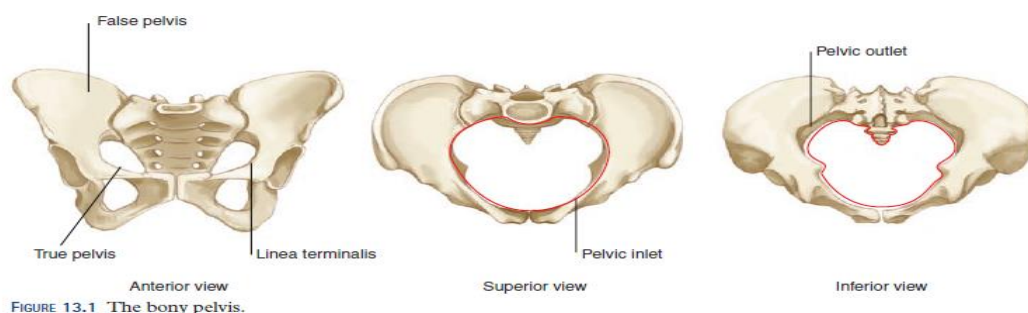
Kelima "P" tambahan ini membantu dalam merencanakan perawatan untuk keluarga yang akan melahirkan. Faktor-faktor yang berfokus pada pasien ini merupakan upaya untuk mendorong persalinan yang dapat dikelola melalui penggunaan sentuhan tinggi, kesabaran, dukungan, pengetahuan, dan manajemen rasa sakit.

1. *Passageway* (Jalan lahir)

Passageway (Jalan Lahir) Berkaitan dengan pelvis dan jalan lahir meliputi : (1) Jenis pelvik (*gynecoid, android dst*) (2) Struktur pelvik (*True vs false pelvis*) (3) Diameter inlet pelvik (4) Diameter outlet pelvik. Kemampuan segmen uterus untuk melar (menggelembung), cervix untuk dilatasi, dan saluran vagina dan introitus vagina untuk melar

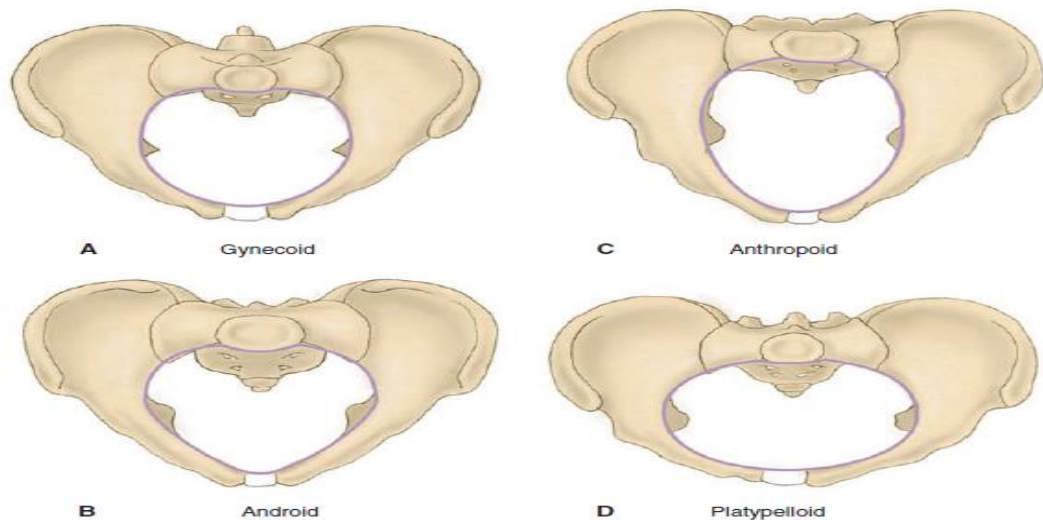
a. Tulang Panggul/ Tulang Pelvis

Tulang pelvis ibu dapat dibagi menjadi bagian sejati dan palsu. Pelvis palsu (atau lebih besar) terdiri dari bagian atas yang melebar dari dua tulang iliaka dengan cekungannya dan sayap pangkal sakrum. Pelvis palsu dipisahkan dari pelvis sejati oleh garis imajiner yang ditarik dari tonjolan sakral di bagian belakang ke aspek superior simfisis pubis di bagian depan pelvis (Gambar. 5.1). Pelvis sejati adalah jalur tulang yang harus dilalui janin. Pelvis ini terdiri dari tiga bidang: bagian atas, bagian tengah pelvis (rongga), dan bagian atas.



Gambar 5.1: The Bony Pelvis.

Ukuran panggul, Jika konjugata diagonal berukuran sedikitnya 11,5 cm dan konjugata sejati atau obstetrik berukuran 10 cm atau lebih (1,5 cm lebih kecil dari konjugat diagonal, atau sekitar 10 cm), maka panggul cukup besar untuk kelahiran pervaginam dari apa yang dianggap sebagai bayi baru lahir berukuran normal. Panggul dibagi menjadi empat bentuk utama: ginekoid, antropoid, android, dan platipelloid (Gambar. 5.2).



Gambar 5.2: Pelvic Shapes

(A) Gynecoid. (B) Android.
(C) Anthropoid. (D) Platypelloid

Pelvis ginekoid dianggap sebagai pelvis wanita sejati, yang terjadi pada sekitar 50% dari semua wanita; lebih jarang terjadi pada pria (Leonard, 2007). Persalinan pervaginam paling disukai dengan jenis pelvis ini karena lubang masuknya bundar dan lubang keluarnya lapang. Bentuk ini menawarkan diameter optimal di ketiga bidang pelvis. Jenis pelvis ini memungkinkan rotasi internal janin secara dini dan lengkap selama persalinan.

2. Passenger (janin dan plasenta)

Janin dan Plasenta berkaitan dengan kemampuan fetus bergerak melewati jalan lahir, yang berdasarkan pada : (1) Ukuran kepala fetal dan kemampuannya untuk menyusup terhadap jalan lahir (2) Presentasi fetal (3) Sikap fetal (4) Posisi fetal (5) Gerakan-gerakan anak pada persalinan. Janin (dengan plasenta) adalah penumpang. Kepala janin (ukuran dan keberadaan molding), sikap janin (derajat fleksi tubuh), letak janin (hubungan bagian-bagian tubuh), presentasi

janin (bagian tubuh pertama), posisi janin (hubungan dengan panggul ibu), posisi janin, dan keterlibatan janin merupakan faktor-faktor penting yang berdampak pada hasil akhir dalam proses melahirkan.

a. Sikap Janin

Sikap janin merupakan pertimbangan penting lainnya yang berkaitan dengan penumpang. Sikap janin mengacu pada postur (fleksi atau ekstensi) sendi dan hubungan bagian-bagian janin satu sama lain. Sikap janin yang paling umum saat persalinan dimulai adalah dengan semua sendi tertekuk—punggung janin membulat, dagu menempel di dada, paha tertekuk di perut, dan kaki tertekuk di lutut (Gambar. 5.3). Posisi janin normal ini paling baik untuk persalinan per vaginam, yang menghadirkan diameter tengkorak janin terkecil ke panggul.

b. Letak Janin

Letak janin mengacu pada hubungan sumbu panjang (tulang belakang). Janin dengan sumbu panjang (tulang belakang) ibu. Ada dua letak utama: longitudinal (yang paling umum) dan transversal (Gambar. 5.4).



Gambar 5.3: Fetal Attitude

Full flexion. Note that the smallest diameter presents to the pelvis.



A. Longitudinal Lie

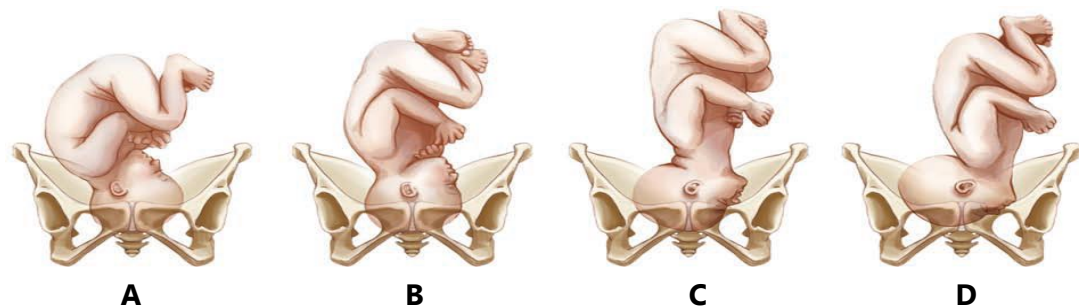


B. Transversal Lie

Gambar 5.4 (A dan B): Fetal Lie

c. Presentasi Janin

Presentasi janin mengacu pada bagian tubuh janin yang memasuki pintu masuk panggul terlebih dahulu (bagian yang disebut "presentasi"). Ini adalah bagian janin yang terletak di atas pintu masuk panggul atau os serviks. Tiga presentasi janin utama adalah sefalik (kepala lebih dulu), sungsang (panggul lebih dulu), dan bahu (skapula lebih dulu). Mayoritas bayi baru lahir cukup bulan (95%) lahir dalam presentasi sefalik; presentasi sungsang mencakup 3% kelahiran cukup bulan, presentasi bahu sekitar 2% (Edmonds, 2007). Dalam presentasi sefalik, bagian yang muncul biasanya adalah bagian oksiput kepala janin (Gambar. 5.5). Presentasi ini juga disebut sebagai presentasi verteks. Variasi dalam presentasi verteks meliputi presentasi milier, alis, dan wajah.



Gambar 5.5: Fetal presentation: cephalic presentations. (A) Vertex. (B) Military. (C) Brow. (D) Face

Selain itu, panggul ibu dibagi menjadi empat kuadran: anterior kanan, anterior kiri, posterior kanan, dan posterior kiri. Kuadran ini menunjukkan apakah bagian presentasi diarahkan ke bagian depan, belakang, kiri, atau sisi kanan panggul. Posisi janin ditentukan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi bagian presentasi dan kemudian kuadran ibu yang menghadap bagian presentasi (Gambar. 5.6). Posisi ditunjukkan dengan singkatan tiga huruf sebagai berikut:

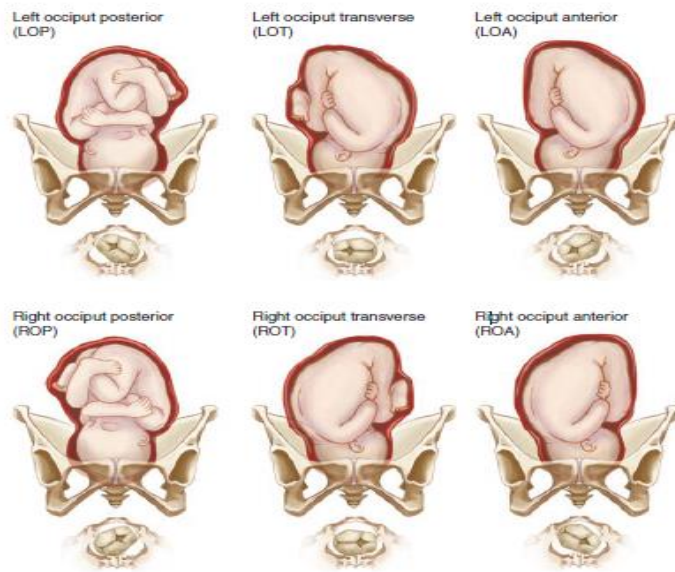


FIGURE 13.9 Examples of fetal positions in a vertex presentation. The lie is longitudinal for each illustration. The attitude is one of flexion. Notice that the view of the top illustration is seen when facing the pregnant woman. The bottom view is that seen with the woman in a dorsal recumbent position.

Gambar 5.6: Contoh Posisi Janin dalam Presentasi Verteks.

Letaknya membujur untuk setiap ilustrasi. Sikapnya adalah fleksi. Perhatikan bahwa pandangan ilustrasi atas terlihat saat menghadap wanita hamil. Pandangan bawah terlihat saat wanita dalam posisi berbaring telentang.

d. Gerakan Kardinal Persalinan

Janin mengalami banyak perubahan posisi saat bergerak melalui jalan lahir. Perubahan posisi ini dikenal sebagai gerakan kardinal persalinan. Gerakan ini disengaja spesifik, dan sangat tepat yang memungkinkan diameter terkecil kepala janin melewati diameter struktur panggul ibu yang sesuai (Gambar 5.7)

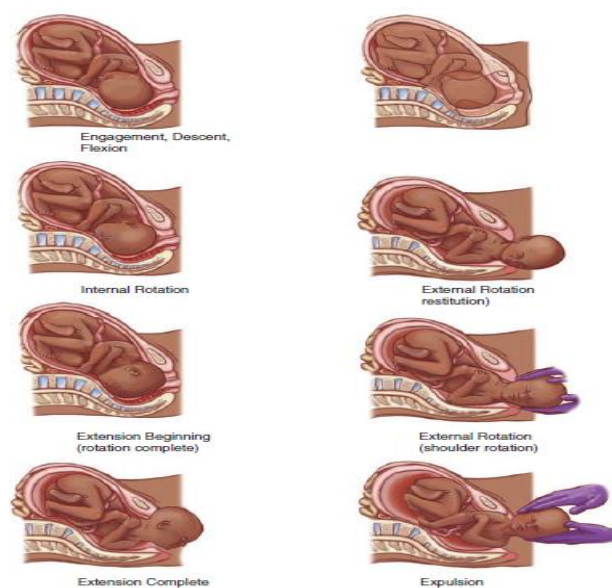


FIGURE 13.11 Cardinal movements of labor.

Gambar 5.7: Gerakan Kardinal Persalinan

3. Power/ Kekuatan

Power berkaitan dengan frekuensi, durasi dan kekuatan kontraksi uterus untuk membuat effacement dan dilatasi serviks komplis. Stimulus utama yang menggerakkan persalinan adalah kontraksi uterus. Kontraksi menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks secara menyeluruh selama tahap pertama persalinan.

Kontraksi uterus bertanggung jawab untuk menipiskan dan melebarkan serviks, dan mendorong bagian presentasi ke arah segmen uterus bagian bawah. Dengan setiap kontraksi uterus, segmen atas uterus menjadi lebih pendek dan lebih tebal, sedangkan segmen pasif bawah dan serviks menjadi lebih panjang, lebih tipis, dan lebih mengembang. Dilatasi bergantung pada tekanan bagian presentasi dan kontraksi serta retraksi uterus. Diameter os serviks meningkat dari kurang dari 1 cm menjadi sekitar 10 cm untuk memungkinkan kelahiran. Ketika serviks melebar sepenuhnya, serviks tidak lagi teraba pada pemeriksaan vagina.

Kontraksi uterus dipantau dan dinilai menurut tiga parameter: frekuensi, durasi, dan intensitas. (1) Frekuensi mengacu pada seberapa sering kontraksi terjadi dan diukur dari peningkatan satu kontraksi ke peningkatan kontraksi berikutnya. (2). Durasi mengacu pada berapa lama kontraksi berlangsung dan diukur dari awal peningkatan hingga akhir penurunan untuk kontraksi yang sama. (3) Intensitas mengacu pada kekuatan kontraksi yang ditentukan dengan palpasi manual atau diukur dengan kateter intrauterin internal (IUPC). Kateter diposisikan di rongga uterus melalui serviks setelah selaput ketuban pecah. Kateter melaporkan intensitas dengan mengukur tekanan cairan ketuban di dalam uterus dalam milimeter merkuri (Edmonds, 2007).

4. Respons Psikologis

Melahirkan dapat menjadi salah satu pengalaman yang paling mengubah hidup bagi seorang wanita. Pengalaman melahirkan melampaui aspek fisiologis: hal itu memengaruhi kepercayaan diri, harga diri, dan pandangan hidup, hubungan, dan anak-anak. Keadaan pikiran (psikis) selama seluruh proses sangat penting untuk menghasilkan hasil positif bagi dirinya dan keluarganya. Faktor-faktor yang mendukung pengalaman melahirkan yang positif meliputi: (1) Informasi yang jelas tentang prosedur (2) Dukungan; dari keluarga/tidak sendirian (2) Rasa percaya diri (3) Kepercayaan pada staf yang merawatnya (4) Reaksi positif terhadap kehamilan (5) Kontrol pribadi atas pernapasan (6) Persiapan untuk pengalaman melahirkan

5. Posisi Ibu

Posisi berbaring telentang dan tidak bergerak selama persalinan tidaklah sehat (Hanson 2006). Namun, meskipun ada bukti yang bertentangan, sebagian besar wanita tetap berbaring telentang selama persalinan. Beberapa alasan mengapa praktik ini terus berlanjut adalah sebagai berikut: (1) Kepercayaan bahwa ibu yang akan melahirkan perlu menghemat energi mereka dan tidak membuat diri mereka lelah (2) Kepercayaan bahwa perawat tidak dapat melacak keberadaan ibu yang sedang berjalan (3) Kepercayaan bahwa posisi berbaring memudahkan pemeriksaan vagina dan penyesuaian sabuk eksternal (*External Belt Adjustment*) (4) Kepercayaan bahwa tempat tidur adalah "tempat yang seharusnya" di lingkungan rumah sakit (5) Kepercayaan bahwa posisi tersebut lebih nyaman bagi tenaga kesehatan yang melahirkan (6) Kepercayaan bahwa ibu yang akan melahirkan "terhubung dengan hal-hal" yang menghambat gerakan (Hanson, 2006)

Penggunaan posisi tegak atau menyamping, dibandingkan dengan posisi terlentang atau litotomi, dapat: (1) Mengurangi lamanya kala satu persalinan (2) Mengurangi durasi kala dua persalinan (3) Mengurangi jumlah persalinan dengan bantuan (vakum dan forseps) (4) Mengurangi episiotomi dan robekan perineum (5) Berkontribusi pada berkurangnya pola denyut jantung janin yang tidak normal (6) Meningkatkan kenyamanan/mengurangi permintaan obat pereda nyeri (7) Meningkatkan rasa kontrol oleh ibu (8) Mengubah bentuk dan ukuran panggul, yang membantu penurunan (9) Membantu gravitasi untuk menggerakkan janin ke bawah (Simkin & Ancheta, 2006).

6. Philosophy/ Filsafat

Tidak semua orang memandang persalinan dengan cara yang sama. Ada kontinum filosofis yang meluas dari memandang persalinan sebagai proses penyakit hingga proses normal. Salah satu filosofi berasumsi bahwa perempuan tidak dapat mengelola pengalaman melahirkan memadai dan karenanya memerlukan pemantauan dan pengelolaan ahli yang konstan. Filosofi lainnya mengasumsikan bahwa wanita adalah individu yang mampu, berakal sehat, dan dapat berpartisipasi aktif dalam pengalaman melahirkan.

Selama tahun 1970-an, perawatan maternitas yang berpusat pada keluarga dikembangkan sebagai respons terhadap reaksi konsumen terhadap depersonalisasi kelahiran. Harapannya adalah untuk menggeser filosofi dari "teknologisasi" ke personalisasi untuk memanusiakan persalinan. Istilah "persalinan yang berpusat pada keluarga" lebih tepat saat ini untuk menunjukkan pendekatan berteknologi rendah dan berteknologi tinggi yang diminta oleh banyak wanita yang melahirkan, yang memandang persalinan sebagai proses

normal. Apapun filosofi yang dianut, idealnya semua pihak yang terlibat dalam proses persalinan, mulai dari penyedia layanan kesehatan hingga ibu, memiliki filosofi yang sama terhadap proses persalinan

7. Partner/Mitra

Wanita menginginkan dukungan dan perhatian penuh selama persalinan dan kelahiran. Pengasuh dapat memberikan dukungan emosional dengan menawarkan kehadiran berkelanjutan dan kata-kata penyemangat. Di seluruh dunia, hanya sedikit wanita yang dibiarkan bersalin sendirian: dukungan emosional, fisik, atau spiritual selama persalinan merupakan norma bagi sebagian besar budaya (Ballen & Fulcher, 2006). Mitra yang peduli dapat menggunakan pijat, sentuhan ringan, akupresur, pegangan tangan, belaian, dan relaksasi, dapat membantu wanita mengomunikasikan keinginannya kepada staf, dan dapat memberikan kehadiran yang terus-menerus dan meyakinkan, yang semuanya memberikan sedikit rasa nyaman bagi wanita yang bersalin (Ballen & Fulcher, 2006). Meskipun kehadiran ayah bayi saat kelahiran memberikan dukungan emosional khusus, mitra dapat berupa siapa saja (ibu atau saudara) yang hadir untuk mendukung wanita tersebut selama proses persalinan.

8. Patience/ Kesabaran

Proses persalinan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jika lebih banyak waktu diberikan bagi wanita untuk bersalin secara alami tanpa intervensi, angka kelahiran sesar kemungkinan besar akan berkurang (Simkin & Ancheta, 2006). Literatur menunjukkan bahwa menunda intervensi dapat memberi wanita cukup waktu untuk maju dalam persalinan dan mengurangi kebutuhan untuk intervensi bedah (*American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2007*).

Ketika ibu yang akan melahirkan merasakan dorongan untuk mengejan, dorongan pun dimulai. Kebanyakan ibu merespons pesan dari tubuh mereka dengan sangat baik tanpa diarahkan oleh perawat. Pendekatan yang lebih alami dan tidak diarahkan memungkinkan ibu untuk menunggu dan mengejan ketika ia merasakan dorongan untuk mengejan. Memiliki kesabaran dan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya akan mengurangi kejadian stres fisiologis pada ibu, sehingga mengurangi trauma pada jaringan perineumnya.

9. Persiapan Pasien

Pendidikan sebelum melahirkan (prenatal) dasar dapat membantu wanita mengelola proses persalinan dan merasa memegang kendali atas pengalaman melahirkan mereka. Literatur menunjukkan bahwa jika seorang wanita dipersiapkan sebelum persalinan dan pengalaman melahirkan, persalinan lebih mungkin tetap normal atau alami (tanpa perlu intervensi medis) (Gagnon, 2006). Semakin banyak bukti juga menunjukkan bahwa wanita yang dipersiapkan

dengan baik, dengan dukungan persalinan yang baik, cenderung tidak memerlukan analgesia atau anestesi dan tidak mungkin memerlukan operasi caesar (Risica & Phipps, 2006). Pendidikan prenatal mengajarkan wanita tentang pengalaman melahirkan dan meningkatkan rasa kendalinya. Dia kemudian dapat bekerja sebagai peserta aktif selama persalinan dan pengalaman melahirkan (Brodsky, 2006). Pendidikan pranatal harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat keluarga dengan memberikan bimbingan antisipatif dan meningkatkan keterampilan hidup anggota keluarga. Singkatnya, pendidikan pranatal membantu mempromosikan keluarga yang sehat selama transisi menjadi orang tua dan seterusnya (Polomeno, 2006).

10. Pain Management/ Manajemen Nyeri Selama Peralinan

Persalinan dan kelahiran, meskipun merupakan proses fisiologis yang normal, dapat menimbulkan nyeri yang signifikan. Nyeri selama persalinan merupakan pengalaman yang hampir universal. Mengendalikan nyeri tanpa membahayakan janin atau proses persalinan merupakan fokus utama manajemen nyeri selama melahirkan.

Nyeri merupakan pengalaman subjektif yang melibatkan interaksi kompleks dari pengaruh fisiologis, spiritual, psikososial, budaya, dan lingkungan (Smith et al., 2006). Nilai-nilai budaya dan perilaku yang dipelajari memengaruhi persepsi dan respons terhadap nyeri, seperti halnya kecemasan dan ketakutan, yang keduanya cenderung meningkatkan rasa nyeri (Walsh, 2007). Tantangan bagi penyedia layanan kesehatan adalah menemukan kombinasi metode manajemen nyeri yang tepat untuk menjaga nyeri tetap terkendali sambil meminimalkan efek negatif pada janin, fisiologi persalinan yang normal, ikatan ibu-bayi, menyusui, dan persepsi wanita tentang persalinan itu sendiri.

D. Kala I Persalinan/Kala Pembukaan

Kala I disebut juga kala pembukaan dimulai sejak terjadinya his adekuat servik membuka, hingga pembukaan lengkap (10.cm). Selama tahap pertama persalinan, perubahan mendasar yang mendasari proses ini adalah dilatasi serviks yang progresif. Dilatasi serviks diukur secara subjektif melalui pemeriksaan vagina dan dinyatakan dalam sentimeter. Tahap pertama berakhir ketika serviks melebar hingga diameter 10 cm dan cukup besar untuk memungkinkan lewatnya kepala janin berukuran rata-rata.

Selaput janin, atau kantung ketuban, biasanya pecah selama tahap pertama, tetapi mungkin pecah lebih awal atau bahkan tetap utuh sampai lahir. Bagi primigravida, tahap pertama persalinan berlangsung sekitar 12 jam. Namun, waktu ini dapat sangat bervariasi: bagi wanita multipara, biasanya hanya setengahnya.

Selama tahap pertama persalinan, wanita biasanya merasakan nyeri viseral akibat kram perut yang menyebar dan kontraksi rahim. Nyeri pada kala I persalinan terutama disebabkan oleh dilatasi serviks dan segmen bawah rahim, serta peregangan (peregangan) struktur tersebut selama kontraksi. Kala I dibagi menjadi tiga fase: fase laten atau awal, fase aktif, dan fase transisi.

1. Fase Laten atau Awal

Fase laten atau awal menimbulkan tanda-tanda dan gejala persalinan yang sudah dikenal. Fase ini dimulai dengan dimulainya kontraksi teratur dan berakhir saat dilatasi serviks yang cepat dimulai. Penipisan serviks terjadi selama fase ini, dan serviks melebar dari 0 hingga 3 cm. Kontraksi biasanya terjadi setiap 5 hingga 10 menit, berlangsung 30 hingga 45 detik, dan digambarkan sebagai ringan dengan palpasi. Penipisan serviks terjadi dari 0% hingga 40%. Kebanyakan wanita sangat banyak bicara selama periode ini, menganggap kontraksi mereka mirip dengan kram menstruasi.

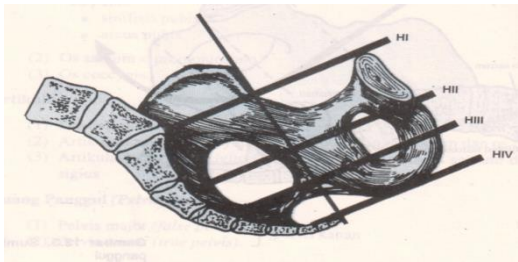
2. Fase Aktif

Dilatasi serviks mulai terjadi lebih cepat selama fase aktif. Serviks biasanya melebar dari 4 hingga 7 cm, dengan 40% hingga 80% penipisan terjadi. Fase ini dapat berlangsung hingga 6 jam untuk wanita nulipara dan 4,5 jam untuk wanita multipara (Simkin & Ancheta, 2006). Janin turun lebih jauh di panggul. Kontraksi menjadi lebih sering (setiap 2 hingga 5 menit) dan durasinya meningkat (45 hingga 60 detik). Ketidaknyamanan wanita meningkat (sedang hingga kuat saat dipalpasi). Kecepatan dilatasi yang umum bagi wanita nulipara adalah 1,2 cm/jam, sedangkan bagi wanita multipara adalah 1,5 cm/jam (Cunningham et al., 2005).

3. Fase Transisi

Fase transisi adalah fase terakhir dari tahap pertama persalinan. Selama fase ini, dilatasi melambat, berkembang dari 8 menjadi 10 cm, dengan penipisan dari 80% menjadi 100%. Fase transisi adalah fase yang paling sulit dan, untungnya, fase terpendek bagi wanita, berlangsung sekitar 1 jam pada kelahiran pertama dan mungkin 15 hingga 30 menit pada kelahiran berikutnya (Walsh, 2007). Selama transisi, kontraksi lebih kuat (keras saat diraba), lebih menyakitkan, dan lebih sering (setiap 1 hingga 2 menit), dan berlangsung lebih lama (60 hingga 90 detik). Rata-rata laju penurunan janin adalah 1 cm/jam pada wanita nulipara dan 2 cm/jam pada wanita multipara. Tekanan pada rektum sangat besar, dan ada keinginan kuat untuk mengontraksikan otot perut dan mengejan. Fase ini tidak boleh berlangsung lebih dari 3 jam untuk nulipara dan 1 jam untuk multipara (Cunningham et al., 2005).

Langkah- langkah pemeriksaan fisik pada kala I adalah : cuci tangan sebelum melakukan tindakan, bersikap ramah, sopan & tentramkan hati ibu, minta ibu mengosongkan kandung kemih, nilai kesehatan dan ku, nilai tanda-tanda vital ibu, lakukan pemeriksaan abdomen lakukan pemeriksaan dalam. anamneses meliputi : indentifikasi klien, gravida, para, abortus, anak hidup, hpht, taksiran partus/persalinan, riwayat penyakit (sebelum, selama kehamilan) termasuk alergi, riwayat persalinan yang lalu, riwayat penyakit keluarga. Lakukan pemeriksaan fisik pada Ibu hamil tentang : Pemeriksaan abdomen: menentukan tinggi fundus uteri, menentukan presentasi dan letak janin, menentukan penurunan bagian bawah janin, memantau denyut jantung janin, menilai kontraksi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk tanda-tanda vital ibu: tekanan darah ibu, nadi dan suhu. Lakukan Pemeriksaan dalam meliputi : Tentukan konsistensi dan pendataran serviks, mengukur besarnya pembukaan, menilai selaput ketuban , menentukan presentasi dan seberapa jauh bagian bawah telah melalui jalan lahir.

	1. Bidang Hodge I: Promontorium pinggir atas simfisis 2. Bidang Hodge II: Pinggir bawah simfisis 3. Bidang Hodge III: Spina Ischiadika 4. Bidan Hodge IV: Ujung coccygeus
---	--

Gambar 5.8: Bidang-bidang Hodge

Riwayat yang harus diperhatikan adalah : pernah bedah sesar, riwayat perdarahan per vagina berulang, prematuritas atau tidak cukup bulan, ketuban pecah disertai mekoneum kental, ketuban pecah lama (> 12 jam), ketuban pecah pada persalinan < bulan, ikterus, anemia berat, tanda gejala infeksi, pre-eklampsia / hipertensi dalam kehamilan, tinggi fundus uteri 40 cm atau lebih, gawat janin, primipara fase aktif kala I persalinan kepala janin 5/5, presentasi bukan belakang kepala, presentasi majemuk (ganda), kehamilan ganda (gemeli), tali pusat menumbung, syok atau keadaan umum jelek, inersia uteri atau fase laten memanjang, partus lama atau kasep.

Persiapan asuhan persalinan normal meliputi : Persiapan ruangan, peralatan penunjang, peralatan//obat-obatan dan persiapan rujukan. Persiapan ruangan yang cukup hangat, sumber air mengalir cukup, kamar mandi yang bersih, ruang persalinan & bayi yang bersih (meja resusitasi), cahaya/penerangan yang cukup. Peralatan penunjang / untuk: kebersihan diri, pengendalian infeksi (pi), bahan-bahan linen. Peralata/obat-obatan: Alat-alat untuk partus/resusitasi, Obat-obatan. Persiapan rujukan : fasilitas kesehatan yang lengkap dan baksoku do.

E. Kala II Persalinan (Kala Pengeluaran)

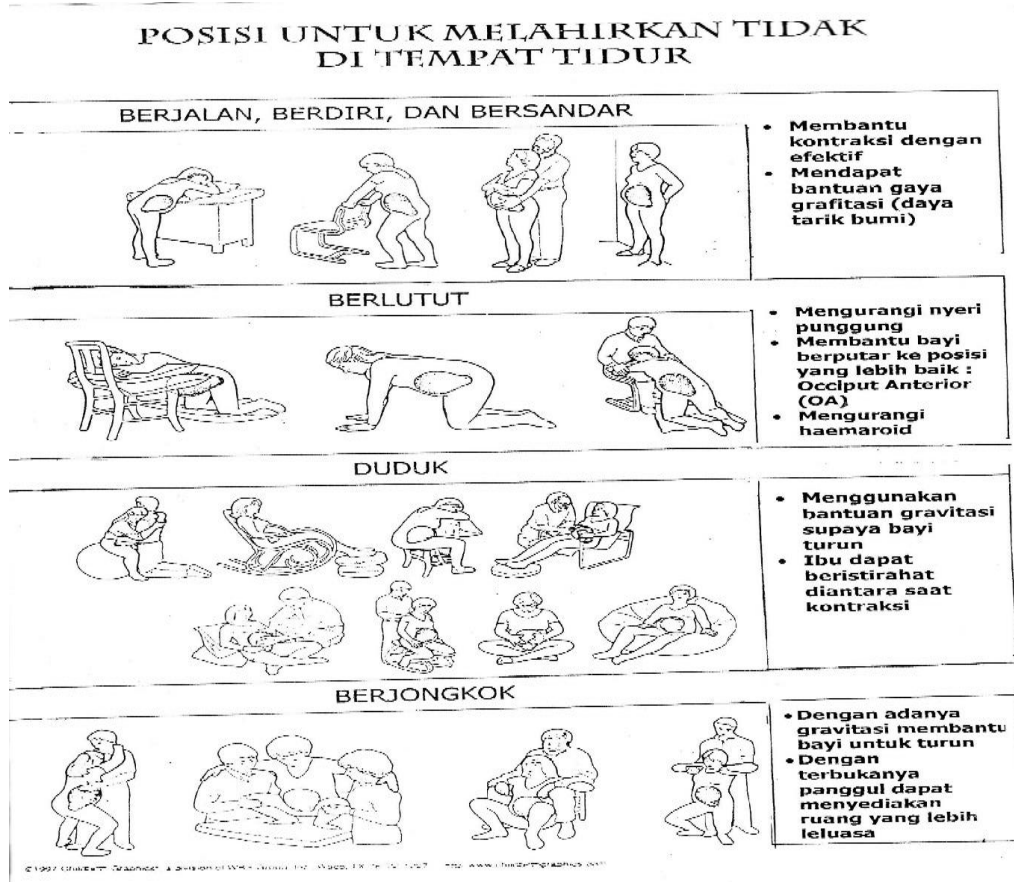
Tahap kedua persalinan dimulai dengan dilatasi serviks lengkap (10 cm) dan penipisan, serta berakhir dengan kelahiran bayi baru lahir. Meskipun tahap persalinan sebelumnya terutama melibatkan penipisan dan pembukaan serviks, tahap ini melibatkan pergerakan janin melalui jalan lahir dan keluar dari tubuh. Gerakan utama persalinan terjadi selama fase awal penurunan pasif pada tahap kedua persalinan.

Tanda dan gejala kala II adalah : adanya rasa ingin meneran saat kontraksi, adanya dorongan pada rektum atau vagina, perineum terlihat menonjol, vulva dan sfingter ani membuka serta peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Tanda-tanda persalinan akan terjadi adalah : (1) *Lightening* : Turunnya fetus dan uterus ke dalam rongga pelvik 2 – 3 minggu (2) Kontraksi *Braxton Hicks* : Tidak teratur, intermittent yang sudah terjadi selama hamil menjadi tidak nyaman dan mengakibatkan nyeri yang tertarik di perut dan pangkal paha. Tanda-Tanda Inpartu : his sudah teratur, frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit, penipisan dan pembukaan serviks keluar cairan dari vagina berbentuk lendir campur darah. His persalinan dikatakan adekuat apabila his teratur minimal 2 kali dalam 10 menit, lamanya > 40 ", uterus mengeras saat kontraksi, tidak ada cekungan bila ditekan dan serviks membuka.

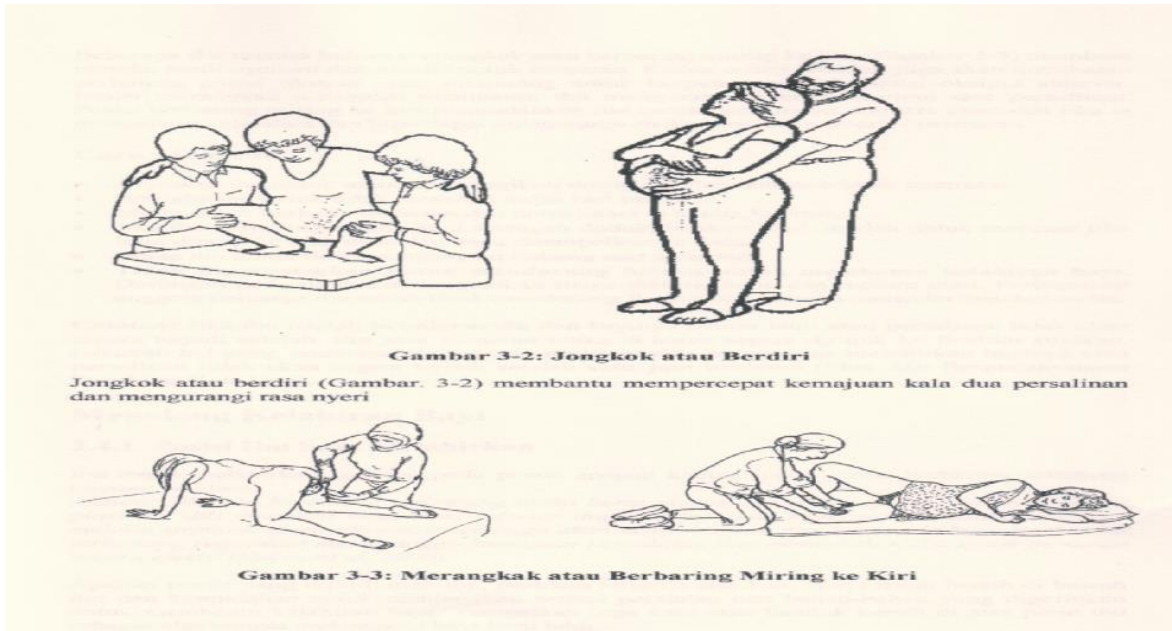
Kontraksi terjadi setiap 2 hingga 3 menit, berlangsung 60 hingga 90 detik, dan digambarkan kuat melalui palpasi. Rata-rata lamanya tahap kedua persalinan pada nulipara adalah sekitar 1 jam dan kurang dari setengah waktu tersebut untuk multipara. Selama tahap pengeluaran ini, ibu biasanya merasa lebih terkendali dan tidak mudah tersinggung serta gelisah. Ia berfokus pada upaya mengejan. Secara tradisional, wanita diajarkan untuk menahan napas hingga hitungan ke-10, menarik napas lagi, mengejan lagi, dan mengulangi proses tersebut beberapa kali selama kontraksi. Gaya mengejan yang kuat dan berkelanjutan ini terbukti menyebabkan perubahan hemodinamik pada ibu dan mengganggu pertukaran oksigen antara ibu dan janin. Selain itu, hal ini dikaitkan dengan kerusakan dasar panggul: semakin lama mengejan, semakin banyak kerusakan pada dasar panggul (Hanson, 2006).

Persiapan menolong Persalinan adalah : (1) Sarung tangan dan barrier protektif lainnya, (2) Tempat bersalin, (3) Peralatan dan bahan yang diperlukan, (4) Tempat meletakkan dan lingkungan yang nyaman bagi bayi, (5) Penyiapan ibu dan keluarganya (Asuhan Sayang Ibu), Penatalaksanaan Kala II adalah : (1) Pembukaan lengkap, pimpin untuk meneran bila timbul dorongan spontan Beristirahat diantara dua kontraksi (2) Atur posisi yang nyaman bagi ibu (3) Pantau kondisi janin (4) Bila ingin meneran, tapi pembukaan belum lengkap, atur nafas, dan anjurkan rubah posisi yang nyaman bagi ibu.

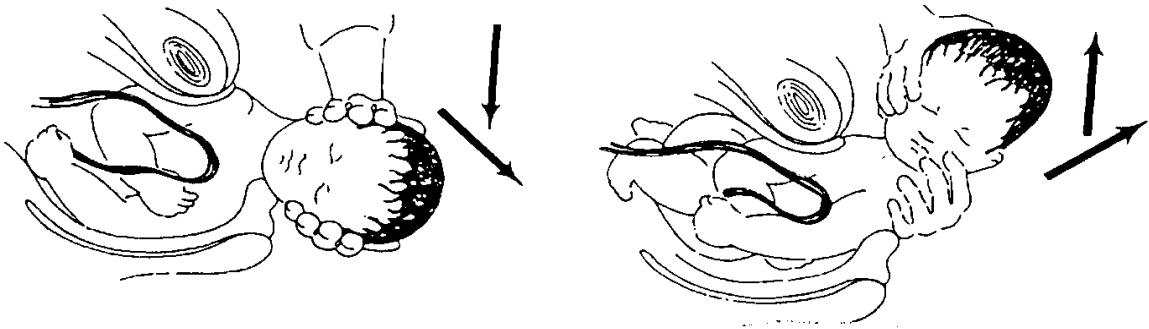
Membimbing Ibu untuk meneran Bila ada tanda pasti Kala II : (1) cuci tangan (2) Pakai sarung tangan (3) Lakukan periksa dalam (4) Bila ibu ingin meneran, tapi pembukaan belum lengkap, ajarkan cara mengatur bernafas (5) Pembukaan lengkap tapi ibu tidak ada dorongan meneran, bantu ibu rubah posisi (6) Jika tetap tidak ada dorongan meneran selama 60 menit, anjurkan ibu untuk meneran, saat puncak his Bila 60 menit meneran tidak berhasil, segera rujuk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pimpinan meneran adalah : (1) Dukungan Ibu Yang Akan Melahirkan Bayinya2. Posisi (2) Meneran (3) Cara Bernafas Diantara his / Saat Meneran.



Gambar 5.9: Posisi untuk Melahirkan Tidak di Tempat Tidur



Gambar 5.10: Posisi untuk Melahirkan Tidak di Tempat Tidur



Gambar 5.11: Melahirkan Bahu Depan dan Belakang



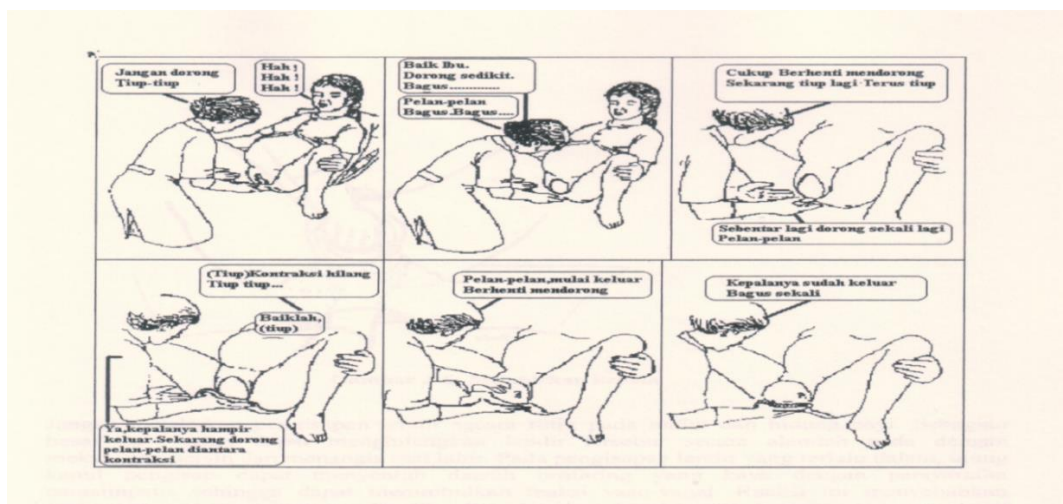
Gambar 5.12: Melahirkan Bahu, Tubuh dan Tungkai

Pemantauan pelaksanaan kala II terhadap kondisi ibu dan janin : nadi ibu dipantau setiap 30 menit, frekuensi dan lama kontraksi setiap 30 menit, denyut jantung janin (djj) setelah meneran atau kontraksi, penurunan kepala (palpasi luar) setiap 30 menit atau jika ada indikasi, lakukan pemeriksaan dalam setiap 60 menit, kondisi selaput ketuban dan warna cairan ketuban, kemungkinan adanya presentasi majemuk, putaran paksi luar (setelah lahirnya kepala bayi), pencatatan hasil pemeriksaan dan intervensi.

Pada saat pengeluaran/persalinan bayi perhatikan hal-hal berikut : posisi ibu saat melahirkan, cegah terjadinya laserasi atau trauma, proses melahirkan kepala, memeriksa lilitan tali pusat pada leher bayi, proses melahirkan bahu, proses melahirkan tubuh bayi, tidak usap muka, saat kepala lahir, tidak membersihkan tangan saat mengeringkan tubuh bayi (rangsang taktil), memotong tali pusat setelah 2 menit kelahiran bayi.

Bila pembukaan lengkap tetapi ibu tidak ada dorongan meneran, anjurkan untuk mobilisasi atau mengubah-ubah posisi hingga timbul dorongan untuk meneran. Bila kontraksi kuat tetapi ibu tidak ingin meneran setelah 60 menit dari sejak pembukaan lengkap, pimpin untuk meneran saat kontraksi puncak (beri asupan yang cukup). Bila 60 menit setelah itu kelahiran bayi masih belum terjadi, rujuk ibu kefasilitas rujukan.

Cara meneran yang baik adalah : Anjurkan ibu meneran secara alamiah, beri tahu tidak menahan nafas saat meneran, anjurkan ibu untuk beristirahat saat tidak ada his, anjurkan ibu untuk dagu menempel didada, mulut dibuka, lutut tarik kearah dada, minta ibu tidak mengangkat bokong saat meneran serta tidak sekali-kali mendorong fundus uteri untuk melahirkan bayi.



Disadur dari Beck, Buffington & Mc Dermot, 1998

Gambar 5.13: Bimbingan saat Membantu Kelahiran Kepala Bayi

Episiotomi tidak dilakukan secara rutin. Bila dilakukan tidak tepat waktu dan prosedurnya salah, terjadi peningkatan jumlah perdarahan, laserasi akan meningkat menjadi derajat 3 atau 4 dan kejadian hematoma, menyebabkan nyeri pasca salin dan meningkatkan risiko infeksi. Indikasi dilakukan episiotomy adalah : Terjadi gawat janin dan persalinan dengan tindakan/bantuan alat (ekstraksi cunam atau vakum), adanya penyulit (distosia bahu, persalinan sungsang, bayi besar), adanya parut yang menghambat proses pengeluaran bayi

Jenis Episiotomi adalah, median, lateral dan mediolateral. Ibu segera dirujuk ke Rumah sakit apabila : syok, dehidrasi, infeksi, pre eklampsia/eklampsia, inersia uteri, gawat janin, kepala janin tidak turun, tanda dan gejala distosia bahu, cairan ketuban campur mekoneum, tali pusat menumbung dan lilitan tali pusat, kehamilan kembar tidak terdeteksi

F. Kala III Persalinan (Kala Uri/Placenta)

Tahap ketiga persalinan dimulai dengan kelahiran bayi baru lahir dan berakhir dengan pemisahan dan kelahiran plasenta. Tahap ini terdiri dari dua fase: pemisahan plasenta dan pengeluaran plasenta. Pelepasan Plasenta Setelah bayi lahir, rahim terus berkontraksi dengan kuat dan sekarang dapat ditarik kembali, sehingga ukurannya mengecil secara signifikan.

Kala III disebut juga Kala Placenta. Mulai dari lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya placenta dan pengeluaran placenta. Tanda-tanda pelepasan placenta Uterus menjadi globular, fundus tinggi di perut, tali pusat memanjang dan perdarahan meningkat (menetes atau menyembur). Kontraksi uterus mengontrol perdarahan uterine dan membantu pemisahan dan pengeluaran placenta. Obat oxytocin umumnya diberikan untuk membantu kontraksi uterus. Manajemen Aktif Kala III adalah Masa setelah lahirnya bayi sampai berlangsungnya proses pengeluaran plasenta. Fisiologi Kala III, tempat implantasi plasenta mengalami pengerutan, Plasenta dilepaskan dari perlekatannya, Pengumpulan darah pada ruang utero-plasenter akan mendorong plasenta ke luar. Setelah ketuban keluar dan bayi lahir maka volume uterus mengecil, placenta mulai lepas. Perdarahan mulai terjadi (350 – 500 ml/menit, kontraksi uterus terjadi untuk menghentikan perdarahan. Pada saat ini perlu dilakukan Manajemen aktif kala III agar kala III lebih singkat, mengurangi jumlah perdarahan yang hilang serta mengurangi kejadian retensio plasenta.

Tiga langkah utama manajemen aktif Kala III adalah : (1) Pemberian oksitosin/uterotonika sesegera mungkin (2) Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT) (3) Masase fundus uteri setelah plasenta lahir (rangsang taktil pada

dinding uterus atau fundus uteri). Penegangan tali pusat terkendali (PTT) adalah: (1) Perawat Berdiri disamping ibu, Pindahkan jepitan tali pusat 5 – 10 cm dari vulva dan tegangkan klem jepitan tsb, Letakkan telapak tangan (alas kain) yang lain pada segmen bawah rahim atau dinding uterus di Supra Simfisis.. Pada saat terjadi kontraksi, tegangkan tali pusat sambil tekan uterus kearah dorso kranial. Ulangi kembali perasat ini bila plasenta belum dapat dilahirkan (jangan lakukan pemaksaan). Perhatikan bila setelah 15 menit berlalu ternyata plasenta belum lahir, berikan oksitosin 10 iu dosis ke 2. kosongkan kandung kemih bila penu, lakukan ptt ulang. bila 30 menit terlapau tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, bila tidak terjadi perdarahan segera rujuk ke fasilitas kesehatan yang lengkap, bila perdarahan banyak lakukan manual plasenta.

Rangsang taktil fundus uteri dilakukan dengan cara : letakkan telapak tangan pada fundus uteri, jelaskan pada ibu, dengan lembut gerakan tangan memutar searah jarum jam selama 15 detik (15x). jika tak ada kontraksi lakukan penatalaksanaan atoni uteri. periksa uterus setelah 1-2 menit. periksa kembali kontraksi uterus setiap 15 menit, Mengajarkan ibu untuk melakukan rangsang taktil pada dinding uterus dengan cara : Minta ibu untuk meletakkan telapak tangannya pada dinding uterus, instruksikan untuk mengusap dinding uterus dengan gerakan sirkuler, beritahukan bahwa mungkin timbul rasa kencang atau tidak nyaman, uterus yang mengencang menunjukkan respon adekuat terhadap rangsangan, teruskan rangsangan taktil, bila uterus masih belum berkontraksi. Pemeriksaan tonus uteri dilakukan 2 – 3 kali dalam 10 menit pertama, setiap 15 menit pada jam pertama. setiap 30 menit pada jam ke dua.

Petugas harus mengiungat tiga tanda lepasnya plasenta : (1) Perubahan ukuran dan bentuk Rahim (2) Tali pusat memanjang (3) Semburan darah (tidak semua terjadi). Jangan melakukan penegangan Tali Pusat Terkendali tanpa penekanan Uterus di Daerah Supra Pubik ke arah Dorso Kranial dengan Tangan yang lain. Ingat bahwa seorang wanita dapat meninggal karena perdarahan post partum dalam 1 jam setelah melahirkan, karena itu penatalaksanaan yang cermat selama persalinan kala tiga & empat sangat penting

Jika plasenta tidak keluar secara spontan, tenaga kesehatan membantu mengeluarkannya dengan cara mengeluarkannya secara manual. Saat mengeluarkannya, plasenta diperiksa keutuhannya oleh tenaga kesehatan dan perawat untuk memastikan semua bagiannya ada. Jika ada bagian yang masih menempel di dinding rahim, wanita tersebut berisiko mengalami pendarahan pascapersalinan karena bagian tersebut menjadi objek yang menempati ruang dan mengganggu kemampuan rahim untuk berkontraksi secara penuh dan efektif.

G. Kala IV Persalinan (2-4 Jam Post Partum)

Tahap keempat dimulai dengan selesainya pengeluaran plasenta dan selaput ketuban dan berakhir dengan penyesuaian fisiologis awal dan stabilisasi ibu (1 hingga 4 jam setelah melahirkan). Tahap ini mengawali periode pascapersalinan. Ibu biasanya merasa damai dan gembira, sangat terjaga, dan awalnya sangat banyak bicara. Proses perlekatan dimulai dengan memeriksa bayi baru lahirnya dan ingin memeluk serta menyusunya. Fundus ibu harus kencang dan berkontraksi dengan baik. Biasanya terletak di garis tengah antara pusar dan simfisis, tetapi kemudian perlahan naik ke tingkat pusar selama jam pertama setelah melahirkan (Walsh, 2007). Jika rahim menjadi lembek, rahim dipijat agar tetap kencang. Lokia (keputihan) berwarna merah, bercampur dengan gumpalan kecil, dan alirannya sedang. Jika wanita tersebut telah menjalani episiotomi selama tahap kedua persalinan, episiotomi tersebut harus utuh, dengan tepi yang berdekatan, bersih, dan tidak ada kemerahan atau edema.

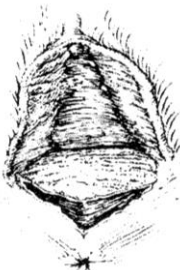
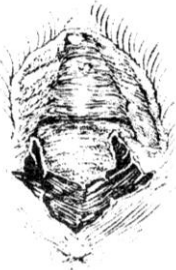
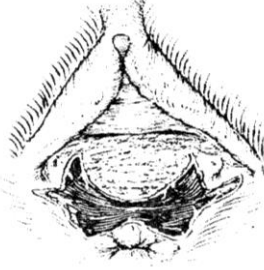
Fokus selama tahap ini adalah memantau ibu secara ketat untuk mencegah pendarahan, distensi kandung kemih, dan trombosis vena. Tanda-tanda vital, jumlah dan konsistensi cairan vagina (lochia), dan fundus uterus biasanya dipantau setiap 15 menit selama minimal 1 jam. Wanita tersebut akan merasakan ketidaknyamanan seperti kram selama waktu ini karena kontraksi rahim.

Pemantauan Kala IV setelah plasenta lahir adalah melakukan pemeriksaan : Kelengkapan plasenta dan selaput ketuban, Perkirakan jumlah perdarahan yang hilang, Melakukan pemeriksaan perineum apakah terdapat laserasi atau luka Episiotomi dengan perdarahan aktif, memeriksa keadaan umum ibu. Tonus uterus diperiksa 2 – 3 kali dalam 10 menit, Setiap 15 menit pada jam pertama dan Setiap 30 menit pada jam kedua. Pemantauan Kala IV adalah : Nilai kontraksi uterus dan jumlah perdarahan, Anjurkan ibu dan keluarganya untuk melakukan Rangsang taktil, menilai kontraksi uterus dan estimasi perdarahan, Rawat gabung Ibu-Bayi dan pemberian ASI (IMD), Berikan Asuhan esensial BBL.

Memperkirakan jumlah perdarahan: Belum ada metode yang akurat, meletakkan penampungan darah dibawah bokong ibu, selain tidak nyaman juga tidak menjamin pengukuran yang tepat. Pengukuran dengan gelas ukuran dapat terganggu dengan tambah cairan lain atau jumlah hilang akibat material penyerap (kain, kasa, pakaian, dsb). Estimasi gejala perdarahan Bila perdarahan menyebabkan terjadinya perubahan pada tanda vital (hipotensi) maka jumlah darah yang keluar telah mencapai 1.000 – 1.200 ml. Bila terjadi syok hipovolemik maka jumlah darah telah mencapai 2.000 – 2.500 ml.

Perawat selalu ingat, jangan tinggalkan ibu dalam 2 jam pertama pasca persalinan, pastikan tanda vital dalam batas normal, berikan asuhan esensial bbl, termasuk pemberian asi dalam 1 jam pertama, ajarkan ibu dan keluarganya untuk melakukan rangsangan taktil uterus dan nilai kontraksi atau perdarahan, pastikan ibu dan keluarganya mengetahui tanda-tanda bahaya atau komplikasi berat

Penjahitan laserasi perineum atau luka episiotomy. Tujuan penjahitan luka laserasi perineum atau episiotomi adalah untuk : Mendekatkan/merapatkan jaringan, Menghentikan perdarahan/hemostasis. Setiap tusukan jarum adalah trauma, jadi usahakan menjahit sedikit mungkin.

Derajat satu	Derajat dua	Derajat tiga	Derajat empat
			
▪ Mukosa vagina ▪ Fourchette Posterior ▪ Kulit Perineum	▪ Mukosa Vagina ▪ Fuorchette posterior ▪ Kulit perineum ▪ Otot Perineum	▪ Mukosa Vagina ▪ Fuorchette posterior ▪ Kulit perineum ▪ Otot Perineum ▪ Otot Sfingter Ani	▪ Mukosa Vagina ▪ Fourchette posterior ▪ Kulit perineum ▪ Otot Perineum ▪ Otot Sfingter Ani ▪ Dinding rektum Anterior

Gambar 5.14: Kala IV Persalinan

H. Manajemen Nyeri Persalinan

Nyeri selama persalinan merupakan pengalaman universal, meskipun intensitas nyeri dapat bervariasi. Meskipun persalinan dan melahirkan dipandang sebagai proses alami, keduanya dapat menimbulkan nyeri dan ketidaknyamanan yang signifikan. Penyebab fisik nyeri selama persalinan meliputi peregangan serviks, hipoksia otot rahim akibat penurunan perfusi selama kontraksi, tekanan pada uretra, kandung kemih, dan rektum, serta distensi otot dasar panggul (Leonard, 2007). Persepsi nyeri seorang wanita dapat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dengan nyeri, kelelahan, antisipasi nyeri, sistem pendukung positif atau negatif,

lingkungan persalinan dan kelahiran, harapan budaya, dan tingkat stres emosional dan kecemasan (Albers, 2007).

Teknik yang digunakan untuk mengelola nyeri persalinan bervariasi menurut geografi dan budaya. Misalnya, beberapa wanita Appalachia percaya bahwa meletakkan kapak atau pisau di bawah tempat tidur wanita yang sedang bersalin dapat membantu "mengurangi rasa sakit saat melahirkan," dan wanita dari latar belakang ini mungkin ingin melakukannya di rumah sakit (Bowers, 2007). Wanita Asia, Latin, dan Yahudi Ortodoks mungkin meminta ibu mereka sendiri, bukan suami mereka, untuk menemani persalinan mereka; suami tidak berpartisipasi aktif dalam proses persalinan. Wanita Cherokee, Hmong, dan Jepang sering kali tetap diam selama persalinan dan melahirkan dan tidak mengeluhkan rasa sakit karena mengekspresikan rasa sakit secara terbuka tidak pantas dalam budaya mereka. Jangan pernah menafsirkan ketenangan mereka sebagai kebebasan dari rasa sakit (Bowers, 2007).

Keluarga yang memiliki anak dengan budaya yang beragam hadir di ruang bersalin dan melahirkan dengan kebutuhan dan keinginan yang sama dengan semua keluarga. Berikan mereka rasa hormat dan sambutan yang sama seperti yang ditunjukkan kepada semua keluarga. Pastikan mereka memiliki pengalaman melahirkan yang berkualitas tinggi: junjung tinggi nilai-nilai agama, etnis, dan budaya mereka dan integrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam perawatan. Saat ini, wanita memiliki banyak pilihan nonfarmakologis dan farmakologis yang aman untuk mengelola nyeri selama persalinan dan melahirkan, yang dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan satu sama lain. Perawat berada dalam posisi yang ideal untuk memberikan informasi yang seimbang, jelas, dan ringkas kepada wanita yang memiliki anak tentang tindakan nonfarmakologis dan farmakologis yang efektif untuk menghilangkan nyeri. Standar manajemen nyeri yang dikeluarkan oleh JCAHO mengamanatkan bahwa nyeri harus dinilai pada semua klien yang dirawat di fasilitas perawatan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memiliki pengetahuan tentang penelitian ilmiah terbaru tentang metode pereda nyeri persalinan, untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan tidak bias tentang metode pereda nyeri yang efektif tersedia bagi ibu yang akan melahirkan, untuk memastikan bahwa ibu menentukan tingkat nyeri persalinan yang dapat diterima baginya, dan untuk memungkinkan ibu memilih metode pereda nyeri.

1. Tindakan Nonfarmakologis

Tindakan nonfarmakologis dapat mencakup dukungan persalinan berkelanjutan, hidroterapi, ambulasi, dan perubahan posisi, akupunktur dan akupresur, pemusatan perhatian dan imajinasi, sentuhan dan pijat terapeutik, teknik pernapasan, dan *effleurage*. Sebagian besar metode ini didasarkan pada

teori *Gate Control*/"kontrol gerbang" nyeri, yang menyatakan bahwa rangsangan fisik lokal dapat mengganggu rangsangan nyeri dengan menutup gerbang hipotetis di sumsum tulang belakang, sehingga menghalangi sinyal nyeri mencapai otak (Arenson & Drake, 2007). Sudah lama menjadi standar perawatan bagi perawat persalinan untuk terlebih dahulu memberikan atau mendorong berbagai tindakan nonfarmakologis sebelum beralih ke intervensi farmakologis.

Tindakan nonfarmakologis biasanya sederhana, aman, dan murah untuk digunakan. Banyak dari tindakan ini diajarkan di kelas persalinan, dan wanita harus didorong untuk mencoba berbagai metode sebelum persalinan yang sebenarnya. Banyak tindakan yang perlu dipraktikkan untuk mendapatkan hasil terbaik dan dikoordinasikan dengan pasangan/pelatih. Perawat memberikan dukungan dan dorongan bagi wanita dan pasangannya dengan menggunakan metode nonfarmakologis. Meskipun wanita tidak dapat secara sadar mengarahkan kontraksi persalinan, mereka dapat mengendalikan cara mereka meresponsnya, sehingga meningkatkan perasaan kontrol mereka.



FIGURE 14.9 Various positions for use during labor. (A) Ambulation. (B) Leaning forward. (C) Sitting in a chair. (D) Using a birthing ball.

Gambar 5.15: Berbagai Posisi yang dapat digunakan Selama Persalinan. (A) Berjalan. (B) Condong ke Depan. (C) Duduk di Kursi. (D) Menggunakan Bola Persalinan

Tabel 5.2: Posisi Umum yang digunakan pada Saat Persalinan dan Kelahiran

Berdiri	• Memanfaatkan gravitasi selama dan di antara kontraksi • Membuat kontraksi terasa kurang nyeri dan lebih produktif • Membantu janin sejajar dengan sudut panggul ibu • Membantu meningkatkan dorongan untuk mengejan pada kala dua persalinan
Berjalan	• Memiliki keuntungan yang sama seperti berdiri • Menyebabkan perubahan pada sendi panggul, membantu janin bergerak melalui jalan lahir
Berdiri dan mencondongkan tubuh ke depan pada pasangan, tempat tidur, bola bersalin 	• Memiliki keuntungan yang sama seperti berdiri • Merupakan posisi yang baik untuk memijat punggung • Mungkin terasa lebih tenang daripada berdiri • Dapat digunakan dengan monitor janin elektronik
Menari pelan (berdiri dengan lengan wanita melingkari leher pasangan, kepala bersandar di dada atau bahunya, dengan tangannya mengusap punggung bawah wanita; bergoyang mengikuti alunan musik dan bernapas mengikuti irama jika itu membantu	• Memiliki manfaat yang sama dengan berjalan • Tekanan punggung membantu meredakan nyeri punggung • Irama dan musik membantu wanita rileks dan memberikan kenyamanan
Lunge (berdiri menghadap kursi lurus dengan satu kaki di kursi dengan lutut dan telapak kaki di samping; menekuk lutut dan pinggul yang diangkat, dan melakukan lunge ke samping berulang kali selama kontraksi, menahan setiap lunge selama 5 detik; pasangan memegang kursi dan membantu menjaga keseimbangan)	• Memperlebar satu sisi panggul (sisi yang mengarah ke lunge) • Mendorong rotasi bayi • Dapat juga dilakukan sambil berlutut
Duduk tegak	• Membantu meningkatkan istirahat

	• Memiliki lebih banyak keuntungan gravitasi daripada berbaring • Dapat digunakan dengan monitor janin elektronik
Setengah duduk (menempatkan kepala tempat tidur pada sudut 45 derajat dengan bantal sebagai penyangga)	• Memiliki keuntungan yang sama dengan duduk tegak • Merupakan posisi yang mudah jika berada di tempat tidur
Duduk di toilet atau commode	• Memiliki keuntungan yang sama dengan duduk tegak • Dapat membantu merelaksasikan perineum untuk mengejan secara efektif
Bergoyang di kursi	• Memiliki keuntungan yang sama dengan posisi duduk tegak • Dapat membantu mempercepat persalinan (gerakan mengayun)
Duduk, mencondongkan tubuh ke depan dengan dukungan	• Memiliki keuntungan yang sama dengan duduk tegak • Merupakan posisi yang baik untuk memijat punggung
Dengan posisi merangkak, bertumpu pada tangan dan lutut	• Membantu meredakan sakit punggung • Membantu rotasi bayi pada posisi posterior • Memungkinkan gerakan panggul dan gerakan tubuh • Mengurangi tekanan pada wasir • Memungkinkan pemeriksaan vagina • Terkadang lebih disukai sebagai posisi mengejan oleh wanita yang mengalami nyeri punggung
Berlutut, mencondongkan tubuh ke depan dengan dukungan di kursi	• Memiliki keuntungan yang sama dengan posisi merangkak • Mengurangi ketegangan pada pergelangan tangan dan tangan
Berbaring Miring (Side Lying	• Merupakan posisi yang sangat baik untuk beristirahat dan nyaman untuk berbagai jenis intervensi medis • Membantu menurunkan tekanan darah tinggi

	• Dapat mempercepat kemajuan persalinan jika dilakukan secara bergantian dengan berjalan • Berguna untuk memperlambat tahap kedua yang sangat cepat • Mengurangi tekanan pada wasir • Memfasilitasi relaksasi di antara kontraksi
Squatting/ Jongkok	• • Dapat meredakan sakit punggung • • Memanfaatkan gravitasi • Memerlukan tenaga lebih sedikit untuk mengejan • Memperlebar saluran panggul • Dapat membantu janin berputar dan bergerak turun saat persalinan sulit • Membantu jika ibu tidak merasa ingin mengejan • Memberikan kebebasan untuk menggeser berat badan demi kenyamanan • Memberikan keuntungan saat mengejan, karena tubuh bagian atas menekan bagian atas rahim
Squat dengan dukungan (bersandar pada pasangan, yang menopang wanita di bawah lengan dan menahan seluruh berat wanita; berdiri di antara kontraksi)	• Membutuhkan kekuatan yang besar pada pasangan • Memperpanjang batang tubuh, sehingga memberikan lebih banyak ruang bagi janin untuk bermanuver ke posisi • Membiarkan gravitasi membantu
Menggantung (pasangan duduk tinggi di tempat tidur atau meja dengan kaki disangga kursi atau sandaran kaki dan paha terbuka; wanita bersandar di antara kaki pasangan, meletakkan lengan tertekuk di atas paha pasangan; pasangan mencengkeram sisi dengan pahanya; wanita menurunkan dirinya dan membiarkan pasangan menopang seluruh berat tubuhnya; berdiri di antara kontraksi)	• Memiliki keuntungan yang sama dengan squat dengan dukungan • Membutuhkan lebih sedikit kekuatan fisik dari pasangan

Sources: Albers, 2007; Armstrong & Feldman, 2007; Koenig, 2007; Walsh, 2007.

2. Pereda Nyeri Farmakologis

Pereda nyeri farmakologis selama persalinan meliputi analgesia sistemik dan anestesi regional atau lokal. Analgesia sistemik dan analgesia/anestesi regional telah menjadi kurang umum, sementara teknik analgesia/anestesi neuraksial yang lebih baru yang melibatkan blokade motorik minimal telah menjadi lebih populer. Analgesia/anestesi neuraksial adalah pemberian agen analgesik (opioid) atau anestesi (obat yang mampu menyebabkan hilangnya sensasi di suatu area tubuh), baik secara terus-menerus atau terputus-putus, ke dalam ruang epidural atau intratekal untuk menghilangkan nyeri. Analgesia epidural dosis rendah dan dosis sangat rendah, analgesia spinal, dan analgesia spinal-epidural gabungan telah menggantikan epidural tradisional untuk persalinan (Kuczkowski, 2007). Pergeseran dalam manajemen nyeri ini memungkinkan seorang wanita untuk menjadi partisipan aktif dalam persalinan.

a. Analgesia Sistemik

Analgesia sistemik melibatkan penggunaan satu atau lebih obat yang diberikan secara oral, intramuskular, atau intravena; obat-obatan tersebut didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Bergantung pada metode pemberian yang digunakan, efek terapeutik penghilang rasa sakit dapat terjadi dalam hitungan menit dan berlangsung selama beberapa jam. Komplikasi terpenting yang terkait dengan penggunaan obat golongan ini adalah depresi pernapasan. Oleh karena itu, wanita yang diberikan obat-obatan ini memerlukan pemantauan yang cermat. Opioid yang diberikan mendekati waktu kelahiran dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat pada bayi baru lahir, sehingga memerlukan pemberian nalokson (Narcan) untuk membalikkan efek depresi opioid.

Beberapa kategori obat dapat digunakan untuk analgesia sistemik:

- 1) Opioid, seperti butorphanol (Stadol), nalbuphine (Nubain), meperidine (Demerol), atau fentanyl (Sublimaze)
- 2) Ataractics, seperti hydroxyzine (Vistaril) atau promethazine (Phenergan)
- 3) Benzodiazepines, seperti diazepam (Valium) atau midazolam (Versed)
- 4) Barbiturat, seperti secobarbital (Seconal) atau pentobarbital (Nembutal)

b. Analgesia/Anestesi Regional

Analgesia/anestesi regional memberikan penghilang rasa sakit tanpa kehilangan kesadaran. Ini melibatkan penggunaan agen anestesi lokal, dengan atau tanpa opioid tambahan, untuk menghilangkan rasa sakit atau mati rasa melalui efek obat pada sumsum tulang belakang dan akar saraf. Analgesia regional obstetrik umumnya mengacu pada hilangnya sebagian atau seluruh sensasi nyeri di bawah level T8 hingga T10 sumsum tulang belakang (Edmonds,

2007). Rute untuk menghilangkan rasa sakit regional meliputi blok epidural, blok spinal-epidural gabungan, infiltrasi lokal, blok pudendal, dan analgesia/anestesi intratekal (spinal). Rute lokal dan pudendal digunakan selama persalinan untuk episiotomi; rute epidural dan intratekal digunakan untuk menghilangkan rasa sakit selama persalinan aktif dan kelahiran. Keuntungan utama dari teknik manajemen nyeri regional adalah bahwa wanita dapat berpartisipasi dalam proses persalinan dan tetap dapat mengendalikan nyeri dengan baik.

Epidural dikontraindikasikan bagi wanita dengan riwayat operasi tulang belakang atau kelainan tulang belakang, cacat koagulasi, infeksi, dan hipovolemia. Epidural juga dikontraindikasikan bagi wanita yang menerima terapi antikoagulasi. Komplikasi meliputi mual dan muntah, hipotensi, demam, pruritus, injeksi intravaskular, dan depresi pernapasan. Efek pada janin selama persalinan meliputi gawat janin akibat hipotensi ibu (Bagwell, 2007). Memastikan bahwa wanita menghindari posisi terlentang setelah kateter epidural dipasang akan membantu meminimalkan hipotensi.



FIGURE 14.11 Epidural catheter insertion. (A) A needle is inserted into the epidural space. (B) A catheter is threaded into the epidural space; the needle is then removed. The catheter allows medication to be administered intermittently or continuously to relieve pain during labor and childbirth.

Gambar 5.16: Pemasangan Kateter Epidural

I. Simpulan

Persalinan normal merupakan proses kelahiran alami yang berlangsung tanpa komplikasi pada ibu maupun bayi, ditandai oleh kontraksi rahim yang progresif, pembukaan serviks yang teratur, dan posisi kepala bayi yang optimal untuk lahir. Proses persalinan terdiri dari empat tahap utama yaitu kala pembukaan (kala I), kala pengeluaran (kala II), kala plasenta (kala III), dan stabilisasi postpartum (kala IV).

Setiap tahap memiliki karakteristik khusus dan memerlukan perhatian serta manajemen yang tepat oleh tenaga kesehatan.

Permulaan persalinan dipengaruhi oleh faktor hormonal, termasuk penurunan progesteron dan peningkatan oksitosin serta prostaglandin. Identifikasi tanda-tanda persalinan yang sebenarnya versus palsu penting untuk menentukan waktu yang tepat bagi ibu untuk mendapatkan perawatan medis.

Proses persalinan dipengaruhi oleh faktor-faktor utama yang dikenal sebagai "10 P", termasuk jalan lahir (passageway), janin dan plasenta (passenger), kekuatan kontraksi (powers), posisi ibu, respons psikologis ibu, filosofi persalinan, dukungan mitra, kesabaran, persiapan pasien, dan manajemen nyeri. Setiap faktor ini secara signifikan menentukan keberhasilan persalinan.

Manajemen nyeri dalam persalinan melibatkan metode nonfarmakologis seperti dukungan emosional, hidroterapi, teknik pernapasan, serta metode farmakologis seperti analgesia sistemik dan anestesi regional. Pemilihan metode ini bergantung pada kebutuhan individu ibu, kondisi medis, serta preferensi pribadi, dengan tujuan memastikan persalinan berjalan aman, nyaman, dan positif bagi ibu dan bayi.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tahap persalinan berjalan dengan aman, mulai dari pengawasan intensif selama kontraksi dan pembukaan, dukungan selama pengeluaran bayi, manajemen aktif plasenta untuk mencegah perdarahan postpartum, hingga pemantauan ketat dalam tahap stabilisasi postpartum. Dengan demikian, persalinan normal yang didukung oleh manajemen yang tepat memberikan hasil optimal bagi kesehatan ibu dan bayi.

J. Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). ***Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal***. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2014). ***Panduan Praktis Pelayanan Persalinan Normal***. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Bobak, Lowdermilk, Jensen. 2016. ***Buku Ajar Keperawatan Maternitas***. Jakarta: EGG.
- Susan Scott Ricci, Second Edition. ***Essentials of Maternity, Newborn and Womens Health Nursing***, Lippincot Williams and Wilkins, America Washington
- Lois White, gena Duncan, Wedndy Baumle, 2011. ***Fondation of Maternal Nursing***. Third edition, Chengage learning, Australia.

- Yulizawati, Insani AA, ElSinta L, Andriani F, 2019. ***Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Persalinan***, Indomedia Pustaka, Sidoarjo
- Ari Sulistyawati (2013) ***Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan***, Salemba Medika
- Reeder., Martin S.J., & Koniak-Griffin, D, (2011) ***Keperawatan Maternitas, Kesehatan Wanita, Bayi, Wanita dan Keluarga*** (Afiyanti, dkk. Penerjemah). Jakarta: EGC
- Kemenkes RI, WHO, POGI, IBI, 2013. ***Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas kesehatan Dasar dan Rujukan***. UNFPA, Unicef, USAID, Jakarta
- Ratu Ludji, ID, ***Manajemen laktasi (Strategi dan teknik menyusui untuk Mengoptimalkan Manajemen Laktasi)***, Media Sains, Bandung.
- Kemenkes RI, 2011. ***Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial***, Kemenkes RI. Jakarta.
- World Health Organization (WHO). "Essential newborn care." (2018). WHO Newborn Health.
- World Health Organization (WHO). "Pocket book of hospital care for children." (2013). WHO Hospital Care ***Wanita, Bayi, Wanita dan Keluarga*** (Afiyanti, dkk. Penerjemah). Jakarta: EGC

PROFIL PENULIS



Rigoan Malawat. Lahir di Kaitetu 29 Juli 1970. Pendidikan tinggi dimulai dari sarjana pendidikan S1 Keperawatan di Program Studi Ilmu Keperawatan pada Universitas Padjajaran Bandung lulus pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro Semarang dan lulus pada tahun 2011. Mulai bekerja Pada Akademi Perawat (AKPER) pada tahun 2001, yang sekarang dikenal dengan Program Studi Keperawatan Masohi Poltekkes Kemenkes Maluku. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000. Saat ini penulis bekerja pada Poltekkes Kemenkes Maluku Jurusan Program Studi Keperawatan Masohi, mengampu mata kuliah Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Keperawatan Maternitas, Pendidikan Budaya Anti Korupsi dan Kewirausahaan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : rigoan_malawat@yahoo.com

Motto: "Kesabaran adalah kunci kebahagiaan"



Yuyun Setyorini, S.Kp.,Ners.,M.Kep. Lahir di Surakarta, 4 Juni 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Sarjana Keperawatan Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2001, Program Profesi Ners Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2002 dan menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2008. Penulis aktif sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta sejak tahun 2001. Aktif dalam penerapan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, juga sebagai penulis buku. Korespondensi dapat melalui Alamat email: setyorini.yuyun@gmail.com

Motto : *"Success needs a process"*

PROFIL PENULIS



Yuanita Ani Susilowati, M.Kep., Ns.Sp. Kep.Mat. Lahir di Klaten Jawa Tengah pada tanggal 27 Juli 1967. Karir sebagai dosen diawali pada tahun 2010. Ani itu sebutan akrabnya kuliah keperawatan pertama di AKPER St.Carolus Jakarta. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di raih di UNPAD Bandung pada tahun 2003. Gelar Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Maternitas diraih di Universitas Indonesia pada tahun 2015. Tamat Akper mendapat tugas mengajar di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di RS Lela, Maumere-NTT selama kurang lebih dua tahun. Meniti karir sebagai perawat di RS Santo Yusup Bandung pada tahun 1992 sampai dengan 2010, selama rentang waktu tersebut bertugas di bangsal Bedah, bangsal penyakit dalam, bangsal kebidanan dan terakhir di Unit Gawat Darurat. Pada tahun 2010, Ketua Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus (PPSB) memindah tugaskan di Pendidikan STIKes Santo Borromeus. Riwayat karir/ manajerial sebagai kepala bagian bangsal bedah sebagai koordinator pelayanan keperawatan di Unit Gawat Darurat, dan sebagai Pembantu Ketua III bidang Kemahasiswaan, th 2023 sampai saat ini sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Kreatif Universitas Santo Borromeus. Penulis berkontribusi dalam book chapter lainnya dengan judul: Buku Ajar KDM, Buku Ajar KDK, Buku Ajar Keperawatan Maternitas, Buku Ajar Keperawatan Paliatif, Buku Ajar Falsafah dan Teori Keperawatan, dll. Penulis dapat dihubungi melalui email yuanitaani@yahoo.co.id



Apri Nur Wulandari, S.Kep.,Ns.,M.Kep. Lulus S1 Keperawatan dan Program Profesi Ners pada tahun 2014, dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017, dengan minat Keperawatan Maternitas. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015-2023 sebagai dosen tetap di STIKES Notokusumo Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja di Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Diponegoro sebagai dosen tetap

dengan mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas. Minat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup: *nursing science*, *maternity nursing*, *reproductive health*, dan *social support*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wulandari.aprinur@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes. Lahir di Belu 18 Juni 1968 Jakarta, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu: Akademi Keperawatan Denpasar Tamat Tahun 1989, Sebagai tenaga sukarela di RSU Atambua dan Dinas Kesehatan kabupaten Belu, Menjadi PNS bekerja di Puskesmas Oesao sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikan di PSIK-FKUI Universitas Indonesia Jakarta, tamat Tahun 1997. Bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, kemudian pada tahun

1998 menjadi Dosen pada AKPER MSA Kupang. (Saat ini Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang). Melanjutkan pendidikan di S2 Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Epidemiologi, Tamat Tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan Doktor di Bidang Kesehatan Masyarakat (kesehatan Ibu dan Anak/KIA) tahun 2013. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Poltekkes kemenkes Kupang, Dosen tidak tetap S2 Pasca Sarjana di universitas nusa cendana (Undana Kupang), Dosen tamu di Universitas Da Paz Timor Leste, *Tim Expert* COVID 19, Provinsi NTT, Tim Pakar IAKMI Pengda NTT, Fasilitator Nasional MTBS, Konsultan KIA serta pencegahan stunting, Konsultan pembuatan PERDA Sistem Kesehatan daerah (SKD), Pendamping Teknis kampanye Immunisasi *Measles Rubella* (MR) dan Filariasis kerjasama dengan WHO, Kemenkes, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Daerah/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur, LSM Wijaya Kusuma Kupang, Penanggung Jawab Teknis (PJT) Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes) tahun 2017 dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Mengasuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian/ Riset Keperawatan, Biostatistik, Epidemiologi, Keperawatan maternitas, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Manajemen Penyakit infeksi/Tropis, HIV AIDS, Pemberdayaan Masyarakat, kebijakan Kesehatan Nasional, Keperawatan Keluarga, serta Mata Kuliah penunjang lainnya: Etika Keperawatan, Komunikasi Keperawatan, dan caring dalam keperawatan. Aktif Menulis Buku ajar, book chapter dan Monograf antara lain Asuhan Keperawatan Maternitas: Kehamilan Risiko Tinggi dan Asuhan Keperawatan Maternitas Pasca Partum, Manajemen Laktasi, Epidemiologi, Monograf *"Social Ecological Model of Health Behavior Ina Djayaku Abadi* untuk Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), serta berbagai BukuAjar dan Book chapter lainnya. Menulis artikel di Jurnal dan Koran, menjadi nara sumber di radio swasta, RRI dan TVRI, menulis *Policy Brief* dan advokasi kebijakan kesehatan di Provinsi NTT terkait Penyakit Menular dan Tidak menular dalam rangka

pencapaian target RPJMN dan RPJMD, penurunan angka kematian ibu (AKI), Angka kematian Bayi (AKB), Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting serta perumusan RAD Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Reviewer Nasional Penelitian/kajian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Poltekkes Kemenkes se Indonesia, reviewer *Ethical Clearance*, Asesor Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Beban Kerja Dosen (BKD). Aktif dalam kajian dan pengabdian masyarakat dosen di Poltekkes kemenkes Kupang maupun dengan mitra perguruan tinggi negeri lainnya, swasta dan Filantropi. Demikian sekilas info. Selamat membaca. Semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta menjadi input dan inovasi untuk kajian dan pengabdian masyarakat ke depan. Email: hottaru19@gmail.com

Motto: "Hidup untuk bekerja, bermanfaat bagi orang lain dan bersyukur"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Perawatan Kehamilan dan Persalinan merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas berbagai aspek penting dalam asuhan keperawatan maternitas. Dimulai dari urgensi pemeriksaan kehamilan secara rutin, pembaca akan dibimbing memahami manfaat dan jenis pelayanan antenatal care (ANC), serta bagaimana kepatuhan ibu hamil dalam menjalani pemeriksaan berdampak pada keselamatan ibu dan janin. Pengetahuan dasar ini menjadi pondasi penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang terarah dan berkualitas.

Topik dilanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai perawatan persalinan normal dan teknik manajemen rasa sakit. Buku ini menyajikan panduan praktis mulai dari teori dasar persalinan hingga manajemen nyeri dan pencegahan komplikasi. Tidak hanya itu, perawatan khusus untuk kasus kelahiran prematur juga dibahas secara komprehensif—mulai dari identifikasi faktor risiko, strategi pencegahan, hingga pendekatan perawatan untuk bayi prematur yang membutuhkan perhatian khusus di awal kehidupannya.

Sebagai pelengkap, buku ini juga menyoroti pentingnya aspek kesehatan mental ibu selama masa persalinan dan periode perinatal. Dukungan psikososial dan kebijakan pemerintah yang relevan dibahas sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan ibu. Keseluruhan isi buku ini disusun oleh para akademisi dan praktisi berpengalaman, menjadikannya sumber yang relevan dan aplikatif bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kesehatan yang berkecimpung di bidang keperawatan maternitas.

Buku Bunga Rampai Perawatan Kehamilan dan Persalinan merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas berbagai aspek penting dalam asuhan keperawatan maternitas. Dimulai dari urgensi pemeriksaan kehamilan secara rutin, pembaca akan dibimbing memahami manfaat dan jenis pelayanan antenatal care (ANC), serta bagaimana kepatuhan ibu hamil dalam menjalani pemeriksaan berdampak pada keselamatan ibu dan janin. Pengetahuan dasar ini menjadi pondasi penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang terarah dan berkualitas.

Topik dilanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai perawatan persalinan normal dan teknik manajemen rasa sakit.

Buku ini menyajikan panduan praktis mulai dari teori dasar persalinan hingga manajemen nyeri dan pencegahan komplikasi. Tidak hanya itu, perawatan khusus untuk kasus kelahiran prematur juga dibahas secara komprehensif mulai dari identifikasi faktor risiko, strategi pencegahan, hingga pendekatan perawatan untuk bayi prematur yang membutuhkan perhatian khusus di awal kehidupannya.

Sebagai pelengkap, buku ini juga menyoroti pentingnya aspek kesehatan mental ibu selama masa persalinan dan periode perinatal. Dukungan psikososial dan kebijakan pemerintah yang relevan dibahas sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan ibu. Keseluruhan isi buku ini disusun oleh para akademisi dan praktisi berpengalaman, menjadikannya sumber yang relevan dan aplikatif bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kesehatan yang berkecimpung di bidang keperawatan maternitas.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-54-1



9

786347

219541

